

Buku Referensi

KESELAMATAN PASIEN DAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam Praktik Keperawatan Di Indonesia

Elly Marce Titihalawa • Tanti Marjiana • Yulianti
Anastasia Hardyati • Rahmi Inayati
Sri Rusmini



BUKU REFERENSI: KESELAMATAN PASIEN DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN DI INDONESIA

Penulis:

Ns. Elly Marce Titihalawa, M.Kep.

Ns. Tanti Marjiana, S.Kep., M.Kep., FISQua., FIHFAA., FRSPH

Yuliati, SKp., MM., M.Kep.

Ns. Anastasia Hardyati., MKep., Sp.KMB

Dr. Rahmi Inayati, SKM., M.Kes.

Sri Rusmini, S.Kep., Ners., M.Kep., MM., FISQUa.



**Optimal
Untuk
Negeri**

Buku Referensi: Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko dalam Praktik Keperawatan Di Indonesia

Penulis:

Ns. Elly Marce Titihalawa, M.Kep.

Ns. Tanti Marjiana, S.Kep., M.Kep., FISQua., FIHFAA., FRSPH

Yuliati, SKp., MM., M.Kep.

Ns. Anastasia Hardyati, M.Kep., Sp.KMB

Dr. Rahmi Inayati, SKM., M.Kes.

Sri Rusmini, S.Kep., Ners., M.Kep., MM., FISQua.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7756-06-0

Cetakan Pertama: Mei, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku referensi “Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko dalam Praktik Keperawatan di Indonesia” ini dapat disusun sebagai salah satu kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berpusat pada pasien.

Keselamatan pasien merupakan aspek fundamental dalam pelayanan kesehatan. Dalam praktik keperawatan, perawat memiliki peran yang sangat strategis karena berada pada garis terdepan pelayanan dan berinteraksi langsung dengan pasien selama proses asuhan berlangsung. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep keselamatan pasien, budaya keselamatan, identifikasi insiden, manajemen risiko, serta sistem pelaporan menjadi kebutuhan penting bagi setiap perawat, baik di rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Buku ini disusun untuk memberikan landasan teoritis dan praktis mengenai berbagai aspek penting dalam keselamatan pasien dan manajemen risiko keperawatan. Pembahasan diawali dengan konsep dan budaya keselamatan pasien, yang menjadi dasar dalam membangun kesadaran kolektif bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Selanjutnya, buku ini menguraikan identifikasi dan klasifikasi insiden keselamatan pasien, sehingga pembaca mampu memahami jenis-jenis insiden, faktor penyebab, serta pentingnya deteksi dini dalam mencegah kejadian yang tidak diharapkan.

Selain itu, buku ini membahas manajemen risiko dalam praktik keperawatan sebagai pendekatan sistematis untuk mengenali, menilai, mengendalikan, dan mengevaluasi risiko yang dapat mengancam keselamatan pasien. Topik khusus mengenai debridement, indikasi, teknik, dan peran perawat turut disajikan sebagai bagian dari praktik klinis yang membutuhkan ketelitian, kompetensi, serta kepatuhan terhadap prinsip keselamatan. Buku ini juga menekankan peran perawat dalam pelaporan insiden, karena pelaporan yang jujur, tepat, dan tidak menyalahkan merupakan fondasi penting dalam pembelajaran organisasi.

Pada bagian akhir, pembaca diajak untuk memahami berbagai strategi membangun budaya safety di fasilitas kesehatan, termasuk komunikasi efektif, kepemimpinan, kerja tim, pembelajaran dari insiden, serta penguatan sistem yang mendukung pelayanan aman. Dengan demikian, buku ini diharapkan tidak hanya menjadi sumber bacaan akademik, tetapi juga menjadi panduan aplikatif bagi perawat,

mahasiswa keperawatan, pendidik, pengelola fasilitas kesehatan, dan seluruh pihak yang berkomitmen terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, memperkaya wawasan, serta mendorong terbentuknya praktik keperawatan yang lebih aman, profesional, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Mei 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KONSEP DAN BUDAYA KESELAMATAN PASIEN	1
A. Pendahuluan	1
B. Kerja Sama/ Kolaborasi Tim dalam Satu Unit	2
C. Dukungan Supervisor/Pemimpin klinis untuk Keselamatan Pasien	4
D. Pembelajaran Organisasi yang Berfokus pada Perbaikan Sistem	4
E. Respon tidak Menyalahkan terhadap Kesalahan	5
F. Umpan Balik dan Komunikasi terkait Kesalahan	7
G. Komunikasi Terbuka pada Staf untuk Bebas Berbicara	8
H. Kecukupan Staf untuk Beban kerja	8
I. Kerjasama/Kolaborasi Tim antar Unit	9
J. Prosedur Serah Terima Pasien yang Aman	10
K. Frekuensi Pelaporan Insiden	11
L. Persepsi Staf terhadap Keselamatan Pasien	12
M. Penutup	13
Referensi	14
Glosarium	17
 BAB 2 IDENTIFIKASI DAN KLASIFIKASI INSIDEN KESELAMATAN PASIEN .19	
A. Pendahuluan	19
B. (ISI)Identifikasi Insiden Keselamatan Pasien	20
C. Klasifikasi Insiden Keselamatan Pasien	23
D. Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	27
E. Analisis Insiden Keselamatan Pasien	30
F. Tindak Lanjut, Pembelajaran, dan Pencegahan Insiden	33
G. Arah Kebijakan dan Tantangan Masa Depan (Policy Direction and Future Challenges in Patient Safety)	36
H. Penutup	39
Referensi	40
Glosarium	42

BAB 3 MANAJEMEN RISIKO DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN.....45

A. Pendahuluan.....	45
B. Konsep Dasar Manajemen Risiko.....	47
C. Kerangka Teori Manajemen Risiko dalam Keperawatan.....	61
D. Jenis Risiko dalam Praktik Keperawatan.....	65
E. Proses Manajemen Risiko dalam Praktik Keperawatan.....	71
F. Implementasi Manajemen Risiko dalam Asuhan Keperawatan	76
G. Peran dan Tanggung Jawab Perawat dalam Manajemen Risiko	79
H. Manajemen Risiko dalam Perspektif Akreditasi dan Regulasi	82
I. Tantangan dan Permasalahan dalam Implementasi Manajemen Risiko.....	85
J. Strategi Peningkatan Manajemen Risiko dalam Keperawatan	87
K. Studi Kasus dan Analisis Risiko dalam Praktik Keperawatan.....	90
L. Penutup	92
Referensi	95
Glosarium.....	97

BAB 4 DEBRIDEMENT, INDIKASI, TEKNIK DAN PERAN PERAWAT100

A. Pendahuluan.....	100
B. Konsep Komunikasi Efektif dalam Praktik Keperawatan.....	101
C. Jenis Komunikasi dalam Pelayanan Keperawatan	102
D. Hambatan Komunikasi di Lingkungan Pelayanan Kesehatan.....	103
E. Dampak Miskomunikasi terhadap Keselamatan Pasien.....	104
F. Standar Nasional dan Regulasi di Indonesia dalam Komunikasi Efektif untuk Keselamatan Pasien.....	104
G. Standar Komisi Akreditasi Rumah Sakit terkait Komunikasi.....	106
H. Konsep SBAR sebagai Metode Komunikasi Terstruktur.....	107
I. Penerapan SBAR dalam Praktik Keperawatan	109
J. SBAR dalam Pencegahan Error Keperawatan	112
K. Strategi Implementasi SBAR di Rumah Sakit Indonesia	114
L. Penutup	117
Referensi	119
Glosarium.....	122

BAB 5 PERAN PERAWAT DALAM PELAPORAN INSIDEN.....	126
A. Pendahuluan.....	126
B. Insiden Keselamatan.....	126
C. Peran dan Tanggung Jawab Perawat	127
D. Prosedur Pelaporan.....	131
E. Penutup	133
Referensi	134
 BAB 6 STRATEGI MEMBANGUN BUDAYA SAFETY DI FASILITAS KESEHATAN.....	135
A. Pendahuluan.....	135
B. Strategi Membangun Budaya Keselamatan	136
C. Peran Kepemimpinan dalam Mendorong Budaya Keselamatan	137
D. Penguatan Kebijakan Dalam Sistem Pelayanan	138
E. Peningkatan Kompetensi dan Kepatuhan Tenaga Kesehatan.....	139
F. Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Insiden.....	140
G. Implementasi Just Culture Dalam Pelayanan Kesehatan.....	141
H. Penguatan Komunikasi Interpersonal dan Evaluasi Berkelanjutan Dalam Budaya Keselamatan.....	141
I. Penutup	142
Referensi	144
Glosarium.....	146
 PROFIL PENULIS.....	148

BAB 1

KONSEP DAN BUDAYA KESELAMATAN PASIEN

A. Pendahuluan

Konsep budaya keselamatan pasien merupakan elemen fundamental dalam kerangka kerja organisasi layanan kesehatan, yang menempatkan upaya meminimalkan risiko dan meningkatkan kualitas perawatan sebagai prioritas utama di seluruh spektrum pelayanan medis (Mistri et al., 2023). Mengingat pentingnya dimensi budaya ini, organisasi memerlukan metode evaluasi yang terstruktur untuk memantau komitmen kolektif terhadap keamanan. Untuk mengukur dan memantau kondisi budaya ini, instrumen standar seperti *Hospital Survey of Patient Safety Culture* (HSOPSC) banyak digunakan karena kemampuannya menangkap persepsi staf mengenai lingkungan kerja mereka (Knowles, 2024). Penggunaan instrumen terstandarisasi ini sangat penting bagi manajemen untuk mengidentifikasi kesenjangan spesifik yang ada antara kebijakan formal dan realitas praktik di lapangan.

Keselamatan pasien didefinisikan sebagai upaya sistematis yang ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya efek samping yang terkait dengan intervensi medis, menjadikannya aspek terpenting dalam kerangka perawatan kontemporer. Prioritas fundamental ini tidak hanya bersifat klinis tetapi juga telah terlembaga secara regulasi di berbagai yurisdiksi. Berbagai sistem akreditasi perawatan kesehatan telah secara eksplisit mengintegrasikan aspek keselamatan pasien ke dalam daftar standar wajib yang harus dipenuhi oleh fasilitas kesehatan. Pemenuhan standar ini secara ketat diverifikasi melalui survei berkala, memastikan bahwa rumah sakit secara konsisten mengevaluasi dan meningkatkan praktik klinis mereka (Tadia et al., 2025). Oleh karena itu, kepatuhan terhadap standar keselamatan menjadi indikator utama kualitas institusional.

Meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam praktik medis modern, tantangan substansial masih menghadang dalam menjaga keamanan pasien di lingkungan klinis. Data empiris menunjukkan bahwa kejadian buruk (*adverse events/AEs*) secara konsisten memengaruhi sekitar 10% pasien yang menjalani rawat inap, mengindikasikan adanya kerentanan sistemik yang berkelanjutan. Konsekuensi dari praktik kesehatan yang tidak aman ini sangat luas dampaknya, mencakup peningkatan signifikan dalam biaya operasional rumah sakit, risiko cedera permanen pada pasien, hingga peningkatan angka mortalitas yang seharusnya dapat dicegah.

(Hafezi et al., 2022; Vikan et al., 2023). Oleh karena itu, kompetensi klinis dan profesionalisme perawat memegang peranan yang sangat krusial dalam menjamin bahwa setiap layanan yang diberikan selalu memenuhi standar keamanan dan kualitas tertinggi yang telah ditetapkan.

Tujuan strategis utama dalam upaya mengatasi risiko yang melekat pada perawatan kesehatan adalah pembentukan sebuah budaya keselamatan pasien yang positif. Budaya ini secara definitif diwujudkan melalui lingkungan kerja yang suportif, di mana tanggung jawab terhadap keamanan dibagi secara merata di seluruh tingkatan organisasi. Dalam lingkungan kerja yang sangat kondusif, seluruh tim perawatan kesehatan wajib menunjukkan tekad bulat bersama terhadap prioritas keselamatan pasien. Lebih lanjut, staf harus merasa diberdayakan dan aman untuk secara proaktif mengidentifikasi serta melaporkan potensi bahaya yang mereka deteksi dalam alur kerja sehari-hari tanpa takut akan sanksi (Zaitoun et al., 2023).

Budaya keselamatan pasien merupakan prasyarat fundamental sistemik yang menentukan keberhasilan implementasi standar perawatan aman di fasilitas kesehatan. Pencapaian budaya ini memerlukan pengukuran yang berkelanjutan melalui instrumen terstandarisasi serta komitmen aktif dan nyata dari seluruh personel medis yang terlibat. Komponen kunci dalam menjaga momentum positif ini adalah fokus yang tajam pada pemberdayaan staf untuk melakukan pelaporan insiden dan near miss. Upaya pelaporan yang transparan ini merupakan mekanisme utama dalam memitigasi dampak negatif jangka panjang dari kejadian buruk yang masih kerap terjadi di lingkungan rumah sakit

B. Kerja Sama/ Kolaborasi Tim dalam Satu Unit

Kolaborasi tim yang efektif dalam satu unit merupakan landasan utama bagi terciptanya lingkungan perawatan kesehatan yang aman dan berkualitas tinggi. Dukungan dari kepemimpinan, fondasi perilaku tim yang positif, dan budaya organisasi yang adil bekerja sama untuk memitigasi risiko insiden medis. Fokus pada interaksi unit yang kuat ini tidak hanya melindungi pasien tetapi juga mendukung ketahanan dan kesejahteraan staf klinis.

Kerja tim diakui sebagai salah satu kekuatan paling vital dalam praktik klinis modern yang berorientasi pada keselamatan. Dimensi dukungan yang diberikan oleh manajer dan kepala unit memainkan peran sentral dalam memfasilitasi kolaborasi yang efektif di tingkat operasional. Para profesional kesehatan secara signifikan menghargai ketika saran yang mereka ajukan mengenai isu keselamatan pasien benar-benar dipertimbangkan oleh manajemen. Lebih lanjut, dukungan ini terwujud ketika pimpinan mengambil langkah-langkah konkret untuk

menyelesaikan masalah yang teridentifikasi dalam alur kerja sehari-hari (Segura-García et al., 2023). Kepemimpinan yang responsif terhadap masukan staf memperkuat rasa kepemilikan tim terhadap standar keselamatan.

Kerja tim yang solid dan komunikasi yang efektif merupakan prasyarat fundamental demi keandalan layanan kesehatan. Keberhasilan kolaborasi ini sangat bergantung pada terciptanya lingkungan yang menumbuhkan rasa saling menghormati di antara semua anggota tim. Selain itu, kemampuan tim untuk secara kolektif terlibat dalam pemecahan masalah dan berbagi ide-ide inovatif adalah hal yang sangat esensial. Tanpa adanya elemen-elemen perilaku penting ini, sangat sulit bagi tim untuk memberikan perawatan yang aman dan dapat diandalkan kepada pasien secara konsisten (Fuchshuber & Greif, 2022). Kualitas interaksi internal secara langsung berkorelasi dengan minimnya potensi kesalahan klinis.

Peningkatan kerja tim dalam unit perawatan terbukti memberikan manfaat signifikan terhadap lingkungan kerja secara keseluruhan, khususnya dalam hal mengurangi tingkat kelelahan kerja. Hubungan antara kualitas kerja tim, terutama yang terjalin erat di dalam unit, dan penurunan prevalensi kelelahan kerja (*burnout*) telah teridentifikasi secara luas di berbagai sektor rumah sakit. Temuan ini berlaku bahkan di area yang secara subjektif melaporkan tingkat kekacauan tempat kerja yang sangat tinggi, menunjukkan bahwa kohesi tim dapat berfungsi sebagai penyangga stres. Oleh karena itu, penerapan intervensi tempat kerja yang secara spesifik berfokus pada peningkatan kolaborasi tim adalah strategi yang efektif untuk mendukung keberlanjutan tenaga kerja klinis (Vail et al., 2023).

Untuk mencapai tingkat keselamatan pasien yang tinggi, organisasi perlu memastikan bahwa budaya mereka dibangun di atas pilar kepercayaan dan keadilan prosedural. Dalam kerangka budaya yang adil ini, kejadian buruk atau kesalahan tidak dilihat sebagai momen untuk mencari kesalahan individu, melainkan sebagai peluang berharga untuk memahami faktor penyebab sistemik. Perubahan dari budaya menyalahkan menuju budaya pembelajaran merupakan transformasi paradigma yang signifikan bagi banyak institusi kesehatan. Namun, pergeseran ini sangat krusial karena mendorong transparansi dan pelaporan terbuka yang diperlukan untuk perbaikan sistem berkelanjutan (Murray et al., 2023).

Kolaborasi tim dalam unit, didukung oleh kepemimpinan yang responsif dan budaya yang adil, menjadi penentu utama keberhasilan implementasi praktik keselamatan pasien. Ketika staf merasa dihargai dan aman untuk berkomunikasi, kualitas perawatan meningkat, sementara risiko kelelahan staf dapat dikelola secara lebih efektif. Budaya saling percaya ini adalah katalisator yang mengubah potensi kegagalan menjadi kesempatan belajar yang konstruktif.

C. Dukungan Supervisor/Pemimpin klinis untuk Keselamatan Pasien

Dukungan yang kuat dari supervisor dan pemimpin klinis merupakan pilar esensial dalam menanamkan budaya keselamatan pasien yang efektif di fasilitas layanan kesehatan. Salah satu kekuatan yang paling dihargai dalam lingkungan klinis adalah kerja tim yang solid, yang diperkuat ketika manajemen berperan aktif. Dimensi dukungan dari manajer dan kepala unit menyoroti bahwa para profesional kesehatan mempertimbangkan saran yang diterima dari staf dan secara nyata mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keselamatan pasien (Segura-García et al., 2023). Dukungan yang terlihat ini memastikan bahwa inisiatif keselamatan yang datang dari lini depan diakui dan ditindaklanjuti oleh kepemimpinan.

Peningkatan keselamatan pasien secara berkelanjutan memerlukan upaya organisasi untuk bertransformasi menjadi entitas dengan keandalan tinggi, di mana budaya organisasi didasarkan pada kepercayaan dan keadilan prosedural. Dalam lingkungan yang didominasi oleh kepercayaan ini, kejadian buruk diakui sebagai peluang berharga untuk memahami akar penyebab sistemik, alih-alih langsung mencari pihak yang patut disalahkan. Proses beralih dari budaya menyalahkan (*blame culture*) merupakan perubahan paradigma yang signifikan bagi banyak organisasi perawatan kesehatan, namun hal ini sangat penting untuk mendorong pelaporan terbuka dan perbaikan sistem yang berkelanjutan (Murray et al., 2023).

Dukungan supervisor dan budaya organisasi yang adil menciptakan ekosistem di mana kerja tim dapat berkembang dan staf merasa aman untuk melaporkan risiko. Kepemimpinan yang responsif dalam menanggapi masukan staf serta penekanan pada keadilan prosedural adalah kunci untuk memitigasi kejadian buruk dan mengurangi beban *burnout* pada profesional kesehatan. Budaya berbasis kepercayaan ini adalah landasan yang memungkinkan organisasi belajar secara efektif dari setiap insiden demi peningkatan kualitas perawatan secara sistematis.

D. Pembelajaran Organisasi yang Berfokus pada Perbaikan Sistem

Pendekatan komprehensif dalam meningkatkan keselamatan pasien menuntut organisasi layanan kesehatan untuk secara sadar mengadopsi budaya pembelajaran yang mendalam dan transparansi yang tinggi. Budaya ini memungkinkan institusi untuk secara efektif mengekstrak pelajaran berharga dari kesalahan manusia yang terjadi dalam kerangka sistem perawatan yang kompleks. Tujuan utama dari transformasi budaya ini adalah untuk secara konsisten memberikan perawatan pasien yang lebih aman dan memiliki kualitas yang terjamin tinggi. Dengan

demikian, pembelajaran organisasi menjadi motor penggerak utama dalam mitigasi risiko klinis.

Pembelajaran organisasi yang efektif memerlukan pergeseran paradigma dari fokus pada kesalahan individu menjadi analisis mendalam terhadap kegagalan sistemik. Ketika transparansi menjadi norma, staf merasa lebih aman untuk melaporkan *near miss* dan insiden tanpa perlu khawatir akan sanksi yang tidak proporsional. Analisis akar penyebab (*root cause analysis*) dari setiap kejadian buruk kemudian berfungsi sebagai mekanisme investigasi utama untuk memahami di mana letak kelemahan struktural dalam alur kerja. Proses ini mengubah kegagalan yang terjadi menjadi data yang dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan sistem yang berkelanjutan.

Organisasi yang berorientasi pada keandalan tinggi dapat memanfaatkan berbagai strategi dan metode berbasis bukti untuk menyebarkan pembelajaran yang telah diperoleh ke seluruh lapisan staf. Pemanfaatan sumber data yang beragam, termasuk laporan insiden internal dan data kinerja eksternal, sangat krusial untuk mengidentifikasi pola risiko yang berulang. Organisasi harus memastikan bahwa pengetahuan yang didapat dari analisis data tersebut disebarkan secara efektif melalui pelatihan dan komunikasi yang terstruktur. Semua upaya ini bertujuan untuk memperkuat komitmen inti organisasi terhadap prinsip penyembuhan tanpa membahayakan pasien (Carmack et al., 2024).

Implementasi budaya pembelajaran yang transparan merupakan investasi strategis bagi organisasi layanan kesehatan. Dengan berfokus pada pembelajaran sistemik dari kesalahan, institusi dapat secara proaktif memodifikasi proses kerja mereka. Hal ini memastikan bahwa setiap insiden, sekecil apa pun, berkontribusi pada peningkatan keamanan pasien secara agregat dan berkelanjutan..

E. Respon tidak Menyalahkan terhadap Kesalahan

Respons yang tidak menyalahkan terhadap kesalahan merupakan komponen krusial dalam membangun budaya keselamatan pasien yang kuat dan efektif di fasilitas layanan kesehatan. Pendekatan ini menggeser fokus dari penghukuman individu menjadi analisis sistemik kegagalan, yang didukung oleh kerja sama tim dan komunikasi terbuka. Budaya keadilan restoratif muncul sebagai kerangka kerja yang paling komprehensif untuk memastikan bahwa setiap insiden menghasilkan pembelajaran yang bermakna bagi seluruh organisasi.

Prevalensi kejadian buruk dalam layanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh budaya keselamatan pasien yang berlaku di suatu institusi. Salah satu komponen penting yang membentuk budaya ini adalah tingkat kerja sama yang baik, baik di dalam satu departemen maupun antar departemen rumah sakit secara keseluruhan

(Alkubati et al., 2024). Budaya keselamatan pasien yang lebih positif secara empiris terbukti berkorelasi dengan penurunan jumlah peristiwa sentinel yang terjadi dalam operasional. Oleh karena itu, respons yang tepat terhadap kesalahan harus terintegrasi dalam kerangka budaya yang secara aktif mendukung pelaporan tanpa rasa takut.

Untuk meminimalkan rasa takut staf dalam melaporkan peristiwa sentinel yang kritis, diperlukan perubahan budaya yang eksplisit dalam organisasi. Perubahan ini harus secara tegas mempromosikan budaya tanpa menyalahkan (*no-blame culture*) sebagai landasan utama interaksi staf. Selain itu, peningkatan kualitas kerja tim, efektivitas proses serah terima (*handoffs*), dan keterbukaan komunikasi adalah elemen pendukung yang esensial untuk keberhasilan ini. Langkah-langkah kolektif ini bertujuan untuk meningkatkan frekuensi pelaporan dan pada akhirnya meningkatkan keselamatan pasien secara keseluruhan (Binkheder et al., 2023). Tindakan ini mengalihkan perhatian dari menghukum individu menjadi memperbaiki proses yang cacat dalam sistem.

Kerangka kerja mutakhir dalam manajemen insiden adalah penerapan budaya keadilan restoratif dalam lingkungan perawatan kesehatan. Proses ini bersifat dinamis karena bertujuan untuk memahami seluruh komponen kesalahan medis, sambil secara simultan mengenali kegagalan sistem yang menyebabkan insiden tersebut. Keadilan restoratif menjadi unik karena kemampuannya untuk melihat keseluruhan kejadian secara holistik, alih-alih hanya berfokus pada aspek kerugian tunggal (Savage & Jamarik, 2024). Tujuannya adalah menyatukan investigasi sistemik, komunikasi yang transparan, dan dukungan khusus bagi korban kedua, menghindari penderitaan tambahan yang sering timbul dari budaya retributif. Memahami perbedaan antara pendekatan restoratif dan retributif memungkinkan organisasi mengevaluasi proses internal mereka dengan lebih baik dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan semua pihak yang terlibat.

Respon yang tidak menyalahkan adalah fondasi bagi transparansi dan pembelajaran organisasi yang berkelanjutan dalam konteks keselamatan pasien. Dengan mengadopsi prinsip keadilan restoratif, organisasi dapat memastikan bahwa setiap kesalahan dianalisis secara mendalam untuk perbaikan sistem, bukan untuk mencari kambing hitam. Hal ini menciptakan lingkungan yang aman bagi staf untuk berkontribusi aktif dalam upaya kolektif meningkatkan kualitas perawatan.

F. Umpan Balik dan Komunikasi terkait Kesalahan

Petugas kesehatan mengalami kekhawatiran mendalam setelah insiden kesalahan medis, sebuah kondisi yang dipicu oleh ketakutan terhadap penilaian publik dan profesional. Situasi ini memunculkan konsekuensi serius berupa ancaman nyata terhadap reputasi, potensi tuntutan hukum, dan risiko kehilangan posisi kerja akibat kejadian tersebut. Jika resistensi terhadap komunikasi terbuka ini dibiarkan berlanjut, penderitaan emosional staf akan meningkat secara signifikan, yang bermanifestasi sebagai rasa malu dan bersalah yang tidak terselesaikan, sehingga berdampak negatif pada harga diri dan memicu kondisi seperti kecemasan serta depresi..

Penghindaran percakapan mengenai kesalahan sering kali bersumber dari faktor struktural yang lebih besar daripada kesalahan individu semata. Salah satu penghalang utama adalah adanya budaya organisasi yang tidak aman secara psikologis, di mana staf merasa tidak nyaman untuk berbicara jujur mengenai proses yang gagal. Selain itu, nasihat dari lembaga hukum terkadang secara eksplisit menyarankan agar percakapan tentang insiden tersebut dihindari sepenuhnya. Ketika hambatan psikologis dan struktural ini tetap ada, potensi organisasi untuk belajar dari kegagalan sistemik menjadi sangat terbatas.

Eksplorasi lebih lanjut menegaskan nilai inheren dari percakapan timbal balik yang dilakukan secara terbuka setelah terjadi kesalahan medis. Komunikasi yang jujur ini memberikan kesempatan berharga bagi para profesional untuk menemukan titik temu dan memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai pengalaman yang terjadi. Berbagi cerita dan bergerak menuju keterbukaan juga merupakan langkah penting untuk mengakui kemanusiaan bersama di antara semua pihak yang terlibat dalam sistem. Kontribusi terhadap keterbukaan ini secara signifikan meningkatkan transparansi dalam sistem kesehatan, yang pada akhirnya mendukung budaya yang lebih adil dan lingkungan perawatan yang lebih aman (Aubin et al., 2022).

Komunikasi yang terbuka mengenai kesalahan medis adalah kunci untuk mengurangi beban emosional staf dan memperbaiki sistem kesehatan secara keseluruhan. Meskipun terdapat hambatan berupa rasa takut akan konsekuensi, dialog yang jujur menawarkan jalan menuju pemahaman bersama dan pengakuan kemanusiaan. Budaya yang memfasilitasi umpan balik timbal balik ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan transparansi dan keselamatan pasien jangka panjang.

G. Komunikasi Terbuka pada Staf untuk Bebas Berbicara

Membangun budaya di mana staf merasa aman dan didorong untuk berbicara adalah fundamental bagi peningkatan keselamatan pasien dalam layanan kesehatan. Administrator rumah sakit perlu menyadari bahwa perspektif mengenai budaya keselamatan sangat bervariasi di antara kelompok pekerja yang berbeda di dalam institusi. Mengandalkan hanya pada nilai rata-rata respons survei dapat mengaburkan perbedaan penting berdasarkan profesi atau peran staf. Perbedaan mendasar ini memiliki implikasi signifikan dalam merancang intervensi perbaikan yang benar-benar efektif dan tepat sasaran.

Perilaku penyampaian pendapat staf dipengaruhi oleh berbagai dimensi budaya keselamatan yang berbeda, sehingga menuntut adanya analisis yang terpisah untuk setiap komponen. Terdapat perbedaan mendasar antara penyampaian pendapat yang bersifat promosi, yang mengusulkan ide baru, dan penyampaian pendapat yang bersifat melarang, yang berfungsi sebagai peringatan risiko, di mana keduanya dipengaruhi oleh aspek budaya yang berbeda pula. Oleh karena itu, intervensi yang berhasil dalam mendorong keterbukaan harus memeriksa kedua jenis ekspresi ini secara terpisah dan menerapkan strategi yang berbeda untuk masing-masing (Lee et al., 2023). Pemimpin rumah sakit dan pengawas unit memegang tanggung jawab krusial untuk secara aktif mendukung budaya di mana staf merasa bebas berbicara tanpa rasa takut akan konsekuensi negatif. Dengan secara konsisten mempertimbangkan saran staf mengenai masalah keselamatan pasien yang mereka hadapi langsung, kepemimpinan mendukung budaya berbicara (*culture of speaking up*) yang merupakan prasyarat penting untuk peningkatan keselamatan berkelanjutan.

Komunikasi terbuka yang mendukung staf untuk berbicara adalah hasil dari kepemimpinan yang sadar akan keragaman perspektif dan perbedaan jenis ekspresi pendapat. Dengan tidak mengandalkan data rata-rata dan membedakan antara saran promosi dan peringatan, organisasi dapat menciptakan intervensi yang lebih tepat sasaran. Dukungan aktif dari manajemen terhadap setiap suara yang disampaikan adalah kunci untuk menumbuhkan lingkungan yang lebih aman dan lebih adil bagi pasien.

H. Kecukupan Staf untuk Beban kerja

Beban kerja perawat di unit perawatan intensif telah diidentifikasi sebagai faktor signifikan yang secara langsung memengaruhi keselamatan pasien di area dengan tingkat keparahan tinggi. Memastikan bahwa tingkat kepegawaian perawat berada pada level yang memadai merupakan langkah esensial untuk memitigasi

berbagai risiko keselamatan yang ada di area tersebut. Keseimbangan staf yang tepat tidak hanya mengurangi potensi kesalahan medis, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan hasil perawatan pasien secara keseluruhan (Anik et al., 2025). Oleh karena itu, manajemen beban kerja dan alokasi staf menjadi elemen integral dalam strategi keselamatan pasien yang efektif.

Beban kerja perawat memiliki pengaruh yang tidak terpisahkan terhadap kesehatan dan hasil akhir pasien secara umum. Untuk menjaga kualitas perawatan tetap tinggi, standarisasi rasio perawat-pasien menjadi sangat diperlukan dalam operasional rumah sakit sehari-hari. Ketika rasio ini dipertahankan pada tingkat yang optimal, perawat tidak lagi terpaksa hanya memprioritaskan intervensi utama yang mendesak di tengah keterbatasan waktu. Sebaliknya, mereka memiliki kapasitas untuk memberikan perawatan yang lebih komprehensif dan holistik kepada setiap individu pasien (Rahman et al., 2024). Penerapan rasio yang tepat ini secara langsung menghasilkan dampak positif yang terukur pada kualitas layanan kesehatan yang diberikan.

Korelasi antara beban kerja perawat, rasio staf yang memadai, dan keselamatan pasien sangat kuat, terutama di area perawatan intensif. Pengaturan rasio perawat-pasien yang ideal memungkinkan perawat untuk beralih dari sekadar mengatasi krisis menjadi memberikan perawatan yang berorientasi pada kebutuhan pasien secara menyeluruh. Kepemimpinan rumah sakit harus memprioritaskan pemenuhan standar kepegawaian ini sebagai investasi mendasar dalam mitigasi risiko dan peningkatan mutu layanan.

I. Kerjasama/Kolaborasi Tim antar Unit

Kerja sama tim yang terjalin erat antar unit merupakan fondasi operasional yang krusial dalam menunjang keberlanjutan dan mutu sistem layanan kesehatan. Ketika tenaga kesehatan menunjukkan tingkat koordinasi yang tinggi serta mempertahankan sikap kerja sama yang positif, manfaatnya meluas ke seluruh spektrum organisasi. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kepuasan penerima layanan dan konsistensi dalam penyediaan perawatan kesehatan berkualitas tinggi yang terstandarisasi. Budaya kerja sama yang kuat ini secara fundamental membentuk lingkungan klinis yang lebih aman dan produktif.

Dalam konteks ini, kolaborasi interprofesional bertindak sebagai katalisator utama untuk mengimplementasikan paradigma perawatan yang berpusat pada pasien secara substansial. Ketika berbagai disiplin ilmu menyatukan perspektif dan keahlian mereka, perencanaan klinis menjadi lebih terintegrasi dan menyeluruh, mengatasi kompleksitas kebutuhan pasien secara holistik. Layanan Kesehatan dapat mewujudkan model perawatan yang berfokus pada individu dengan lebih efektif

melalui mekanisme kerja sama ini (Villareal, 2024). Kegagalan dalam mengintegrasikan pandangan dari berbagai unit akan menghasilkan fragmentasi layanan yang mengancam tujuan utama perawatan berpusat pada pasien.

Lebih lanjut, sinergi yang kuat antar unit memiliki implikasi signifikan terhadap efisiensi sistem secara keseluruhan dan mitigasi risiko. Alur kerja yang terkoordinasi dengan baik memastikan proses transisi pasien antar departemen berjalan mulus, mengurangi potensi hambatan birokrasi dan penundaan klinis. Selain itu, lingkungan yang mendorong komunikasi terbuka antar tim memfasilitasi identifikasi dini terhadap potensi bahaya atau ketidaksesuaian protokol. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi ini harus dipandang sebagai investasi strategis yang mendukung keunggulan klinis dan keberlanjutan operasional jangka panjang.

Kolaborasi tim yang efektif adalah penentu utama keberhasilan sistem kesehatan, memungkinkan layanan yang lebih berkualitas dan berpusat pada pasien. Sinergi antar profesi adalah kunci untuk mewujudkan perawatan yang terintegrasi, sebuah aspek penting yang didukung oleh analisis terkini mengenai praktik layanan kesehatan. Dengan demikian, koordinasi yang tinggi antar unit bukan sekadar pilihan operasional, melainkan sebuah prasyarat untuk mencapai hasil klinis yang optimal..

J. Prosedur Serah Terima Pasien yang Aman

Penerapan model komunikasi SBAR (*Situation, Background, assessment, dan Recommendation*) telah terbukti efektif dalam menciptakan proses serah terima perawatan pasien yang lebih aman dan terstruktur di lingkungan kesehatan karena sifatnya yang konsisten dan berpusat pada pasien. Studi secara spesifik mengindikasikan bahwa penggunaan model ini tidak menghasilkan kejadian negatif selama proses serah terima, menegaskan SBAR sebagai metode yang andal dan aman untuk transisi perawatan antar staf. Meskipun perawat menunjukkan kesediaan yang tinggi untuk mengadopsi model komunikasi ini, keberhasilan implementasi bergantung pada faktor pendukung yang lebih luas daripada sekadar kemauan staf. Efektivitas penuh SBAR sangat terikat pada pengembangan budaya organisasi yang mendukung keterbukaan serta investasi dalam pelatihan praktis yang memadai untuk penerapannya (Pazar et al., 2024). Dengan demikian, institusi harus memastikan bahwa landasan budaya dan pelatihan yang kuat telah ditetapkan untuk mendukung adopsi model ini demi mempertahankan standar keselamatan yang konsisten.

Model SBAR menawarkan solusi terstruktur untuk meningkatkan keamanan selama serah terima pasien dengan menstandarisasi penyampaian informasi penting. Keberhasilannya terbukti dari tidak adanya insiden negatif yang dilaporkan

selama pengujian model ini dalam praktik. Meskipun perawat menyambut baik penggunaan SBAR, institusi harus memastikan bahwa landasan budaya dan pelatihan yang kuat telah ditetapkan untuk mendukung adopsi yang efektif dan berkelanjutan.

K. Frekuensi Pelaporan Insiden

Pengukuran kejadian buruk secara andal dan efisien merupakan prasyarat fundamental dalam upaya peningkatan keselamatan pasien di lingkungan klinis. Pengembangan pendekatan yang terstandarisasi untuk mengidentifikasi dan memfokuskan perhatian pada bahaya yang sebenarnya dapat dicegah sangat penting untuk memberikan dukungan yang efektif bagi tim peningkatan keselamatan. Tanpa sistem pengukuran yang konsisten, upaya perbaikan yang ditargetkan berpotensi kehilangan fokus dan efektivitasnya di tengah kompleksitas operasional rumah sakit.

Terdapat variasi signifikan dalam kemudahan identifikasi berbagai jenis kejadian buruk yang terjadi dalam praktik klinis sehari-hari. Sebagai contoh nyata, infeksi terkait perawatan kesehatan sering kali dapat diidentifikasi dengan tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jenis insiden lainnya. Ketidakseimbangan dalam deteksi ini secara jelas menunjukkan perlunya peningkatan pelacakan rutin, terutama untuk kejadian yang lebih sulit ditangkap seperti efek samping obat yang merugikan. Oleh karena itu, konsistensi dalam metodologi pemantauan sangat penting untuk menangkap seluruh spektrum bahaya yang mungkin terjadi (Bates et al., 2023).

Peningkatan kualitas dan frekuensi pengumpulan data memiliki dampak langsung pada kemampuan rumah sakit untuk mengelola risiko secara proaktif. Apabila sebuah institusi memiliki data yang lebih andal dan dikumpulkan secara lebih rutin, hal tersebut membuka peluang untuk meningkatkan intensitas dan ketepatan pemantauan klinis. Peningkatan pemantauan berbasis data yang kuat ini pada akhirnya berkorelasi langsung dengan potensi penurunan tingkat kejadian buruk secara keseluruhan di fasilitas kesehatan tersebut. Dengan demikian, investasi dalam sistem pelaporan yang superior merupakan strategi preventif yang esensial.

Efektivitas program peningkatan keselamatan sangat bergantung pada seberapa baik dan sering insiden buruk dilaporkan serta dianalisis secara sistematis. Variabilitas dalam deteksi antar jenis insiden menuntut fokus khusus pada peningkatan pelacakan untuk kejadian yang kurang kentara. Fasilitas kesehatan yang mampu mengumpulkan data yang lebih andal dan rutin akan mampu meningkatkan pemantauan dan mencapai pengurangan insiden yang tidak diinginkan.

L. Persepsi Staf terhadap Keselamatan Pasien

Peningkatan persepsi budaya keselamatan pasien di kalangan perawat merupakan upaya strategis yang menuntut intervensi pendidikan yang terstruktur dan berkelanjutan. Perawat perlu dibekali pemahaman mendalam mengenai protokol perawatan standar yang berlaku di institusi mereka agar praktik klinis tetap konsisten. Selain itu, penguasaan praktik pelaporan insiden yang efektif dan mekanisme komunikasi yang lancar antar tim sangat vital untuk menumbuhkan lingkungan yang aman. Program pengembangan profesional berkelanjutan atau pelatihan kerja yang terfokus menjadi sarana utama untuk mengintegrasikan kesadaran ini ke dalam praktik harian mereka.

Peningkatan budaya keselamatan pasien sangat bergantung pada bagaimana staf, khususnya perawat, memandang dan menerapkan protokol keamanan yang berlaku di lingkungan kerja mereka. Upaya ini memerlukan kesadaran yang tinggi terhadap isu-isu keselamatan, termasuk kepatuhan terhadap protokol perawatan standar serta pemahaman mengenai pelaporan insiden dan komunikasi efektif. Intervensi melalui pengembangan profesional berkelanjutan menjadi kunci untuk mengintegrasikan kesadaran ini ke dalam praktik klinis sehari-hari.

Pengukuran persepsi perawat terhadap budaya keselamatan sangat penting untuk menentukan hubungan mengenai dampak akreditasi rumah sakit terhadap praktik klinis. Investigasi ini bertujuan untuk menambah pengetahuan baru dengan membandingkan persepsi perawat di fasilitas terakreditasi dan yang tidak terakreditasi. Hasilnya akan memberikan bukti valid kepada para pemangku kepentingan layanan kesehatan mengenai apakah status akreditasi berpengaruh positif terhadap pola pikir keselamatan staf. Bukti empiris ini diperlukan untuk menentukan efektivitas standar eksternal dalam mendorong budaya keselamatan yang lebih tangguh (Oweidat et al., 2024).

Pemeriksaan mendalam ini menawarkan lebih dari sekadar perbandingan status yang berfungsi sebagai peta jalan krusial untuk perbaikan berkelanjutan di tingkat staf. Penilaian ini secara eksplisit menunjukkan area kekuatan yang sudah ada di mana persepsi perawat telah selaras dengan standar keselamatan. Selain itu, temuan tersebut juga mengidentifikasi zona yang memerlukan penguatan agar perawat dapat memperluas dan memperdalam praktik mereka menuju budaya keselamatan pasien yang lebih komprehensif. Dengan pemetaan rinci ini, manajemen dapat menyusun program pelatihan yang lebih tepat sasaran dan berdampak signifikan..

Kesadaran staf dan pelatihan yang ditargetkan adalah komponen kunci dalam membangun fondasi keselamatan pasien yang kuat di rumah sakit. Pengukuran

persepsi ini memungkinkan institusi untuk bergerak melampaui kepatuhan prosedural menuju adopsi nilai-nilai keselamatan secara intrinsik oleh tenaga kesehatan. Dengan mengidentifikasi kesenjangan antara praktik ideal dan persepsi aktual, rumah sakit dapat memprioritaskan sumber daya untuk intervensi yang paling dibutuhkan.

Secara keseluruhan, kesadaran staf dan pelatihan yang ditargetkan adalah komponen kunci dalam membangun fondasi keselamatan pasien yang kuat di rumah sakit. Pengukuran persepsi ini memungkinkan institusi untuk bergerak melampaui kepatuhan prosedural menuju adopsi nilai-nilai keselamatan secara intrinsik oleh tenaga kesehatan. Dengan mengidentifikasi kesenjangan antara praktik ideal dan persepsi aktual, rumah sakit dapat memprioritaskan sumber daya untuk intervensi yang paling dibutuhkan.

M. Penutup

Budaya keselamatan pasien merupakan landasan strategis yang menopang kualitas dan keandalan seluruh sistem layanan kesehatan. Keberhasilan dalam meminimalkan risiko insiden tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap protokol, melainkan pada integrasi mendalam dari berbagai komponen perilaku dan struktural. Hal tersebut, mencakup kolaborasi tim yang kuat antar unit, dukungan nyata dari kepemimpinan klinis, serta penerapan kerangka keadilan restoratif yang mendorong pelaporan tanpa rasa takut. Selain itu, elemen operasional seperti serah terima yang terstruktur, pemantauan insiden yang konsisten, dan alokasi staf yang memadai menjadi penopang praktis bagi budaya pembelajaran organisasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemahaman multidimensi terhadap setiap aspek budaya keselamatan ini adalah langkah awal yang krusial bagi organisasi untuk bertransformasi menjadi entitas yang secara proaktif mengutamakan keamanan pasien di atas segalanya.

Referensi

- Alkubati, S. A., Al-Qalah, T., Salameh, B., Alsabri, M., Alrubaiee, G. G., Loutfy, A., Alwesabi, S. A., El-Monshed, A. H., & Elsayed, S. M. (2024). Understanding the Relationship Between Critical Care Nurses' Perception of Patient Safety Culture and Adverse Events. *SAGE Open Nursing*, 10, 23779608241292847. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/23779608241292847>
- Anik, A. I., Islam, T., & Uddin, B. (2025). Relationship between nurse workload and patient safety in critical care. *Asia Pacific Journal of Nursing Research*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.70818/apjnr.2025.v06i01.019>
- Aubin, D. L., Soprovich, A., Diaz Carvallo, F., Prowse, D., & Eurich, D. (2022). Support for healthcare workers and patients after medical error through mutual healing: another step towards patient safety. *BMJ Open Quality*, 11(4), e002004.
- Bates, D. W., Levine, D. M., Salmasian, H., Syrowatka, A., Shahian, D. M., Lipsitz, S., Zebrowski, J. P., Myers, L. C., Logan, M. S., & Roy, C. G. (2023). The safety of inpatient health care. *New England Journal of Medicine*, 388(2), 142–153. <https://doi.org/10.1056/NEJMsa2206117>
- Binkheder, S., Alaska, Y. A., Albaharnah, A., AlSultan, R. K., Alqahtani, N. M., Amr, A. A., Algerian, N., & Alkutbe, R. (2023). The relationships between patient safety culture and sentinel events among hospitals in Saudi Arabia: a national descriptive study. *BMC health services research*, 23(1), 270. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12913-023-09205-0>
- Carmack, A., Valleru, J., Baka, D., Henderson, M., McCarter, S., Walsh, J., & Randall, K. (2024). Building a Learning Management Framework for Patient Safety: Lessons From a Large Multistate System. *Patient Safety*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33940/001c.121145>
- Fuchshuber, P., & Greif, W. (2022). Creating effective communication and teamwork for patient safety. In *The SAGES manual of quality, outcomes and patient safety* (pp. 443–460). Springer. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-94610-4_23
- Hafezi, A., Babaii, A., Aghaie, B., & Abbasinia, M. (2022). The relationship between patient safety culture and patient safety competency with adverse events: a multicenter cross-sectional study. *BMC nursing*, 21(1), 292. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12912-022-01076-w>
- Knowles, S. (2024). Measuring Patient Safety Culture. In *Patient Safety Coaching: Transforming Healthcare Culture* (pp. 193–217). Springer. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-68722-8_8
- Lee, S. E., Dahinten, V. S., Seo, J.-K., Park, I., Lee, M. Y., & Han, H. S. (2023). Patient safety culture and speaking up among health care workers. *Asian nursing research*, 17(1), 30–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.anr.2023.01.001>

- Mistri, I. U., Badge, A., & Shahu, S. (2023). Enhancing patient safety culture in hospitals. *Cureus*, 15(12), e51159. <https://doi.org/10.7759/cureus.51159>
- Murray, J. S., Clifford, J., Larson, S., Lee, J. K., & Sculli, G. L. (2023). Implementing just culture to improve patient safety. *Military Medicine*, 188(7-8), 1596–1599. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/milmed/usac115>
- Oweidat, I. A., Atiyeh, H., Alost, M., Al-Mugheed, K., Saeed Alabdullah, A. A., Alzoubi, M. M., & Farghaly Abdelaliem, S. M. (2024). The influence of hospital accreditation on nurses' perceptions of patient safety culture. *Human Resources for Health*, 22(1), 36. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12960-024-00920-1>
- Pazar, B., Kavakli, O., Ak, E. N., & Erten, E. E. (2024). Implementation and evaluation of the SBAR Communication Model in Nursing handover by Pediatric surgery nurses. *Journal of PeriAnesthesia Nursing*, 39(5), 847–852. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jopan.2023.12.021>
- Rahman, S. U., Mehmood, A., Naz, I., Ismail, M., Adeel, M., Gul, S., Islam, M., & Uddin, M. (2024). Nurse's Workload, Patient Safety and Quality of Care; A Descriptive Study in Tertiary Care Hospital: Workload and Quality of Care in Nurses. *Pakistan BioMedical Journal*, 11–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.54393/pbmj.v7i09.1152>
- Savage, M., & Jamarik, M. B. (2024). Healing and Learning: A Restorative Just Culture. In *The Nexus between Nursing and Patient Safety* (pp. 307–321). Springer. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-53158-3_16
- Segura-García, M. T., Castro Vida, M. Á., García-Martin, M., Álvarez-Ossorio-García de Soria, R., Cortés-Rodríguez, A. E., & López-Rodríguez, M. M. (2023). Patient safety culture in a tertiary hospital: a cross-sectional study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(3), 2329. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/ijerph20032329>
- Tadia, V. K., Kotwal, N., & Jalaunia, R. S. (2025). Patient safety culture: Insights from a cross-sectional study among healthcare professionals. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 14(1), 90–96. https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_904_24
- Vail, S. G., Dierst-Davies, R., Kogut, D., Winslow, L. D., Kolb, D., Weckenman, A., Almeida, S., King, H. B., Chesson, E., & Strickland, M. (2023). Teamwork is associated with reduced hospital staff burnout at military treatment facilities: findings from the 2019 department of defense patient safety culture survey. *The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety*, 49(2), 79–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcjq.2022.11.004>
- Vikan, M., Haugen, A. S., Bjørnnes, A. K., Valeberg, B. T., Deilkås, E. C. T., & Danielsen, S. O. (2023). The association between patient safety culture and adverse

- events—a scoping review. *BMC health services research*, 23(1), 300.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12913-023-09332-8>
- Villareal, S. C. (2024). The impact of the collaborating factors on the quality of care among health care in the hospitals of Hail region: A cross-sectional study. *Hail Journal of Health Sciences*, 6(1), 36–40.
<https://doi.org/0.4103/hjhs.hjhs.13.23>
- Zaitoun, R. A., Said, N. B., & de Tantillo, L. (2023). Clinical nurse competence and its effect on patient safety culture: a systematic review. *BMC nursing*, 22(1), 173.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12912-023-01305-w>

Glosarium

A

Adverse Events (AEs) / Kejadian Buruk : Kejadian yang mengindikasikan adanya kerentanan sistemik yang berkelanjutan dalam sistem perawatan kesehatan

B

Budaya Keadilan Restoratif : Kerangka kerja mutakhir dalam manajemen insiden yang bertujuan memahami seluruh komponen kesalahan medis sambil mengenali kegagalan sistem yang menyebabkannya, berfokus pada investigasi sistemik dan dukungan bagi korban.

Budaya Keselamatan Pasien : Elemen fundamental dalam kerangka kerja organisasi layanan kesehatan yang memprioritaskan upaya meminimalkan risiko dan meningkatkan kualitas perawatan di seluruh spektrum pelayanan medis,

Budaya Tanpa Menyalahkan (*No-blame Culture*) : Perubahan budaya eksplisit yang harus dipromosikan sebagai landasan utama interaksi staf untuk meminimalkan rasa takut dalam melaporkan peristiwa sentinel yang kritis.

H

Hospital Survey of Patient Safety Culture (HSOPSC) : Instrumen standar yang digunakan untuk mengukur dan memantau kondisi budaya keselamatan dengan menangkap persepsi staf mengenai lingkungan kerja mereka.

K

Keadilan Prosedural : Pilar budaya organisasi di mana kejadian buruk tidak dilihat sebagai momen mencari kesalahan individu, melainkan sebagai peluang untuk memahami faktor penyebab sistemik.

Keselamatan Pasien : Upaya sistematis yang ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya efek samping yang terkait dengan intervensi medis, menjadikannya aspek terpenting dalam perawatan kontemporer.

Kolaborasi Interprofesional : Mekanisme kerja sama di mana berbagai disiplin ilmu menyatukan perspektif dan keahlian untuk mewujudkan perawatan yang berpusat pada pasien secara lebih menyeluruh.

P

Pembelajaran Organisasi : Adopsi budaya pembelajaran mendalam dan transparansi tinggi yang memungkinkan institusi mengekstrak pelajaran berharga dari kesalahan manusia untuk perbaikan sistem berkelanjutan.

C

Rasio Perawat-Pasien : Standarisasi jumlah perawat terhadap pasien yang diperlukan dalam operasional rumah sakit untuk menjaga kualitas perawatan tetap tinggi dan memungkinkan pemberian perawatan yang komprehensif.

S

SBAR (*Situation, Background, Assessment, and Recommendation*) : Model komunikasi terstruktur yang terbukti efektif dalam menciptakan proses serah terima perawatan pasien yang lebih aman dan konsisten antar staf.

BAB 2

IDENTIFIKASI DAN KLASIFIKASI INSIDEN KESELAMATAN PASIEN

A. Pendahuluan

Keselamatan pasien (patient safety) merupakan pilar utama mutu pelayanan kesehatan dan menjadi indikator penting keberhasilan sistem kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa 1 dari 10 pasien mengalami insiden keselamatan selama perawatan, dan hampir 50% di antaranya dapat dicegah melalui sistem identifikasi dini, komunikasi efektif, serta pelaporan insiden yang terstruktur (WHO, 2021).

Di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, insiden keselamatan pasien dapat menimbulkan cedera, memperpanjang lama rawat, meningkatkan biaya, bahkan menyebabkan kematian (OECD, 2020). Di Indonesia, komitmen terhadap keselamatan pasien ditegaskan melalui Peraturan Menteri Kesehatan tentang keselamatan pasien serta standar akreditasi rumah sakit yang mewajibkan identifikasi, klasifikasi, pelaporan, analisis, dan tindak lanjut insiden sebagai bagian dari manajemen risiko pelayanan kesehatan. Walaupun demikian, berbagai laporan nasional menunjukkan bahwa pelaporan insiden masih rendah karena kendala budaya menyalahkan (blaming culture), ketakutan terhadap konsekuensi hukum, kurangnya pengetahuan mengenai klasifikasi insiden, serta belum optimalnya sistem pelaporan internal (KPPRS, 2022).

Upaya meningkatkan keselamatan pasien memerlukan pemahaman yang jelas mengenai **jenis-jenis insiden**, **mekanisme identifikasi**, serta **klasifikasi insiden** berdasarkan sistem nasional dan standar internasional seperti *International Classification for Patient Safety* (ICPS) dari WHO. Identifikasi dan klasifikasi insiden yang tepat merupakan dasar bagi analisis akar masalah (*Root Cause Analysis*), perbaikan sistem, serta pencegahan insiden serupa di masa depan.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep dasar, proses identifikasi, klasifikasi, pelaporan, hingga analisis insiden keselamatan pasien agar tenaga kesehatan dapat berkontribusi dalam membangun pelayanan yang aman, efektif, dan berorientasi pembelajaran.

B. (ISI)Identifikasi Insiden Keselamatan Pasien

1. Prinsip Identifikasi Insiden Keselamatan Pasien

Identifikasi insiden keselamatan pasien merupakan proses sistematis untuk menemukan setiap kejadian yang berpotensi atau telah menyebabkan cedera pada pasien. Prinsip-prinsip utama meliputi:

a. Fokus pada Sistem, bukan Individu

Kesalahan umumnya berasal dari kelemahan sistem, bukan individu. Pendekatan sistem membantu mengurangi budaya menyalahkan dan mendorong pelaporan terbuka. Didukung oleh panduan WHO dalam *Global Patient Safety Action Plan 2021–2030*.

b. Deteksi Secepat Mungkin (Early Identification)

Semakin cepat insiden dikenali, semakin kecil risiko cedera. Deteksi mencakup observasi klinis, monitoring elektronik, dan kontrol checklist.

c. Berbasis Bukti & Standar Internasional

Identifikasi harus merujuk pada *International Classification for Patient Safety* (ICPS) dari WHO untuk klasifikasi insiden. Merujuk *International Classification for Patient Safety*.

d. Menyeluruh & Konsisten

Semua area layanan (IGD, rawat inap, ICU, kamar operasi, farmasi) wajib menjalankan sistem identifikasi dengan prosedur yang seragam.

e. Transparansi & Akuntabilitas

Informasi harus lengkap, jujur, dan terdokumentasi melalui sistem pelaporan internal (misal IRIMS, SIMRS).

2. Mekanisme Deteksi Dini Insiden (*Early Detection Mechanisms*)

Deteksi dini menekankan pengenalan tanda awal kondisi memburuk atau potensi bahaya.

a. Deteksi Klinis

- 1) Pemantauan tanda vital,
- 2) Observasi perubahan status mental,
- 3) Deteksi gejala awal *deterioration*,
- 4) Mengenali respon abnormal terhadap obat.

Metode ini didukung dalam buku: *Nursing Management and Professional Concepts*.

b. *Early Warning Scoring System (EWSS)*

Sistem skoring untuk mendeteksi kondisi memburuk melalui penilaian:

- 1) Frekuensi napas,
- 2) Saturasi O₂,

- 3) Tekanan darah,
- 4) Denyut nadi,
- 5) Tingkat kesadaran (*avpu*),
- 6) Suhu tubuh.

Bila skor melewati batas, perawat wajib mengaktifkan *Rapid Response Team* (RRT).

c. Monitoring Berbasis Teknologi

- 1) Alarm monitor ICU,
- 2) Sistem smart infusion pump,
- 3) Electronic medical record alert,
- 4) Barcode medication administration (BCMA).

Teknologi ini efektif mencegah *medication error* (WHO, 2021).

d. Identifikasi Risiko Melalui Screening

Contoh screening risiko:

- 1) Risiko jatuh (*Morse Fall Scale*),
- 2) Risiko ulkus tekan (*Braden Scale*),
- 3) Risiko infeksi nosokomial.

3. Penggunaan Alat & Checklist

Checklist digunakan untuk meningkatkan konsistensi dan mengurangi human error.

a. SBAR (*Situation–Background–Assessment–Recommendation*)

SBAR adalah alat komunikasi standar untuk memastikan informasi klinis disampaikan jelas, cepat, dan terstruktur.

Fungsi SBAR:

- 1) Mempercepat proses pengambilan keputusan,
- 2) Mencegah miskomunikasi,
- 3) Meningkatkan keselamatan pasien.

Contoh penggunaan:

- 1) Melapor ke dokter saat kondisi pasien menurun,
- 2) Melakukan handover di ruang rawat.

SBAR direkomendasikan dalam *Leadership and Nursing Care Management* sebagai alat manajemen mutu komunikasi.

b. *Early Warning Checklist*

Checklist untuk mendeteksi perubahan dini pasien, termasuk:

- 1) Peningkatan skor Early Warning,
- 2) Penurunan kesadaran,
- 3) Perubahan pola napas drastis,

4) Warna kulit tidak normal.

Checklist ini berperan sebagai *trigger tool* untuk mencegah sentinel event.

c. *Surgical Safety Checklist* (SSC – WHO)

Digunakan di kamar bedah untuk mencegah:

- 1) Salah pasien,
- 2) Salah prosedur,
- 3) Salah lokasi operasi.

Mengacu pada *WHO Surgical Safety Checklist*.

d. *Medication Safety Checklist*

Checklist ini membantu mencegah *medication error* yang meliputi:

- 1) 6 benar (right patient, right drug, right dose, right time, right route, right documentation),
- 2) Alergi obat,
- 3) Interaksi obat.

4. Peran Tim dalam Identifikasi dan Deteksi Insiden

a. Peran Perawat

Perawat berada di garis depan sehingga berperan utama dalam:

- 1) Identifikasi perubahan kondisi pasien,
- 2) Pelaporan awal insiden,
- 3) Penggunaan checklist,
- 4) Komunikasi antar tim.

b. Peran Dokter

- 1) Menindaklanjuti laporan perawat,
- 2) Menentukan keputusan klinis cepat,
- 3) Memberikan klarifikasi terhadap tindakan.

c. Peran Komite Mutu & Keselamatan Pasien

- 1) Menerima laporan insiden,
- 2) Melakukan analisis akar masalah (*Root Cause Analysis*),
- 3) Menyusun rekomendasi perbaikan sistem.

d. *Rapid Response Team* (RRT)

RRT diaktifkan jika pasien menunjukkan tanda memburuk pada skor *Early Warning*.

5. Budaya Pelaporan (*Reporting Culture*)

Budaya pelaporan adalah fondasi keselamatan pasien.

Prinsip utama budaya pelaporan:

- a. Non-Punitive (tidak menyalahkan)
Tenaga kesehatan harus merasa aman melaporkan insiden tanpa takut dihukum (Mira et al., 2020).
- b. Anonim & Rahasia
Identitas pelapor tidak menjadi fokus, melainkan belajarnya.
- c. Pembelajaran Berkelanjutan
Setiap insiden dianalisis dan digunakan untuk memperbaiki sistem, bukan mencari kesalahan.
- d. Keterbukaan Informasi
Pelaporan harus transparan, mudah diakses, dan cepat.
- e. Dukungan Kepemimpinan
Pemimpin organisasi wajib mendorong:
 - 1) Komunikasi terbuka,
 - 2) Reward untuk pelaporan,
 - 3) Penyediaan sistem pelaporan yang mudah.

C. Klasifikasi Insiden Keselamatan Pasien

Klasifikasi insiden keselamatan pasien bertujuan untuk mengidentifikasi jenis kejadian, tingkat keparahan, serta risiko yang muncul dalam pelayanan kesehatan. Sistem klasifikasi ini menjadi dasar untuk pelaporan, analisis akar masalah, dan pengembangan strategi pencegahan. Pedoman utama mengacu pada standar nasional dan *International Classification for Patient Safety (ICPS)* dari WHO

1. Sistem Klasifikasi Nasional

Di Indonesia, klasifikasi insiden keselamatan pasien merujuk pada regulasi Kementerian Kesehatan RI serta panduan dari Komite Mutu & Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KMKP-RS).

Jenis Insiden menurut Sistem Nasional:

- a. Kejadian Nyaris Cedera (*Near Miss*)
Insiden yang sudah terjadi namun tidak sampai menimbulkan cedera pada pasien karena dicegah tepat waktu atau secara kebetulan tidak berdampak.
- b. Kejadian Tidak Cedera (*No Harm Event*)
Kesalahan terjadi dan mencapai pasien, tetapi tidak menimbulkan cedera maupun dampak klinis.

- c. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD / *Adverse Event*)
Insiden yang mencapai pasien dan menimbulkan cedera, baik ringan, sedang, maupun berat.
 - d. Kejadian Sentinel (*Sentinel Event*)
Kejadian yang mengancam nyawa, menyebabkan kecacatan permanen, atau kematian; memerlukan penyelidikan mendalam (*Root Cause Analysis*).
 - e. Kondisi Berbahaya (*Hazardous Condition*)
Kondisi atau situasi yang berpotensi menimbulkan insiden jika tidak ditangani.
Sistem ini digunakan dalam audit keselamatan pasien, pelaporan insiden, serta peningkatan mutu. (Referensi nasional: Kemenkes RI ; Pedoman Keselamatan Pasien Rumah Sakit, 2020).
2. Klasifikasi Berdasarkan WHO (ICPS)
- Klasifikasi Berdasarkan WHO (ICPS)
- Klasifikasi internasional mengacu pada International Classification for Patient Safety yang menyediakan kerangka global untuk pemahaman dan pelaporan insiden.
- Elemen utama ICPS meliputi:
- a. Jenis Insiden (Incident Type)
Termasuk medikasi, prosedur klinis, komunikasi, dokumentasi, peralatan medis, dan lainnya.
 - b. Penyebab / Faktor Kontribusi
 - 1) Faktor manusia (misal: kelelahan, komunikasi kurang)
 - 2) Faktor organisasi (SDM kurang, shift berlebih)
 - 3) Faktor teknologi (alat rusak, alarm gagal)
 - 4) Faktor lingkungan (bising, pencahayaan rendah)
 - c. Outcome Pasien (*Patient Outcomes*)
Tingkat keparahan cedera atau potensi cedera.
 - d. Outcome Organisasi
Dampak administratif atau operasional, misal: biaya tambahan, perawatan lebih lama.
 - e. Fase Perawatan (*Care Delivery Stage*)
Identifikasi di tahap manapun: asesmen, diagnosis, pengobatan, pembedahan, edukasi, pemulangan.

Kategori Utama Insiden menurut WHO ICPS:

- a. *Clinical Administration*
- b. *Medication / IV Fluids*
- c. *Blood / Blood Products*
- d. *Patient Behavior / Accidents*
- e. *Clinical Process / Procedure*
- f. *Documentation*
- g. *Healthcare-Associated Infection*
- h. *Medical Device / Equipment*
- i. *Nutrition*
- j. *Oxygen / Gas / Vacuum*
- k. *Infrastructure / Building / Fixtures*

3. Level Keparahan Insiden

Level keparahan digunakan menentukan dampak terhadap pasien dan urgensi tindak lanjut.(WHO – *Patient Safety Incident Reporting and Learning Systems* , 2020).

a. *No Harm*

Insiden tidak menyebabkan cedera atau dampak klinis.

b. *Mild Harm*

Menimbulkan cedera ringan, tidak memerlukan perawatan tambahan dan tidak berkepanjangan.

c. *Moderate Harm*

Menimbulkan cedera yang membutuhkan tindakan atau perawatan tambahan, tetapi tidak mengancam nyawa.

d. *Severe Harm*

Cedera berat yang berdampak pada disabilitas permanen atau memerlukan intervensi medis besar.

e. *Death* (Kematian)

Insiden yang berkontribusi langsung atau tidak langsung terhadap kematian pasien.

Keparahan ini digunakan untuk prioritas investigasi, terutama dalam sentinel event yang wajib dilakukan RCA (Root Cause Analysis).

4. Area Risiko Utama

Ada beberapa area layanan yang diketahui secara global memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya insiden keselamatan pasien:

a. Medikasi

Termasuk kesalahan:

- 1) Salah obat,
- 2) Salah dosis,
- 3) Salah waktu,
- 4) Salah pasien,
- 5) Interaksi obat tidak terdeteksi,
- 6) Infus pump error.

Pendukung: barcode medication administration (BCMA).

Referensi: WHO – *Medication Without Harm Global Challenge* (2017).

b. Transfusi Darah

Risiko:

- 1) Inkompatibilitas golongan,
- 2) Salah identifikasi pasien,
- 3) Reaksi transfusi akut,
- 4) Dokumentasi yang buruk.

Checklist transfusi dan double-check sangat penting.

c. Pembedahan/ *Surgical Safety*

Kesalahan yang sering terjadi:

- 1) Salah pasien,
- 2) Salah tempat operasi,
- 3) Salah prosedur,
- 4) Instrumen tertinggal,
- 5) Infeksi luka operasi.

Solusi: *WHO Surgical Safety Checklist*.

d. Peralatan Medis (*Medical Devices*)

Risiko:

- 1) Alarm fatigue,
- 2) Ventilator error,
- 3) Kalibrasi tidak sesuai,
- 4) Kabel/monitor rusak.

e. Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (HAIs)

Termasuk:

- 1) Infeksi luka operasi,
- 2) Infeksi saluran kemih terkait kateter,
- 3) VAP (Ventilator-Associated Pneumonia),
- 4) CLABSI (infeksi garis sentral).

f. Diagnosis dan Proses Klinis

Risiko:

- 1) Keterlambatan diagnosis,
- 2) Salah interpretasi hasil lab,
- 3) Salah membaca hasil imaging,
- 4) Miskomunikasi antar tim.

Referensi: *Leadership and Nursing Care Management* (Leadership and Nursing Care Management).

g. Komunikasi & Dokumentasi

Misalnya:

- 1) Serah terima tidak lengkap,
- 2) Penggunaan SBAR tidak konsisten,
- 3) Catatan medis tidak akurat.

D. Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien

Pelaporan insiden merupakan bagian penting dari sistem keselamatan pasien yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencegah kejadian yang membahayakan pasien. Pelaporan yang baik memungkinkan fasilitas kesehatan untuk menemukan akar masalah, memperbaiki proses, dan membangun budaya keselamatan. Pelaporan insiden tidak bertujuan mencari kesalahan individu, tetapi memperbaiki sistem dan alur kerja. Oleh karena itu, prinsip non-punitive dan budaya terbuka sangat ditekankan dalam praktik keselamatan pasien modern.

1. Standar Pelaporan Internal & Eksternal

a. Pelaporan Internal (di dalam fasilitas kesehatan)

Biasanya diatur melalui kebijakan RS/Puskesmas:

- 1) Insiden keselamatan pasien harus dilaporkan oleh tenaga kesehatan yang menemukan atau terlibat.
- 2) Jenis insiden yang wajib dilaporkan meliputi:
 - a) Kejadian tidak diharapkan (KTD)
 - b) Kejadian nyaris cedera (KNC)
 - c) Kejadian tidak cedera (KTC)
 - d) Sentinel event (kejadian sentinel)
- 3) Waktu pelaporan:
 - a) Insiden serius → segera / < 24 jam
 - b) Insiden lainnya → maksimal 2×24 jam
- 4) Tim Terkait:
 - a) Tim Keselamatan Pasien
 - b) Komite Mutu

- c) Unit mutasi/penanggung jawab instalasi
- b. Pelaporan Eksternal (di luar fasilitas kesehatan)

Sesuai standar Kementerian Kesehatan RI & WHO:

 - 1) Pelaporan nasional melalui *National Reporting and Learning System (NRLS)* versi Indonesia (Komite Nasional Keselamatan Pasien – Kemenkes).
 - 2) Pelaporan sentinel event wajib diteruskan ke regulator (Kemenkes/Dinkes).
 - 3) Pelaporan ke organisasi independen internasional (bila diperlukan):
 - a) WHO Global Patient Safety Network
 - b) Joint Commission International (JCI)

Tujuan pelaporan eksternal: pembelajaran nasional, benchmarking, dan perbaikan sistem kesehatan.
- 2. Alur Pelaporan Insiden

Setiap institusi memiliki SOP masing-masing, namun alurnya umumnya sama:

 - a. Identifikasi Insiden

Tenaga kesehatan menemukan insiden, keluhan, perubahan kondisi mendadak, atau kesalahan proses.
 - b. Stabilkan Kondisi Pasien

Keselamatan pasien menjadi prioritas sebelum melakukan dokumentasi.
 - c. Dokumentasi & Pelaporan

Mengisi formulir pelaporan insiden:

 - 1) Deskripsi kejadian
 - 2) Lokasi & waktu
 - 3) Siapa saja yang terlibat
 - 4) Kronologi
 - 5) Dampak
 - 6) Tindakan awal
 - d. Pelaporan ke Unit / Tim Keselamatan Pasien

Petugas melapor ke:

 - 1) Kepala ruangan
 - 2) Tim keselamatan pasien
 - 3) Komite mutu
 - e. Analisis

Proses ini bisa mencakup:

 - 1) *Root Cause Analysis* (RCA)
 - 2) *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA)
 - 3) Audit & Investigasi Insiden

f. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan

Meliputi:

- 1) Perubahan SOP
- 2) Pelatihan ulang
- 3) Redesign proses kerja

g. Implementasi & Monitoring

Rekomendasi dilaksanakan dan efeknya dievaluasi secara berkala.

3. *Prinsip Non-Punitive Reporting*

Prinsip ini menekankan bahwa pelaporan insiden tidak boleh dijadikan dasar hukuman, kecuali pelanggaran berat seperti:

- a. Ketidakjujuran
- b. Pelanggaran etik
- c. Tindakan kriminal
- d. Konsumsi alkohol/obat terlarang saat bertugas

Tujuan utama non-punitive reporting:

- a. Mendorong staf untuk melapor tanpa takut dihukum.
- b. Meningkatkan jumlah pelaporan sehingga akar masalah dapat ditemukan.
- c. Membangun budaya keselamatan berbasis pembelajaran.
- d. Mengurangi budaya menyalahkan individu.

Karakteristik sistem non-punitive:

- a. Fokus pada perbaikan sistem, bukan kesalahan individu.
- b. Mengutamakan anonymity dan confidentiality bila memungkinkan.
- c. Menekankan kolaborasi, bukan kompetisi.
- d. Menghargai pelapor sebagai pihak yang berkontribusi pada keselamatan.

4. Contoh Formulir Pelaporan Insiden (Format Ringkas)

FORMULIR PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN

a. Informasi Umum

- 1) Tanggal & waktu kejadian:
- 2) Unit/ruangan:
- 3) Pelapor: (nama/jabatan, boleh anonim)

b. Jenis Insiden

- 1) Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)
- 2) Kejadian Nyaris Cedera (KNC)
- 3) Kejadian Tidak Cedera (KTC)
- 4) Sentinel Event

- c. Deskripsi Kejadian
Tuliskan kronologi lengkap, termasuk tahapan peristiwa.
- d. Dampak pada Pasien
 - 1) Tidak ada cedera
 - 2) Cedera ringan
 - 3) Cedera sedang
 - 4) Cedera berat
 - 5) Meninggal
- e. Tindakan Segera
Upaya stabilisasi pasien & langkah mitigasi awal.
- f. Analisis Awal (bila ada)
 - 1) Faktor manusia
 - 2) Faktor lingkungan
 - 3) Faktor sistem
 - 4) Faktor komunikasi
- g. Rekomendasi Perbaikan
Saran perubahan proses kerja/SOP.
- h. Verifikasi Tim Keselamatan Pasien
Ditandatangani oleh: Ketua Tim atau Komite Mutu.

E. Analisis Insiden Keselamatan Pasien

Analisis insiden keselamatan pasien bertujuan untuk mengungkap akar masalah, menemukan faktor kontribusi, serta merancang intervensi perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang. Proses analisis dilakukan secara sistematis, objektif, dan lintas profesi. Empat metode yang paling banyak digunakan secara internasional adalah *Root Cause Analysis (RCA)*, *Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)*, Analisis 5-Why, dan analisis faktor kontribusi.

1. Root Cause Analysis (RCA)

RCA adalah metode investigasi sistematis yang berfokus pada penyebab utama (root causes) dari sebuah insiden, bukan kesalahan individu. RCA digunakan terutama untuk kejadian serius atau sentinel event.

Tujuan RCA

- a. Mengidentifikasi akar masalah yang menyebabkan insiden terjadi.
- b. Menentukan perbaikan sistem yang berkelanjutan.
- c. Mencegah insiden yang sama terjadi kembali.

Tahapan RCA

- a. Pengumpulan Data
 - 1) Wawancara staf
 - 2) Observasi lokasi
 - 3) Telaah rekam medis
 - 4) Dokumentasi alat & prosedur
- b. Membuat Kronologi Waktu ("Timeline")
- c. Mengidentifikasi Masalah Utama
- d. Analisis Penyebab

Menggunakan tools seperti:

 - 1) Fishbone diagram (Ishikawa)
 - 2) 5-Why Analysis
- e. Menentukan Akar Penyebab (Root Cause)
- f. Menyusun Tindakan Perbaikan (Corrective Actions)

Harus bersifat: *specific, systemic, sustainable*.
- g. Monitoring & Evaluasi Perbaikan

Contoh Root Cause

- a. SOP tidak jelas
 - b. Komunikasi antar tim buruk
 - c. Pelatihan staf tidak memadai
 - d. Kelelahan staf (fatigue)
2. *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA)

FMEA adalah metode prospektif untuk mencegah kegagalan sebelum terjadi. Berbeda dengan RCA yang dilakukan setelah insiden, FMEA dilakukan sebelum proses diterapkan atau diperbaiki.

Tujuan FMEA

- a. Mengidentifikasi potensi kegagalan proses.
- b. Menilai risiko dari setiap kegagalan.
- c. Menentukan prioritas perbaikan.

Tahapan FMEA

- a. Memetakan Proses (flowchart)
- b. Mengidentifikasi Failure Mode

Bagaimana proses bisa gagal?
- c. Menilai Dampak (Severity), Probabilitas (Occurrence), dan Deteksi (Detection)
- d. Menghitung RPN (Risk Priority Number)
$$RPN = S \times O \times D$$

- e. Menentukan Prioritas Kegagalan
- f. Merencanakan Tindakan Pencegahan
- g. Implementasi & Evaluasi

Contoh Failure Mode

- a. Obat salah dosis
- b. Salah identifikasi pasien
- c. Keterlambatan triase
- d. Alarm monitor tidak berfungsi

3. Analisis 5-Why

Metode sederhana namun efektif untuk menggali penyebab mendalam dari suatu masalah dengan bertanya "Mengapa?" hingga menemukan akar masalah.

Cara Kerja 5-Why

- a. Tuliskan masalah yang terjadi.
- b. Ajukan pertanyaan "Mengapa?" untuk setiap jawaban.
- c. Ulangi sampai mencapai akar penyebab (biasanya 4–6 level).

Contoh 5-Why

Masalah: Obat diberikan ke pasien yang salah.

- a. Mengapa? → Identifikasi pasien tidak dilakukan.
- b. Mengapa? → Gelang pasien tidak diperiksa.
- c. Mengapa? → Proses verifikasi tidak diawasi.
- d. Mengapa? → Staf terburu-buru dan overload.
- e. Mengapa? → Jumlah perawat tidak sesuai beban kerja.

Root Cause: Kekurangan staf dan kurangnya pengawasan.

4. Penentuan Faktor Kontribusi

Penentuan faktor kontribusi membantu memahami penyebab tidak langsung yang memungkinkan insiden terjadi. Pendekatan ini digunakan oleh WHO dan National Patient Safety Agency (NPSA).

Kategori Faktor Kontribusi (WHO ICPS, 2009)

- a. Faktor Manusia
 - 1) Kelelahan
 - 2) Kompetensi
 - 3) Komunikasi
- b. Faktor Tugas/Proses
 - 1) SOP tidak jelas
 - 2) Alur kerja tidak efisien

- c. Faktor Tim
 - 1) Kerjasama buruk
 - 2) Tidak ada briefing/debriefing
- d. Faktor Lingkungan Kerja
 - 1) Suara bising
 - 2) Pencahayaan buruk
 - 3) Beban kerja tinggi
- e. Faktor Organisasi
 - 1) Kepemimpinan lemah
 - 2) Budaya menyalahkan
- f. Faktor Pasien
 - 1) Kondisi klinis kompleks
 - 2) Hambatan komunikasi
- g. Faktor Eksternal
 - 1) Kebijakan regulator
 - 2) Kekurangan obat/alat

Tujuan Analisis Faktor Kontribusi

- a. Menentukan perbaikan sistem yang paling berdampak.
- b. Mengurangi peluang insiden berulang.
- c. Menilai kesiapan organisasi dalam merespons masalah keselamatan.

F. Tindak Lanjut, Pembelajaran, dan Pencegahan Insiden

Tindak lanjut insiden keselamatan pasien merupakan rangkaian proses sistematis yang bertujuan memastikan perbaikan berkelanjutan (*continuous quality improvement*) terhadap mutu dan keamanan pelayanan. Kegiatannya meliputi intervensi perbaikan sistem, monitoring & evaluasi, audit keselamatan pasien, serta pembelajaran berbasis kasus untuk mencegah kejadian berulang.

1. Intervensi Perbaikan Sistem

Intervensi perbaikan harus bersifat sistemik, bukan hanya fokus pada individu, sesuai prinsip keselamatan pasien global.

Jenis Intervensi Sistem:

- a. Perbaikan Proses / SOP
 - 1) Revisi SOP yang tidak jelas atau tidak relevan.
 - 2) Penambahan langkah mitigasi risiko.
- b. Intervensi Desain Sistem
 - 1) Standardisasi peralatan (mis. syringe lock, warna label obat).
 - 2) Implementasi double-check atau barcode medication system.

- c. Peningkatan Kompetensi Staf
 - 1) Pelatihan komunikasi SBAR.
 - 2) Pelatihan clinical handover.
 - 3) Refreshing early warning system.
- d. Intervensi Teknologi
 - 1) Penggunaan decision-support system.
 - 2) Alarm management improvement.
- e. Intervensi Organisasi
 - 1) Penyesuaian rasio perawat–pasien.
 - 2) Pembentukan komite keselamatan pasien.

Prinsip Intervensi yang Efektif (WHO, 2009):

- a. Sistematis
 - b. Evidence-based
 - c. Feasible & sustainable
 - d. Mengurangi ketergantungan pada memori manusia
2. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Monev dilakukan untuk menilai efektivitas intervensi yang diterapkan dan memastikan peningkatan berkelanjutan.

Komponen Monitoring:

- a. Indikator keselamatan pasien, misalnya:
 - 1) Medication error rate
 - 2) Fall rate
 - 3) Pressure injury incidence
- b. Audit implementasi SOP
- c. Survei budaya keselamatan pasien

Cara Evaluasi:

- a. Evaluasi Proses
 - Apakah intervensi dijalankan sesuai rencana?
- b. Evaluasi Output
 - Apakah ada penurunan insiden?
- c. Evaluasi Outcome
 - Berdampak pada kualitas perawatan & kepuasan pasien?
- d. Evaluasi Dampak
 - Organisasi menjadi lebih aman?

Alat Monitoring:

- a. Dashboard mutu
- b. *Balanced scorecard*
- c. *Root Cause Analysis follow-up checklist*

3. *Audit Patient Safety*

Audit keselamatan pasien digunakan untuk menilai kesesuaian praktik dengan standar pelayanan.

Tujuan Audit:

- a. Mengidentifikasi gap antara praktik dan standar.
- b. Menilai area yang paling berisiko.
- c. Menghasilkan rekomendasi perbaikan.

Jenis Audit:

- a. Audit Kepatuhan Prosedur
 - 1) Identifikasi pasien
 - 2) Protokol pencegahan infeksi
- b. Audit Sentinel Event
- c. Audit Risiko Medikasi

Langkah Audit:

- a. Menetapkan standar & indikator
- b. Mengumpulkan data
- c. Membandingkan dengan standar
- d. Memberikan rekomendasi
- e. Menindaklanjuti perbaikan
- f. Re-audit

Audit menjadi alat utama dalam *clinical governance* dan *continuous improvement*.

4. *Pembelajaran Berbasis Kasus (Case-Based Learning)*

Pembelajaran berbasis kasus insiden (misalnya sentinel event, near miss) menjadi metode edukasi yang sangat efektif dalam membangun budaya keselamatan.

Tujuan CBL dalam Patient Safety:

- a. Meningkatkan kemampuan analisis klinis & manajerial.
- b. Melatih identifikasi risiko.
- c. Mengembangkan refleksi profesional.
- d. Mempromosikan budaya non-punitive.

Bentuk CBL yang Direkomendasikan:

- a. Studi kasus medication error
- b. Kasus near miss identifikasi pasien
- c. Kasus komunikasi SBAR yang tidak efektif
- d. Simulasi resusitasi dengan interupsi alur komunikasi
- e. Simulasi early warning system

Langkah CBL:

- a. Presentasi kasus
- b. Identifikasi masalah
- c. Analisis penyebab (RCA, 5-Why)
- d. Diskusi intervensi
- e. Penyusunan lesson learned
- f. Integrasi ke SOP atau intervensi baru

CBL yang baik harus menyertakan *debriefing* dan pembahasan moral, etika, serta sistem.

G. Arah Kebijakan dan Tantangan Masa Depan (Policy Direction and Future Challenges in Patient Safety)

Keselamatan pasien kini menjadi pilar utama mutu pelayanan kesehatan global. Berbagai regulasi internasional (WHO, Joint Commission International) dan nasional (Kemenkes RI) menekankan bahwa keselamatan pasien harus berorientasi sistem, bukan individu. Perubahan epidemiologi, teknologi digital, dan kompleksitas layanan membuat kebijakan keselamatan pasien perlu terus diperbarui.

1. Arah Kebijakan Masa Depan Keselamatan Pasien

a. Pendekatan Sistem (System-Based Approach)

Kebijakan global menekankan bahwa insiden keselamatan pasien adalah kegagalan sistem, bukan semata-mata human error.

Arah kebijakan:

- 1) Penguatan *safety culture* di seluruh unit.
- 2) Analisis akar masalah (Root Cause Analysis) sebagai standar.
- 3) Penekanan pada *learning organization*.

Referensi: WHO Global Patient Safety Action Plan 2021–2030 ; Kemenkes RI: Peraturan Menteri Kesehatan No. 11/2017 tentang Keselamatan Pasien.

b. Penguatan Tata Kelola Mutu dan Keselamatan Pasien

Fokus kebijakan masa depan:

- 1) Integrasi keselamatan pasien dengan mutu layanan.
- 2) Penilaian risiko terstruktur (Risk Assessment).

3) Peningkatan akreditasi berbasis kinerja (*performance-based accreditation*).

Strategi Kunci:

- 1) Pelaporan insiden wajib dan non-punitive reporting.
- 2) Penguatan Komite Mutu & Keselamatan.

Referensi: International Society for Quality in Health Care (ISQua) ; SNARS Edisi 1.2 (2022).

c. Transformasi Digital dalam Keselamatan Pasien

Transformasi digital akan menjadi kebijakan utama untuk dekade berikutnya.

Arah Kebijakan:

- 1) Rekam Medis Elektronik (RME) wajib dan interoperabilitas nasional.
- 2) Clinical Decision Support System (CDSS) untuk mengurangi error.
- 3) *Real-time monitoring* kejadian pasien.
- 4) Big data analytics untuk mengidentifikasi pola risiko.

Peran Teknologi:

- 1) Sistem barcode medication administration.
- 2) Telemedicine aman (secure & compliant).
- 3) AI untuk prediksi adverse events.

Referensi: WHO Digital Health Strategy (2020–2030) ; Kemenkes RI Transformasi Digital Kesehatan (2022).

d. Penguatan Kompetensi SDM Kesehatan

Kebijakan SDM akan diarahkan pada:

- 1) Kompetensi keselamatan pasien sebagai standar kompetensi profesi.
- 2) Pendidikan interprofesional (IPE) untuk mencegah kesenjangan komunikasi.
- 3) Pelatihan wajib: *TeamSTEPPS*, komunikasi SBAR, manajemen risiko, audit keselamatan.

Tantangan SDM:

- 1) Workload tinggi → meningkatkan error.
- 2) Burnout tenaga kesehatan.
- 3) Kurangnya tenaga analis mutu.

Referensi; WHO: Health Workforce 2030 ; ICN (International Council of Nurses) Guidelines on Patient Safety (2021).

e. Kolaborasi dan Partisipasi Pasien (Patient Engagement)

Future policy: pasien tidak hanya sebagai penerima layanan, tetapi *mitra keselamatan*.

Arah Kebijakan:

- 1) *Shared decision-making*.
- 2) Edukasi pasien sebagai bagian dari mitigasi risiko.
- 3) Akses informasi medis terbuka dan transparan.
- 4) Mekanisme pengaduan yang mudah dan responsif.

Referensi; WHO Patient Engagement Framework (2021) ; OECD: Empowered Patient Model (2020).

f. Keselamatan Pasien Berbasis Komunitas

Untuk Fasilitas Primer (Puskesmas), kebijakan diarahkan pada:

- 1) Integrasi keselamatan pasien ke program kesehatan keluarga.
- 2) Sistem rujukan aman.
- 3) Manajemen risiko pada home care dan telehealth.
- 4) Penguatan surveilans kejadian pasien primer.

Referensi: Primary Health Care: WHO Vision for PHC (2020) ; Kemenkes RI: Panduan Keselamatan Pasien Puskesmas (2021).

2. Tantangan Masa Depan Keselamatan Pasien

a. Kompleksitas Pelayanan dan Teknologi

- 1) Makin canggih teknologi → risiko teknis meningkat.
- 2) Banyaknya alat kesehatan digital → potensi cyber-risk.

b. Beban Kerja dan Burnout Tenaga Kesehatan

- 1) Kaitan langsung dengan adverse events.
- 2) Tantangan: rasio tenaga kesehatan masih rendah.

c. Budaya Tidak Menyalahkan (No-Blame Culture) Belum Optimal

- 1) Pelaporan insiden masih rendah.
- 2) Masih ada ketakutan sanksi.

d. Literasi Pasien yang Rendah

Banyak kasus error terkait kurangnya pemahaman pasien terkait obat, pemeriksaan, dan prosedur.

e. Infrastruktur Informasi Kesehatan Belum Merata

- 1) Transformasi digital belum merata hingga Puskesmas pelosok.
- 2) Akses internet dan perangkat masih menjadi hambatan.

f. Variasi Kompetensi Fasilitas Kesehatan

RS besar vs RS kecil → gap signifikan dalam kualitas implementasi patient safety.

- g. Pembiayaan dan Regulasi
 - 1) Program patient safety membutuhkan sumber daya besar.
 - 2) Insentif untuk mutu dan keselamatan masih terbatas.
- 3. Peluang Masa Depan
 - a. Integrasi AI dan Predictive Analytics
 - 1) Deteksi dini kejatuhan pasien.
 - 2) Prediksi risiko medication error.
 - 3) Monitoring otomatis tanda vital.
 - b. *Value-Based Care*
Pembiayaan berbasis mutu → meningkatkan fokus pada keselamatan.
 - c. *Harm-Reduction Policies*
Target WHO: "Zero Preventable Harm by 2030".
 - d. Keterlibatan Komunitas & Kebijakan Publik
Edukasi publik → meningkatkan kontrol dan kesadaran.

H. Penutup

Identifikasi dan klasifikasi insiden keselamatan pasien merupakan fondasi utama dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang aman. Tanpa proses identifikasi yang tepat, insiden tidak akan terdeteksi; tanpa klasifikasi yang benar, akar masalah tidak dapat dianalisis; dan tanpa pelaporan yang konsisten, fasilitas kesehatan kehilangan peluang untuk belajar serta mencegah kejadian berulang. Melalui penggunaan sistem klasifikasi nasional maupun kerangka ICPS (International Classification for Patient Safety), organisasi mampu memahami jenis, faktor penyebab, hingga tingkat keparahan insiden secara lebih terstruktur. Hal ini memungkinkan pemetaan risiko yang lebih akurat, pengembangan intervensi yang relevan, serta implementasi strategi pencegahan yang efektif di rumah sakit, puskesmas, maupun fasilitas layanan dasar. Kepatuhan pada mekanisme identifikasi dini, penggunaan alat deteksi seperti SBAR, Early Warning Score, checklist prosedur, serta keterlibatan tim lintas profesi memperkuat budaya keselamatan yang non-punitif. Dengan demikian, setiap insiden bukan dipandang sebagai kesalahan individu, tetapi sebagai peluang pembelajaran sistem. Ke depan, tantangannya mencakup integrasi teknologi digital, peningkatan kapasitas SDM, harmonisasi regulasi, dan penguatan kepemimpinan dalam mengawal budaya keselamatan. Namun dengan komitmen bersama, penerapan klasifikasi insiden yang standar, serta proses tindak lanjut berbasis pembelajaran, upaya "zero preventable harm" dapat semakin nyata diwujudkan.

Referensi

- Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). (2020). *Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) Toolkit*.
- Donaldson, L., & Kelley, E. (2021). Patient safety: A global priority. *The Lancet*, 398(10304), 170–185.
- Huber, D. *Leadership and Nursing Care Management*. 8th ed. St. Louis: Elsevier; 2025.
- IHI – Institute for Healthcare Improvement. (2021). *Framework for Safe & Reliable Care*.
- Institute for Healthcare Improvement (IHI). (2021). *Root Cause Analysis and Action (RCA2)*. Boston: IHI.
- International Council of Nurses (ICN). *Nursing Safety and Workforce Report*. 2021.
- International Society for Quality in Healthcare (ISQua). *Patient Safety and Quality Framework*. 2022.
- Joint Commission International. (2021). *Patient safety event reporting guidelines*.
- Joint Commission International. (2021). *Sentinel Event Policy and Procedures*.
- Kemenkes RI (2022). *Transformasi Digital Kesehatan Nasional*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2017). *Pedoman keselamatan pasien rumah sakit (Patient Safety)*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Pedoman Keselamatan Pasien Rumah Sakit (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. *Permenkes No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien*
- Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). (2021). *Standar Akreditasi Rumah Sakit: SNARS Edisi 1.1. KARS*.
- Ministry of Health Indonesia. (2020). *Pedoman Pelaporan dan Pembelajaran Insiden Keselamatan Pasien*
- Mira, J. J., et al. (2020). Learning from patient safety incidents: Strategies for reporting and analysis. *BMJ Quality & Safety*, 29(1), 29–40
- National Patient Safety Agency (NPSA). (2020). *Contributory Factors Classification Framework*.
- OECD. (2020). *The Economics of Patient Safety*. OECD Publishing.
- Open RN. *Nursing Management and Professional Concepts*. Wisconsin Technical College System; 2024.
- SNARS Edisi 1.2. *Standar Akreditasi Rumah Sakit*. 2022.
- Sorrentino, S. A., Remmert, L., & Wilk, M. J. (2020). *Nursing management and professional concepts (2nd ed.)*. Elsevier.

- Turner, S., et al. (2022). Improving patient safety culture through incident reporting: A systematic review. *BMC Health Services Research*, 22(1), 115.
- WHO. Primary Health Care: Operational Framework. 2020.
- World Health Organization. (2009). The conceptual framework for the international classification for patient safety (ICPS): Final technical report
- World Health Organization*. (2019). International Classification for Patient Safety (ICPS). WHO.
- World Health Organization*. (2021). Global Patient Safety Action Plan 2021–2030. WHO Press.
- World Health Organization*. Digital Health Strategy 2020–2030. WHO; 2021.

Glosarium

A

Adverse Event (Kejadian Tidak Diharapkan): adalah Insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien akibat tindakan atau sistem pelayanan kesehatan, bukan karena kondisi penyakit.

Audit Patient Safety: Proses evaluasi sistematis terhadap pelaksanaan standar keselamatan pasien untuk menilai kepatuhan, efektivitas, dan peluang perbaikan.

Area Risiko Utama: Kelompok proses pelayanan kesehatan yang memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya insiden, seperti medikasi, transfusi, pembedahan, identifikasi pasien, dan pelayanan diagnostik.

E

Early Warning Score (EWS): adalah Alat penilaian dini untuk mendeteksi perubahan kondisi klinis pasien dan mencegah terjadinya penurunan status yang tidak terdeteksi.

F

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA): adalah Metode analisis proaktif untuk mengidentifikasi potensi kegagalan pada proses sebelum insiden terjadi serta menentukan prioritas risiko.

Five Rights of Delegation : Prinsip delegasi tugas keperawatan yang aman: right task, right circumstance, right person, right direction/communication, dan right supervision/evaluation.

Formulir Pelaporan Insiden : Dokumen standar untuk mencatat kejadian, kondisi sekitar, kronologi, dan tindakan awal terhadap insiden keselamatan pasien.

H

Harm Level (Level Keparahan) : Kategori yang menggambarkan tingkat dampak insiden pada pasien, mulai dari tidak ada cedera hingga kematian.

I

ICPS (International Classification for Patient Safety) : Kerangka klasifikasi global dari WHO yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, dan mengkategorikan insiden keselamatan pasien.

Identifikasi Pasien : Proses memastikan identitas pasien secara benar menggunakan dua identitas (misal: nama dan tanggal lahir) untuk mencegah kesalahan tindakan.

Incident Reporting System : Sistem formal di fasilitas kesehatan untuk mencatat, mengelola, dan menganalisis pelaporan insiden keselamatan pasien.

Insiden Keselamatan Pasien (Patient Safety Incident) : Setiap kejadian atau kondisi yang berpotensi atau telah menyebabkan bahaya terhadap pasien akibat proses pelayanan.

K

Kejadian Hampir Cedera (Near Miss) : Insiden yang hampir menyebabkan cedera tetapi tidak terjadi karena keberuntungan, deteksi dini, atau intervensi cepat.

Kejadian Sentinel (Sentinel Event) : Insiden yang mengakibatkan cedera serius, kematian, atau risiko tinggi dan membutuhkan investigasi mendalam segera.

Kultur Non-Punitif (Non-Punitive Culture) : Budaya organisasi yang mendorong pelaporan insiden tanpa takut disalahkan, sehingga fokus pada perbaikan sistem, bukan kesalahan individu.

M

Mechanism of Early Detection (Mekanisme Deteksi Dini) : Sistem atau prosedur untuk mengidentifikasi potensi risiko atau insiden sedini mungkin, termasuk observasi klinis dan alat skrining.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) : Upaya memantau implementasi tindakan perbaikan dan menilai efektivitas strategi pencegahan insiden.

P

Patient Safety Goals (Sasaran Keselamatan Pasien) : Enam tujuan keselamatan nasional/internasional untuk meminimalkan risiko insiden dalam pelayanan kesehatan.

Pelaporan Internal & Eksternal : Proses pelaporan ke unit internal fasilitas kesehatan dan ke lembaga eksternal (misal: KKP-RS, Dinas Kesehatan) sesuai regulasi.

R

Rekomendasi Perbaikan Sistem : Rangkaian tindakan atau perubahan pada proses kerja untuk mencegah insiden serupa terjadi lagi.

Root Cause Analysis (RCA) : Metode analisis reaktif untuk mengidentifikasi penyebab dasar insiden setelah kejadian terjadi.

S

SBAR(*Situation-Background-Assessment-Recommendation*) : Metode komunikasi efektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara jelas, sistematis, dan aman.

T

Tindak Lanjut Insiden : Upaya penanganan pascakejadian, termasuk evaluasi, edukasi, monitoring, dan penerapan strategi perbaikan.

Tim Mutu & Keselamatan Pasien : Kelompok lintas profesi yang bertanggung jawab mengelola program keselamatan pasien, termasuk investigasi dan pencegahan insiden.

W

WHO Patient Safety Framework : Kerangka global yang digunakan untuk meningkatkan keamanan pasien melalui standar, kebijakan, dan praktik terbaik.

BAB 3

MANAJEMEN RISIKO DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN

A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan modern menuntut terselenggaranya asuhan yang tidak hanya efektif, tetapi juga aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien (*patient safety*). Dalam konteks ini, praktik keperawatan memegang peranan yang sangat strategis, mengingat perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi langsung dengan pasien selama 24 jam. Intensitas interaksi tersebut menempatkan perawat sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dini perubahan kondisi pasien, sekaligus dalam mencegah dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat terjadi selama proses pelayanan kesehatan (*Agency for Healthcare Research and Quality* [AHRQ], 2022; *World Health Organization* [WHO], 2023).

Keselamatan pasien saat ini telah menjadi isu global yang mendapat perhatian serius dari berbagai organisasi kesehatan internasional. Laporan terbaru menunjukkan bahwa kejadian tidak diharapkan (*adverse events*) masih menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya di negara berkembang. Diperkirakan sekitar satu dari sepuluh pasien mengalami kejadian yang sebenarnya dapat dicegah selama menjalani perawatan di rumah sakit. Sebagian besar kejadian tersebut berkaitan dengan kelemahan sistem, seperti kegagalan komunikasi, proses pelayanan yang tidak optimal, serta faktor organisasi yang kompleks (WHO, 2023; *National Academy of Medicine*, 2022). Hal ini menegaskan bahwa risiko dalam pelayanan kesehatan tidak hanya bersumber dari individu, tetapi merupakan hasil interaksi berbagai komponen dalam sistem pelayanan.

Dalam praktik keperawatan, risiko dapat muncul pada setiap tahapan proses asuhan, mulai dari pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Risiko tersebut dapat berupa kesalahan pemberian obat (*medication error*), infeksi terkait pelayanan kesehatan (*healthcare-associated infections*), kejadian pasien jatuh, cedera akibat penggunaan alat medis, hingga kesalahan komunikasi antar tenaga kesehatan. Jika tidak dikelola secara sistematis, risiko-risiko tersebut dapat berkembang menjadi insiden keselamatan pasien yang berdampak serius, baik terhadap kondisi pasien maupun terhadap aspek hukum dan profesional tenaga kesehatan (AHRQ, 2022; Carayon et al., 2020).

Manajemen risiko merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian. Dalam pelayanan kesehatan, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pencegahan kesalahan, tetapi juga pada penguatan sistem pelayanan agar lebih aman dan andal. Perspektif modern dalam keselamatan pasien menekankan bahwa sebagian besar kesalahan dalam pelayanan kesehatan bukan semata-mata disebabkan oleh individu, melainkan akibat kelemahan sistem yang memungkinkan terjadinya kesalahan (*system failure*) (Reason, 2000; Carayon et al., 2020). Oleh karena itu, manajemen risiko harus dipahami sebagai bagian integral dari upaya peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan standar akreditasi, baik di tingkat nasional maupun internasional, penerapan manajemen risiko menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian mutu pelayanan kesehatan. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) dan *Joint Commission International* (JCI) menekankan pentingnya sistem pelaporan insiden, analisis akar masalah, serta implementasi perbaikan berkelanjutan yang melibatkan seluruh tenaga kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko bukan hanya menjadi tanggung jawab manajemen rumah sakit, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif yang harus terintegrasi dalam praktik klinis sehari-hari (JCI, 2021; Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Perawat memiliki peran kunci dalam implementasi manajemen risiko karena keterlibatannya secara langsung dalam pemberian asuhan kepada pasien. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada tindakan klinis, tetapi juga mencakup pengkajian risiko, dokumentasi, pelaporan insiden, serta partisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan perbaikan sistem. Selain itu, perawat juga berperan penting dalam membangun budaya keselamatan pasien (*patient safety culture*), yang menekankan komunikasi terbuka, pelaporan tanpa rasa takut (*no blame culture*), serta pembelajaran berkelanjutan dari setiap insiden yang terjadi (Vaismoradi et al., 2020; Alquwez et al., 2021).

Meskipun demikian, implementasi manajemen risiko dalam praktik keperawatan masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja yang tinggi, kurangnya pelatihan, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung keselamatan pasien menjadi hambatan yang sering ditemui di lapangan. Selain itu, fenomena *underreporting* terhadap insiden keselamatan pasien masih sering terjadi, sehingga menghambat proses pembelajaran organisasi dan perbaikan sistem secara optimal (Alquwez et al., 2021; AHRQ, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, proses, serta implementasi manajemen risiko dalam praktik keperawatan. Pemahaman ini tidak hanya penting bagi perawat pelaksana, tetapi juga bagi perawat manajer, pendidik, dan pengambil kebijakan dalam upaya meningkatkan mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Bab ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis mengenai manajemen risiko dalam praktik keperawatan, meliputi konsep dasar, kerangka teori, jenis risiko, proses manajemen risiko, implementasi dalam asuhan keperawatan, peran perawat, serta strategi peningkatan keselamatan pasien. Dengan pemahaman yang komprehensif dan penerapan yang konsisten, diharapkan perawat mampu berkontribusi secara optimal dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

B. Konsep Dasar Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan komponen esensial dalam sistem pelayanan kesehatan yang berperan penting dalam menjamin keselamatan pasien sekaligus meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan. Dalam praktik keperawatan, manajemen risiko tidak lagi dipandang semata sebagai upaya menghindari kesalahan, tetapi berkembang menjadi pendekatan yang proaktif dan sistematis dalam mengidentifikasi potensi bahaya, mencegah kejadian tidak diharapkan, serta memperkuat sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh (*Agency for Healthcare Research and Quality [AHRQ], 2022; World Health Organization [WHO], 2023*).

Pendekatan ini menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama, sekaligus menegaskan bahwa kualitas pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kemampuan organisasi dalam mengelola risiko secara efektif.

1. Definisi Manajemen Risiko dalam Pelayanan Kesehatan

Manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan dapat didefinisikan sebagai proses sistematis yang meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko yang berpotensi memengaruhi keselamatan pasien, tenaga kesehatan, maupun organisasi pelayanan kesehatan (*International Organization for Standardization [ISO], 2018; WHO, 2023*).

Dalam konteks keperawatan, manajemen risiko merupakan bagian integral dari praktik profesional yang bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya cedera atau kerugian selama proses asuhan keperawatan. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara terstruktur, berbasis sistem, serta berorientasi pada pencegahan, bukan sekadar respons terhadap insiden yang telah terjadi (Carayon et al., 2020).

Dengan demikian, manajemen risiko dalam keperawatan dapat dipahami sebagai:

- a. Upaya yang bersifat proaktif sekaligus reaktif
- b. Pendekatan yang berfokus pada sistem dan proses
- c. Strategi untuk meningkatkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan

2. Tujuan dan Prinsip Manajemen Risiko

a. Tujuan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko dalam praktik keperawatan memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

- 1) Mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien
- 2) Mengurangi dampak kejadian tidak diharapkan
- 3) Meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan
- 4) Meningkatkan kepercayaan pasien terhadap layanan kesehatan
- 5) Mendukung pencapaian standar akreditasi (SNARS, JCI)
- 6) Membangun budaya keselamatan pasien (*patient safety culture*)

Tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajemen risiko tidak hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi juga pada kepercayaan publik dan keberlanjutan organisasi pelayanan kesehatan.

b. Prinsip Manajemen Risiko

Prinsip manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan mengacu pada kerangka ISO 31000 yang dikombinasikan dengan pendekatan keselamatan pasien modern. Prinsip tersebut meliputi:

- 1) Berorientasi pada keselamatan pasien
- 2) Menggunakan pendekatan sistem (*system-based approach*)
- 3) Berbasis data dan bukti (*evidence-based*)
- 4) Bersifat proaktif dan berkelanjutan
- 5) Melibatkan seluruh tenaga kesehatan (*interprofessional collaboration*)
- 6) Mendorong budaya terbuka dan tidak menyalahkan (*just culture*)

Prinsip ini menegaskan bahwa risiko dalam pelayanan kesehatan tidak dapat dikelola secara individual, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh komponen organisasi. Budaya keselamatan yang kuat menjadi fondasi utama dalam keberhasilan implementasi manajemen risiko (Vaismoradi et al., 2020; *National Academy of Medicine*, 2022).

3. Terminologi Penting dalam Manajemen Risiko

Pemahaman terhadap terminologi dasar sangat penting agar seluruh tenaga kesehatan memiliki persepsi yang sama dalam mengelola risiko.

a. *Hazard* (Bahaya)

Hazard adalah segala kondisi atau faktor yang berpotensi menyebabkan cedera, kerugian, atau dampak negatif terhadap pasien, tenaga kesehatan, maupun lingkungan pelayanan kesehatan (WHO, 2023).

Contoh:

- 1) Lantai licin
- 2) Alat medis tidak steril
- 3) Kesalahan label obat

b. Risiko

Risiko merupakan kombinasi antara kemungkinan terjadinya suatu kejadian dan tingkat keparahan dampak yang ditimbulkan (ISO, 2018). Sehingga secara sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut:

Risiko = Probabilitas kejadian × Dampak

c. Insiden Keselamatan Pasien

Insiden keselamatan pasien adalah setiap kejadian atau kondisi yang dapat menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera yang dapat dicegah pada pasien (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Berikut ini table klasifikasinya:

Tabel 3.1
Klasifikasi Insiden Keselamatan Pasien

Jenis Insiden	Definisi	Contoh
KNC (Kejadian Nyaris Cedera)	Insiden belum mencapai pasien	Obat salah dosis terdeteksi sebelum diberikan
KTC (Kejadian Tidak Cedera)	Insiden terjadi tetapi tidak menimbulkan cedera	Pasien menerima obat salah tetapi tanpa efek
KPC (Kejadian Potensial Cedera)	Kondisi yang berpotensi menimbulkan cedera	Label obat tidak jelas
KTD (Kejadian Tidak Diharapkan)	Insiden menyebabkan cedera	Reaksi alergi akibat kesalahan obat
Sentinel Event	Insiden serius yang menyebabkan kematian atau kecacatan permanen	Operasi pada sisi yang salah

Sumber: Kemenkes RI (2022), WHO (2021)

4. Siklus Manajemen Risiko (*Risk Management Cycle*)

Manajemen risiko dilaksanakan melalui suatu siklus berkelanjutan yang dikenal sebagai *Risk Management Cycle*, yang meliputi beberapa tahapan sistematis.

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan tahap awal yang sangat krusial karena menjadi dasar bagi seluruh proses manajemen risiko selanjutnya. Tahap ini bertujuan untuk menemukan, mengenali, dan mendeskripsikan berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi keselamatan pasien maupun tenaga kesehatan (ISO, 2018; WHO, 2023).

Dalam praktik keperawatan, identifikasi risiko tidak hanya berfokus pada kejadian yang telah terjadi, tetapi juga pada potensi kejadian yang mungkin terjadi di masa depan. Pendekatan ini bersifat proaktif dan memungkinkan tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan pencegahan sebelum risiko berkembang menjadi insiden (Carayon et al., 2020).

Pendekatan modern menunjukkan bahwa sebagian besar insiden keselamatan pasien sebenarnya dapat dicegah jika potensi risiko diidentifikasi sejak dini melalui sistem yang baik dan budaya keselamatan yang kuat (AHRQ, 2022).

Metode identifikasi:

1) Observasi Langsung (*Direct Observation*)

Observasi langsung merupakan metode identifikasi risiko yang dilakukan dengan cara mengamati secara sistematis kondisi lingkungan, proses kerja, serta interaksi antara tenaga kesehatan dan pasien di unit pelayanan. Melalui observasi langsung, perawat dapat mengidentifikasi berbagai potensi bahaya seperti:

- Lingkungan yang tidak aman (lantai licin, pencahayaan kurang)
- Ketidakesesuaian prosedur (tidak melakukan hand hygiene)
- Kesalahan penggunaan alat medis

Menurut Carayon et al. (2020), observasi langsung merupakan salah satu metode paling efektif dalam mengidentifikasi risiko karena memungkinkan deteksi terhadap kesenjangan antara prosedur standar dan praktik aktual di lapangan. Selain itu, metode ini juga dapat mengungkap faktor sistemik seperti beban kerja, desain lingkungan kerja, dan alur komunikasi yang berpotensi menimbulkan kesalahan.

WHO (2021) juga menekankan bahwa observasi langsung sangat penting dalam pendekatan Human Factors Engineering, yang bertujuan untuk memahami interaksi antara manusia, sistem, dan lingkungan kerja dalam pelayanan kesehatan.

2) Audit Klinis (Clinical Audit)

Audit klinis adalah proses sistematis untuk mengevaluasi kesesuaian praktik klinis dengan standar yang telah ditetapkan, seperti standar prosedur operasional (SPO), *clinical pathway*, dan pedoman praktik berbasis bukti (NICE, 2020).

Dalam konteks manajemen risiko, audit klinis digunakan untuk:

- Mengidentifikasi deviasi dari standar pelayanan
- Menemukan potensi risiko yang tidak terdeteksi dalam praktik rutin
- Menilai kepatuhan tenaga kesehatan terhadap protokol keselamatan pasien

Sebagai contoh, audit terhadap pemberian obat dapat mengidentifikasi risiko *medication error*, seperti kesalahan dosis, waktu pemberian, atau pasien yang tidak sesuai.

Menurut *Agency for Healthcare Research and Quality* (AHRQ, 2022), audit klinis merupakan alat penting dalam meningkatkan keselamatan pasien karena mampu mengidentifikasi area yang berisiko tinggi serta memberikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Audit juga berperan dalam mendukung budaya keselamatan dengan menyediakan data objektif yang dapat digunakan untuk evaluasi sistem.

3) Pelaporan Insiden (Incident Reporting System)

Pelaporan insiden merupakan metode identifikasi risiko yang dilakukan melalui pencatatan dan pelaporan kejadian yang berkaitan dengan keselamatan pasien, baik yang sudah terjadi maupun yang hampir terjadi.

Jenis insiden yang dilaporkan meliputi:

- Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)
- Kejadian Nyaris Cedera (KNC)
- Kejadian Tidak Cedera (KTC)
- Kejadian Potensial Cedera (KPC)

Menurut WHO (2021), sistem pelaporan insiden merupakan komponen utama dalam manajemen risiko karena memungkinkan organisasi untuk:

- Mengidentifikasi pola kejadian
- Menganalisis akar penyebab masalah
- Mengembangkan strategi pencegahan

AHRQ (2022) menambahkan bahwa pelaporan insiden yang efektif harus didukung oleh budaya non-punitif (*no blame culture*), di mana tenaga kesehatan tidak takut untuk melaporkan kesalahan. Hal ini penting karena

underreporting masih menjadi masalah utama dalam sistem keselamatan pasien (Alquwez et al., 2021).

Selain itu, data dari pelaporan insiden dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan *Root Cause Analysis* (RCA) untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

4) Diskusi Tim (Briefing dan Debriefing)

Diskusi tim merupakan metode identifikasi risiko yang dilakukan melalui komunikasi antar anggota tim kesehatan, baik sebelum (*briefing*) maupun setelah (*debriefing*) pelaksanaan tindakan atau pelayanan.

- *Briefing* dilakukan sebelum tindakan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan merencanakan langkah pencegahan
- *Debriefing* dilakukan setelah tindakan untuk mengevaluasi kejadian dan mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi

Menurut Salas et al. (2020), *briefing* dan *debriefing* merupakan bagian penting dari *team communication strategy* yang efektif dalam meningkatkan keselamatan pasien. Diskusi tim memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara terbuka, sehingga risiko yang mungkin terlewatkan oleh individu dapat diidentifikasi secara kolektif.

WHO (2021) juga menegaskan bahwa komunikasi tim yang efektif merupakan salah satu faktor kunci dalam mencegah kesalahan medis, terutama dalam situasi kompleks seperti tindakan operasi, perawatan intensif, dan kegawatdaruratan. Dalam praktik keperawatan, diskusi tim dapat dilakukan dalam bentuk:

- Handover pasien
- Ronde keperawatan
- Safety briefing harian
- Evaluasi kasus

Contoh:

- Risiko jatuh pada pasien lansia
- Risiko *medication error*

b. Analisis Risiko

Analisis risiko merupakan tahap lanjutan setelah identifikasi risiko yang bertujuan untuk memahami karakteristik risiko secara lebih mendalam. Pada tahap ini dilakukan penilaian sistematis terhadap faktor penyebab, frekuensi kejadian, serta dampak yang mungkin ditimbulkan dari suatu risiko. Analisis

risiko menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan serta strategi pengendalian yang tepat (ISO 31000, 2018; WHO, 2021).

Dalam pelayanan kesehatan, khususnya praktik keperawatan, analisis risiko sangat penting karena tidak semua risiko memiliki tingkat urgensi yang sama. Beberapa risiko mungkin memiliki frekuensi rendah tetapi berdampak fatal (misalnya *sentinel event*), sementara risiko lain mungkin sering terjadi tetapi berdampak ringan. Oleh karena itu, analisis risiko membantu tenaga kesehatan dalam memfokuskan sumber daya pada risiko yang paling signifikan (AHRQ, 2022).

Menurut WHO (2021), analisis risiko harus dilakukan secara sistematis dan berbasis data, serta melibatkan pendekatan multidisiplin untuk memastikan bahwa seluruh faktor yang berkontribusi terhadap risiko dapat diidentifikasi secara komprehensif.

Komponen Analisis Risiko

Dalam proses analisis risiko, terdapat tiga komponen utama yang perlu dikaji secara mendalam

1) Penyebab risiko (*Cause Analysis*)

Analisis penyebab risiko bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya suatu kejadian. Dalam konteks pelayanan kesehatan, penyebab risiko umumnya bersifat multifaktorial dan melibatkan interaksi antara manusia, sistem, dan lingkungan kerja. Menurut Carayon et al. (2020), faktor penyebab risiko dalam pelayanan kesehatan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, antara lain:

- Faktor manusia (human factors): kelelahan, kurangnya kompetensi, kesalahan komunikasi
- Faktor sistem: SOP yang tidak jelas, alur kerja yang kompleks
- Faktor lingkungan: kondisi ruangan, kebisingan, pencahayaan
- Faktor organisasi: budaya kerja, kepemimpinan, beban kerja

Pendekatan modern dalam keselamatan pasien menekankan bahwa kesalahan tidak semata-mata disebabkan oleh individu, tetapi lebih sering merupakan akibat dari kegagalan sistem (Reason, 2000; Carayon et al., 2020).

2) Frekuensi kejadian (*Likelihood/Frequency*)

Frekuensi atau likelihood mengacu pada seberapa sering suatu risiko dapat terjadi dalam periode tertentu. Penilaian frekuensi penting untuk menentukan probabilitas kejadian, yang menjadi salah satu komponen utama dalam penilaian tingkat risiko.

Menurut ISO 31000 (2018), frekuensi risiko dapat dikategorikan dalam beberapa tingkat, seperti:

- Sangat jarang (*rare*)
- Jarang (*unlikely*)
- Mungkin terjadi (*possible*)
- Sering (*likely*)
- Sangat sering (*almost certain*)

Dalam praktik keperawatan, data frekuensi dapat diperoleh dari:

- Sistem pelaporan insiden
- Audit klinis
- Data mutu pelayanan

AHRQ (2022) menyatakan bahwa penggunaan data historis sangat penting dalam menilai frekuensi risiko secara objektif, sehingga keputusan yang diambil lebih berbasis bukti (*evidence-based*).

3) Dampak yang mungkin terjadi (*Severity/Consequence*)

Dampak risiko mengacu pada tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan jika risiko tersebut terjadi. Dampak dapat bersifat klinis, psikologis, finansial, maupun reputasi organisasi. Menurut WHO (2021), dampak risiko dalam pelayanan kesehatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Ringan (tidak menimbulkan cedera)
- Sedang (cedera ringan, membutuhkan intervensi)
- Berat (cedera serius, memperpanjang masa rawat)
- Sangat berat (kematian atau kecacatan permanen)

Penilaian dampak sangat penting karena risiko dengan dampak tinggi harus menjadi prioritas utama meskipun frekuensinya rendah. Hal ini sejalan dengan prinsip keselamatan pasien yang menempatkan pencegahan kejadian fatal sebagai prioritas utama (AHRQ, 2022).

Metode Analisis Risiko

Dalam praktik pelayanan kesehatan, terdapat dua metode utama yang sering digunakan dalam analisis risiko, yaitu *Root Cause Analysis* (RCA) dan *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA).

4) *Root Cause Analysis* (RCA)

Root Cause Analysis (RCA) adalah metode analisis retrospektif yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu insiden yang telah terjadi. Tujuan utama RCA adalah untuk memahami mengapa suatu

kejadian terjadi dan mencegah kejadian serupa di masa depan (WHO, 2021).

RCA biasanya digunakan pada:

- Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)
- Sentinel event
- Insiden serius lainnya

Menurut AHRQ (2022), langkah-langkah dalam RCA meliputi:

- Mengidentifikasi kejadian
- Mengumpulkan data dan fakta
- Membuat kronologi kejadian
- Mengidentifikasi faktor penyebab
- Menentukan akar penyebab
- Menyusun rencana perbaikan

Pendekatan RCA menekankan analisis sistem, bukan menyalahkan individu. Hal ini sejalan dengan konsep *no blame culture*, yang bertujuan untuk mendorong pembelajaran organisasi (Vaismoradi et al., 2020).

Contoh: Kesalahan pemberian obat tidak hanya disebabkan oleh perawat, tetapi dapat dipengaruhi oleh:

- Label obat yang mirip
- Sistem distribusi obat
- Kurangnya double check



Gambar 3.1. Alur Analisis Akar Masalah

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan konsep *Root Cause Analysis* (AHRQ, 2022)

5) *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA)

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) adalah metode analisis prospektif yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan sebelum kejadian terjadi. Metode ini bertujuan untuk mencegah risiko dengan cara mengantisipasi kemungkinan kesalahan dalam suatu proses (*Joint Commission International* [JCI], 2021). FMEA biasanya digunakan untuk:

- Proses baru
- Perubahan sistem
- Area dengan risiko tinggi

Menurut JCI (2021), langkah-langkah FMEA meliputi:

- Mengidentifikasi proses yang akan dianalisis
- Mengidentifikasi kemungkinan kegagalan (*failure modes*)
- Menentukan penyebab kegagalan
- Menilai dampak kegagalan
- Menghitung Risk Priority Number (RPN)
- Menentukan tindakan pencegahan

FMEA menekankan pendekatan proaktif, sehingga sangat efektif dalam meningkatkan keselamatan pasien sebelum insiden terjadi (WHO, 2021).

Contoh: Dalam proses pemberian obat:

- Failure mode: salah dosis
- Penyebab: tidak ada verifikasi
- Dampak: efek samping serius
- Solusi: penerapan double check system

c. Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko merupakan tahap dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk menentukan tingkat prioritas risiko berdasarkan kombinasi antara kemungkinan terjadinya (*likelihood*) dan tingkat keparahan dampak (*severity*). Tahap ini sangat penting karena tidak semua risiko memiliki tingkat urgensi yang sama, sehingga diperlukan suatu metode untuk memprioritaskan risiko yang harus segera ditangani (ISO 31000, 2018; WHO, 2021). Dalam praktik keperawatan, evaluasi risiko membantu perawat dan manajemen pelayanan kesehatan untuk:

- 1) Menentukan risiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu
- 2) Mengalokasikan sumber daya secara efektif
- 3) Menghindari fokus yang berlebihan pada risiko dengan dampak rendah

Menurut AHRQ (2022), evaluasi risiko yang baik memungkinkan organisasi pelayanan kesehatan untuk meminimalkan kejadian serius dengan pendekatan berbasis prioritas dan data.

Risk Matrix sebagai Alat Evaluasi Risiko

Salah satu metode yang paling umum digunakan dalam evaluasi risiko adalah *risk matrix*, yaitu alat yang menggabungkan tingkat kemungkinan dan dampak untuk menghasilkan kategori tingkat risiko.

Risk matrix biasanya mengelompokkan risiko menjadi:

- 1) Risiko rendah (low risk)
- 2) Risiko sedang (moderate risk)
- 3) Risiko tinggi (high risk)

Pendekatan ini memudahkan pengambilan keputusan dalam menentukan tindakan pengendalian yang tepat (WHO, 2021).

Tabel 3.2
Matriks Penilaian Risiko (Risk Matrix)

Dampak / Probabilitas	Sangat Jarang	Jarang	Mungkin	Sering	Sangat Sering
Ringan	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
Berat	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
Sangat Berat	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber: Adaptasi dari WHO (2021) dan ISO 31000 (2018)

Interpretasi Risk Matrix

- 1) Risiko rendah → dapat diterima, cukup dimonitor
- 2) Risiko sedang → memerlukan pengendalian terencana
- 3) Risiko tinggi → harus segera dilakukan tindakan korektif
- 4) Risiko sangat tinggi → prioritas utama, perlu intervensi segera

Dalam praktik keperawatan, contoh penerapan evaluasi risiko:

- 1) Risiko jatuh pasien lansia dengan skor tinggi → prioritas intervensi
- 2) Risiko kesalahan dokumentasi → prioritas lebih rendah

Evaluasi risiko memungkinkan perawat untuk bekerja secara prioritas-based care, yang sangat penting dalam situasi keterbatasan sumber daya (Carayon et al., 2020).

d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko merupakan tahap dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk mengurangi, menghilangkan, atau mengendalikan risiko agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Tahap ini merupakan implementasi nyata dari hasil identifikasi dan analisis risiko (WHO, 2021).

Dalam pelayanan kesehatan, pengendalian risiko harus dilakukan secara sistematis dan berlapis, dengan mempertimbangkan efektivitas serta keberlanjutan intervensi yang dilakukan (AHRQ, 2022).

Hierarki Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dilakukan berdasarkan prinsip *hierarchy of controls*, yaitu pendekatan yang mengutamakan intervensi paling efektif. Tahap ini merupakan upaya untuk mengurangi atau menghilangkan risiko.

Strategi pengendalian:

1) Eliminasi risiko (*Elimination*)

Eliminasi merupakan strategi paling efektif dengan cara menghilangkan sumber risiko secara langsung. Contoh:

- Menghapus penggunaan obat yang berisiko tinggi jika tersedia alternatif yang lebih aman
- Menghilangkan prosedur yang tidak diperlukan

Menurut WHO (2021), eliminasi adalah metode paling ideal, tetapi tidak selalu dapat dilakukan dalam semua situasi klinis.

2) Substitusi (*Substitution*)

Substitusi dilakukan dengan mengganti sumber risiko dengan alternatif yang lebih aman. Contoh:

- Mengganti alat medis yang berisiko tinggi dengan teknologi yang lebih aman
- Menggunakan obat dengan efek samping lebih rendah

Pendekatan ini sering digunakan dalam praktik klinis untuk meningkatkan keselamatan pasien tanpa mengganggu proses pelayanan (AHRQ, 2022).

3) *Engineering control*

Engineering control adalah upaya pengendalian risiko melalui desain sistem atau lingkungan kerja. Contoh:

- Penggunaan *infusion pump* dengan alarm otomatis
- Desain tempat tidur pasien dengan pengaman (side rail)
- Sistem barcode untuk pemberian obat

Menurut Carayon et al. (2020), pendekatan ini sangat efektif karena mengurangi ketergantungan pada faktor manusia.

4) *Administrative control* (SOP, pelatihan)

Administrative control merupakan pengendalian risiko melalui kebijakan dan prosedur. Contoh:

- Penyusunan dan implementasi SOP
- Pelatihan tenaga kesehatan
- Sistem double check
- Jadwal kerja untuk mengurangi kelelahan

Menurut WHO (2021), administrative control sangat penting dalam membentuk perilaku tenaga kesehatan dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar keselamatan pasien.

5) Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

APD merupakan lapisan terakhir dalam pengendalian risiko yang bertujuan melindungi tenaga kesehatan dari paparan bahaya. Contoh:

- Sarung tangan
- Masker
- *Face shield*
- Gaun pelindung

Meskipun penting, penggunaan APD dianggap sebagai metode paling rendah efektivitasnya karena bergantung pada kepatuhan individu (WHO, 2021).

e. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan tahap akhir dalam siklus manajemen risiko yang bertujuan untuk menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan serta memastikan bahwa risiko tetap berada dalam batas yang dapat diterima (ISO 31000, 2018).

Tahap ini bersifat berkelanjutan (*continuous*) dan menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara terus-menerus (*continuous quality improvement*).

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi meliputi:

1) Audit berkala

Audit dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap standar dan efektivitas implementasi pengendalian risiko. Contoh:

- Audit *hand hygiene*
- Audit pemberian obat

Menurut AHRQ (2022), audit merupakan alat penting untuk memastikan bahwa intervensi yang telah dirancang benar-benar dilaksanakan di lapangan.

2) Evaluasi indikator mutu

Indikator mutu digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan kesehatan dalam aspek keselamatan pasien. Contoh indikator:

- Angka kejadian pasien jatuh
- Angka infeksi nosokomial
- Kepatuhan hand hygiene

WHO (2021) menekankan bahwa indikator mutu harus bersifat terukur, relevan, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

3) Review insiden

Review insiden dilakukan untuk mengevaluasi kejadian yang telah terjadi dan mengidentifikasi peluang perbaikan.

Metode:

- *Root Cause Analysis* (RCA)
- *Morbidity and mortality review*

Menurut Vaismoradi et al. (2020), pembelajaran dari insiden merupakan kunci dalam membangun budaya keselamatan pasien.

4) Continuous quality improvement (CQI)

CQI merupakan pendekatan sistematis untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan melalui siklus:

- Plan
- Do
- Check
- Act (PDCA)

CQI memungkinkan organisasi untuk terus melakukan perbaikan berdasarkan data dan evaluasi yang dilakukan (Deming, 1986; AHRQ, 2022).



Gambar 3.2
Siklus Manajemen Risiko

Sumber: Diadaptasi dari ISO 31000: Risk Management Guidelines (ISO, 2018) dan WHO Global Patient Safety Action Plan (WHO, 2021).

C. Kerangka Teori Manajemen Risiko dalam Keperawatan

Kerangka teori manajemen risiko dalam keperawatan diperlukan agar pengelolaan risiko tidak dilakukan secara reaktif, melainkan berbasis konsep, sistem, dan bukti ilmiah. Dalam pelayanan keperawatan, risiko tidak hanya muncul dari tindakan klinis individual, tetapi juga dari interaksi antara manusia, teknologi, prosedur, lingkungan kerja, komunikasi tim, dan budaya organisasi. Oleh karena itu, pendekatan teoritis dalam manajemen risiko harus bersifat sistemik dan komprehensif.

Menurut WHO (2021), keselamatan pasien merupakan suatu sistem yang mencakup budaya, proses, prosedur, perilaku, teknologi, dan lingkungan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk menurunkan risiko serta mengurangi dampak cedera yang dapat dicegah. Hal ini menegaskan bahwa manajemen risiko dalam keperawatan harus dilakukan secara terintegrasi dalam sistem pelayanan kesehatan.

1. Model manajemen risiko (ISO 31000 dalam kesehatan)

ISO 31000 merupakan standar internasional yang menyediakan prinsip, kerangka kerja, dan proses untuk mengelola risiko dalam berbagai sektor, termasuk pelayanan kesehatan (ISO, 2018). Model ini mendefinisikan risiko sebagai efek ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dalam konteks keperawatan, risiko tidak hanya terbatas pada kesalahan klinis, tetapi juga mencakup seluruh ketidakpastian yang dapat mempengaruhi:

- a. Keselamatan pasien
- b. Mutu pelayanan
- c. Keselamatan tenaga kesehatan
- d. Efisiensi sumber daya

ISO 31000 menekankan beberapa prinsip utama (ISO, 2018):

- a. Terintegrasi dalam seluruh aktivitas organisasi
- b. Terstruktur dan sistematis
- c. Berbasis konteks
- d. Dinamis dan responsif
- e. Berbasis bukti dan data

WHO juga menegaskan bahwa pengelolaan risiko dalam pelayanan kesehatan harus dilakukan secara terkoordinasi pada seluruh level organisasi (WHO, 2021).

2. Model *Swiss Cheese* (James Reason) dalam keselamatan pasien

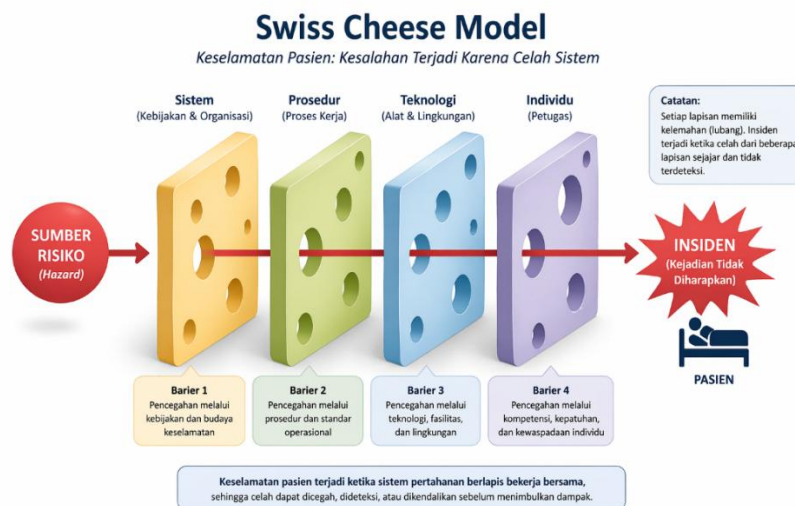
Model Swiss Cheese yang dikembangkan oleh Reason (2000) menjelaskan bahwa insiden keselamatan pasien terjadi bukan karena satu kesalahan tunggal, tetapi akibat kegagalan berlapis dalam sistem. Setiap lapisan pertahanan (misalnya SOP, pelatihan, supervisi) memiliki kelemahan (*holes*). Ketika kelemahan ini sejajar, maka risiko dapat menembus seluruh sistem dan menyebabkan insiden. Menurut Reason (2000) dan diperkuat oleh Carayon et al. (2020):

- Active failure* → kesalahan langsung oleh tenaga kesehatan
- Latent condition* → kelemahan sistem yang tersembunyi

Contoh dalam keperawatan:

- Label obat mirip
- Beban kerja tinggi
- Komunikasi tidak efektif

Pendekatan ini menggeser fokus dari: “siapa yang salah” menjadi “mengapa sistem gagal”. WHO (2021) menegaskan bahwa pendekatan sistem sangat penting dalam keselamatan pasien karena risiko bersifat inheren dalam sistem pelayanan kesehatan.



Gambar 3.3 Swiss Chees Model

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan *Swiss Cheese Model* (Reason, 2000)

3. Pendekatan sistem vs individu dalam error keperawatan

Pendekatan individu melihat error sebagai akibat dari:

- a. Kelalaian
- b. Kurang kompetensi
- c. Tidak patuh SOP

Namun pendekatan ini memiliki keterbatasan karena mengabaikan faktor sistem (Reason, 2000). Sebaliknya, pendekatan sistem memandang error sebagai hasil interaksi kompleks antara:

- a. Manusia
- b. Sistem kerja
- c. Lingkungan

Menurut Carayon et al. (2020) dan WHO (2021) dijelaskan bahwa kesalahan lebih sering disebabkan oleh kegagalan sistem daripada individu. Contoh: Kesalahan pemberian obat dapat disebabkan oleh:

- a. Sistem distribusi obat
- b. Kemasan yang mirip
- c. Gangguan saat bekerja
- d. Beban kerja tinggi

AHRQ menegaskan bahwa peningkatan keselamatan pasien harus difokuskan pada:

- a. Perbaikan sistem
- b. Desain proses yang aman
- c. Pembelajaran organisasi (AHRQ, 2022)

Konsep *Just Culture* juga penting, yaitu membedakan:

- a. *Human error*
- b. *At-risk behavior*
- c. *Reckless behavior*

Pendekatan ini mendukung budaya keselamatan dan pelaporan insiden (Vaismoradi et al., 2020).

4. *High Reliability Organization* (HRO) dalam pelayanan kesehatan

High Reliability Organization (HRO) adalah organisasi yang mampu beroperasi dalam kondisi kompleks dan berisiko tinggi dengan tingkat kegagalan yang sangat rendah (Weick & Sutcliffe, 2015; AHRQ, 2022).

Karakteristik utama HRO meliputi:

- a. *Preoccupation with failure* → selalu waspada terhadap potensi kesalahan
- b. *Reluctance to simplify* → tidak menyederhanakan masalah kompleks
- c. *Sensitivity to operations* → memahami kondisi lapangan secara real time
- d. *Commitment to resilience* → mampu beradaptasi saat terjadi gangguan
- e. *Deference to expertise* → keputusan berdasarkan kompetensi

Dalam praktik keperawatan:

- a. *Safety huddle*
- b. *Briefing*
- c. *Early warning system*, merupakan contoh penerapan prinsip HRO.

WHO melalui *Global Patient Safety Action Plan* menekankan pentingnya membangun sistem pelayanan kesehatan yang andal (WHO, 2021).

5. *Evidence-based risk management* dalam praktik keperawatan

Evidence-based risk management adalah pendekatan pengelolaan risiko yang mengintegrasikan:

- a. Bukti ilmiah
- b. Data lokal
- c. Keahlian klinis
- d. Kebutuhan pasien

Menurut Connor (2023), *evidence-based practice* terbukti meningkatkan:

- a. Kualitas pelayanan
- b. Keselamatan pasien
- c. Outcome klinis

AHRQ (2022) melalui program *Making Healthcare Safer* menekankan bahwa intervensi keselamatan harus berbasis bukti. Contoh implementasi:

- a. Pencegahan pasien jatuh berbasis skala risiko
- b. Bundle pencegahan infeksi
- c. SOP berbasis guideline

Menurut Melnyk & Fineout-Overholt (2019) menjelaskan bahwa keputusan klinis terbaik adalah yang menggabungkan:

- a. Evidence terbaik
- b. Expertise klinis
- c. Preferensi pasien

Pendekatan ini juga mendorong:

- a. Audit berbasis data
- b. Evaluasi indikator mutu
- c. *Continuous Quality Improvement* (CQI)

D. Jenis Risiko dalam Praktik Keperawatan

Dalam praktik keperawatan, risiko dapat muncul pada level klinis, non-klinis, dan sistem. Klasifikasi ini penting karena sumber risiko pada pelayanan keperawatan tidak hanya berasal dari tindakan klinis langsung, tetapi juga dari komunikasi, dokumentasi, tata kelola, lingkungan kerja, dan kapasitas sistem pelayanan (Carayon et al., 2020; *Agency for Healthcare Research and Quality* [AHRQ], 2022). WHO (2021) menegaskan bahwa keselamatan pasien merupakan hasil dari integrasi budaya, proses, prosedur, perilaku, teknologi, dan lingkungan pelayanan kesehatan yang secara konsisten bertujuan menurunkan risiko serta mengurangi harm yang dapat dicegah. Dengan demikian, risiko dalam keperawatan harus dipahami sebagai fenomena multidimensi yang memerlukan pendekatan pengelolaan yang komprehensif dan sistematis (WHO, 2021).

1. Risiko klinis:

Risiko klinis adalah risiko yang muncul langsung dalam proses asuhan keperawatan dan berpotensi menimbulkan cedera, perburukan kondisi, atau komplikasi pada pasien. Risiko ini paling dekat dengan praktik *bedside nursing* karena berkaitan dengan pemberian obat, pencegahan infeksi, mobilisasi pasien, dan perlindungan integritas kulit. World Health Organization (WHO, 2021; WHO, 2023) menempatkan *medication-related harm* sebagai salah satu sumber utama cedera pada pasien, sementara *Agency for Healthcare Research and Quality* (AHRQ, 2022), *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC, 2024), dan *National Pressure Injury Advisory Panel* (NPIAP, 2023) masing-masing menyoroti pasien jatuh, HAIs, dan *pressure injury* sebagai area prioritas dalam keselamatan pasien

a. Medication error

Medication error adalah setiap kesalahan yang dapat dicegah pada proses penggunaan obat, mulai dari peresepan, transkripsi, dispensing, penyiapan, pemberian, hingga pemantauan efek obat (WHO, 2021). WHO menyatakan bahwa praktik penggunaan obat yang tidak aman dan medication error merupakan penyebab utama *avoidable harm* dalam sistem kesehatan, dan hampir 50% kejadian yang dapat dicegah berkaitan dengan penggunaan obat (WHO, 2017; WHO, 2021). Selain itu, WHO melaporkan bahwa medication-

related harm mempengaruhi sekitar 1 dari 30 pasien, dengan lebih dari seperempat kasus tergolong serius atau mengancam jiwa (WHO, 2023).

Dalam keperawatan, medication error sering terjadi pada tahap administrasi obat, karena perawat merupakan tenaga kesehatan yang melakukan verifikasi terakhir sebelum obat diberikan kepada pasien. Bentuk kesalahan meliputi salah pasien, salah obat, salah dosis, salah waktu, salah rute, dan kesalahan dokumentasi. Risiko ini meningkat akibat faktor seperti kemiripan nama obat, label yang tidak jelas, interupsi kerja, kelelahan, dan komunikasi yang tidak efektif (Carayon et al., 2020; AHRQ, 2022). WHO melalui program *Medication Without Harm* menegaskan bahwa kesalahan obat harus dicegah melalui pendekatan sistem, bukan dengan menyalahkan individu (WHO, 2017).

b. Infeksi terkait pelayanan kesehatan (HAIs)

Healthcare-associated infections (HAIs) adalah infeksi yang diperoleh pasien selama menjalani pelayanan kesehatan (CDC, 2024). CDC menyatakan bahwa HAIs merupakan ancaman serius karena dapat terjadi akibat penggunaan alat invasif, komplikasi tindakan medis, serta transmisi mikroorganisme dalam fasilitas kesehatan (CDC, 2024).

Dalam praktik keperawatan, HAIs berkaitan erat dengan tindakan seperti hand hygiene, teknik aseptik, perawatan kateter, dan perawatan luka. Jenis HAIs yang sering dipantau meliputi CLABSI, CAUTI, SSI, dan infeksi *Clostridioides difficile* (CDC, 2024; WHO, 2021). Risiko HAIs meningkat akibat faktor sistem seperti kepadatan pasien, keterbatasan fasilitas, serta kepatuhan yang rendah terhadap prosedur pencegahan infeksi (WHO, 2021; AHRQ, 2022).

c. Pasien Jatuh

Pasien jatuh merupakan salah satu insiden keselamatan yang paling sering terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan dan dapat menyebabkan cedera serius hingga kematian (AHRQ, 2022). Pencegahan jatuh memerlukan pendekatan multifaktorial yang mencakup faktor pasien, lingkungan, dan sistem pelayanan (AHRQ, 2022).

Dalam praktik keperawatan, risiko jatuh berkaitan dengan kondisi pasien seperti usia lanjut, gangguan mobilitas, penggunaan obat sedatif, dan gangguan kognitif. AHRQ menegaskan bahwa program pencegahan jatuh yang efektif harus menghubungkan hasil asesmen risiko dengan intervensi yang spesifik bagi tiap pasien (AHRQ, 2022).

d. *Pressure injury*

Pressure injury adalah kerusakan jaringan akibat tekanan berkepanjangan atau kombinasi tekanan dan shear (NPIAP, 2023). NPIAP menegaskan bahwa kondisi ini merupakan masalah keselamatan pasien yang signifikan karena

sebagian besar kasus dapat dicegah melalui intervensi keperawatan yang tepat (NPIAP, 2023).

Faktor risiko meliputi imobilisasi, malnutrisi, gangguan perfusi, dan penggunaan alat medis yang menekan jaringan. Dalam praktik keperawatan, pencegahan dilakukan melalui asesmen risiko, reposisi berkala, penggunaan alat bantu, serta pemantauan kondisi kulit (NPIAP, 2023; WHO, 2021).

2. Risiko non-klinis:

Risiko non-klinis adalah risiko yang tidak selalu muncul dari tindakan klinis langsung, tetapi sangat memengaruhi keselamatan pasien, mutu asuhan, dan akuntabilitas profesional. Dalam keperawatan, risiko non-klinis yang paling penting meliputi komunikasi, dokumentasi, dan aspek hukum-etik. Walaupun tampak administratif atau relasional, ketiga area ini sangat menentukan kualitas keputusan klinis, kontinuitas asuhan, dan perlindungan hukum bagi pasien maupun perawat (*World Health Organization* [WHO], 2021; *Agency for Healthcare Research and Quality* [AHRQ], 2022).

a. Risiko komunikasi

Risiko komunikasi muncul ketika informasi tidak disampaikan secara jelas, lengkap, tepat waktu, atau dapat dipahami oleh penerima. PSNet-AHRQ (AHRQ, 2022) menegaskan bahwa komunikasi yang tidak akurat atau tidak tepat waktu serta teamwork yang tidak efektif merupakan penyebab utama adverse events yang dapat dicegah, termasuk medication error, misdiagnosis, dan keterlambatan terapi. Masa transisi pelayanan, seperti handover antar shift atau perpindahan unit, merupakan titik yang sangat rentan (AHRQ, 2022).

Dalam praktik keperawatan, risiko komunikasi dapat terjadi saat handover, pelaporan perubahan kondisi pasien, pemberian instruksi verbal, edukasi pasien, maupun koordinasi antarprofesi. Informasi yang tidak lengkap atau tidak terkonfirmasi dapat menyebabkan kesalahan klinis. Literatur menunjukkan bahwa communication errors berhubungan erat dengan berbagai *adverse events*, termasuk jatuh pasien dan keterlambatan diagnosis (*The Joint Commission*, 2021; AHRQ, 2022).

Oleh karena itu, komunikasi harus dipandang sebagai bagian dari sistem keselamatan pasien. Penggunaan metode komunikasi terstruktur seperti SBAR, *read-back*, dan *bedside handover* terbukti meningkatkan keselamatan pasien (WHO, 2021; AHRQ, 2022).

b. Risiko dokumentasi

Dokumentasi keperawatan merupakan bagian integral dari proses klinis, komunikasi profesional, serta aspek legal pelayanan kesehatan. AHRQ (2022) menegaskan bahwa dokumentasi yang baik sangat penting untuk akurasi

pengukuran indikator keselamatan pasien dan evaluasi mutu pelayanan. Dokumentasi yang tidak lengkap, tidak tepat waktu, atau tidak akurat dapat menyebabkan:

- 1) Gangguan kontinuitas asuhan
- 2) Kesalahan pengambilan keputusan klinis
- 3) Risiko hukum

Dalam praktik keperawatan, risiko dokumentasi meliputi keterlambatan pencatatan, ketidaksesuaian antara tindakan dan catatan, serta penggunaan istilah yang ambigu. PSNet-AHRQ (2022) juga menyoroti bahwa sistem rekam medis elektronik yang tidak optimal dapat meningkatkan risiko keselamatan pasien.

Karena itu, dokumentasi harus dipandang sebagai bagian dari patient safety system, bukan sekadar administrasi. Perawat memiliki tanggung jawab profesional untuk memastikan dokumentasi akurat, lengkap, dan real time (AHRQ, 2022; WHO, 2021).

c. Risiko hukum dan etik

Risiko hukum dan etik muncul ketika praktik keperawatan tidak sesuai dengan standar profesi, prinsip etik, maupun regulasi yang berlaku. International Council of Nurses (ICN, 2021) menyatakan bahwa *Code of Ethics for Nurses* menjadi pedoman utama dalam menentukan tanggung jawab profesional perawat terhadap pasien, masyarakat, dan profesi. Risiko ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti:

- 1) Pelanggaran informed consent
- 2) Pelanggaran kerahasiaan pasien
- 3) Praktik di luar kewenangan
- 4) Kelalaian dalam pelayanan
- 5) Dokumentasi yang tidak akurat

Dalam konteks manajemen risiko, aspek hukum dan etik sering merupakan konsekuensi dari kegagalan sistem sebelumnya, seperti komunikasi yang buruk atau dokumentasi yang tidak lengkap (WHO, 2021; AHRQ, 2022). Oleh karena itu, pengelolaan risiko hukum dan etik harus dilakukan secara preventif melalui:

- 1) Pendidikan etik
- 2) Supervisi klinis
- 3) Penguatan budaya keselamatan (*speak-up culture*)
- 4) Sistem pelaporan insiden yang aman

Perawat harus mampu menyeimbangkan antara tanggung jawab profesional dan keselamatan pasien sebagai prioritas utama (ICN, 2021; WHO, 2021).

3. Risiko sistem:

Risiko sistem adalah risiko yang bersumber dari kondisi organisasi, desain kerja, kapasitas sumber daya, dan lingkungan operasional pelayanan. Risiko ini sering menjadi akar dari berbagai insiden klinis dan non-klinis. Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ, 2022) menegaskan bahwa *patient safety* dalam praktik keperawatan sangat dipengaruhi oleh kondisi kerja, jam kerja, *staffing*, serta fenomena *missed care*. Selain itu, World Health Organization (WHO, 2021; WHO, 2024) menekankan bahwa ketahanan sistem pelayanan kesehatan sangat bergantung pada tenaga kesehatan yang terlindungi, didukung, dan memiliki jumlah yang memadai.

a. Kelelahan tenaga kesehatan

Kelelahan atau burnout pada tenaga kesehatan merupakan risiko sistem yang signifikan karena dapat memengaruhi konsentrasi, ketahanan emosional, kualitas pengambilan keputusan, komunikasi, serta kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. WHO (2024) menyoroti pentingnya perlindungan kesehatan mental tenaga kesehatan sebagai bagian dari keselamatan sistem pelayanan. Selain itu, *National Institute for Occupational Safety and Health* (NIOSH, 2023) dan *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC, 2023) menegaskan bahwa tenaga kesehatan memiliki risiko tinggi mengalami burnout akibat tekanan kerja yang tinggi. *National Academy of Medicine* (NAM, 2022) juga menyatakan bahwa burnout merupakan ancaman utama terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan dan kualitas pelayanan.

Dalam praktik keperawatan, kelelahan dapat disebabkan oleh shift panjang, beban emosional tinggi, paparan kasus kompleks, konflik kerja, dan kurangnya dukungan organisasi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perawat, tetapi juga pasien, karena kelelahan meningkatkan risiko *missed care*, kesalahan klinis, komunikasi yang tidak efektif, serta penurunan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi pasien (AHRQ, 2022; Carayon et al., 2020).

Oleh karena itu, kelelahan tenaga kesehatan harus dipandang sebagai risiko keselamatan pasien, bukan hanya masalah kesejahteraan individu. Upaya mitigasi meliputi penataan jadwal kerja, dukungan psikologis, kepemimpinan yang suportif, serta penguatan budaya kerja yang sehat (WHO, 2024; AHRQ, 2022).

b. Beban kerja tinggi

Beban kerja tinggi terjadi ketika tuntutan pelayanan melebihi kapasitas tenaga, waktu, dan sumber daya yang tersedia untuk memberikan asuhan yang aman. Dalam keperawatan, kondisi ini berkaitan erat dengan meningkatnya missed nursing care, keterlambatan tindakan, serta penurunan kualitas pemantauan pasien. AHRQ (2022) menegaskan bahwa staffing yang tidak memadai berhubungan dengan meningkatnya risiko kejadian tidak diharapkan, termasuk peningkatan mortalitas pasien.

Beban kerja tinggi juga menyebabkan berkurangnya waktu untuk tindakan preventif seperti edukasi pasien, reposisi, verifikasi obat, serta komunikasi yang efektif saat handover. Hal ini membuat sistem pelayanan menjadi lebih rentan terhadap kegagalan, karena lapisan pengaman tidak berjalan secara optimal (Carayon et al., 2020; AHRQ, 2022).

Oleh karena itu, pengendalian risiko pada aspek ini memerlukan pendekatan sistemik, seperti penyesuaian rasio perawat-pasien, pengelolaan beban kerja, penggunaan teknologi pendukung, serta penguatan fungsi manajerial kepala ruangan (AHRQ, 2022).

c. Keterbatasan SDM dan fasilitas

Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas merupakan risiko sistem yang berdampak luas terhadap keselamatan pasien. WHO (2023) menyatakan bahwa dunia menghadapi kekurangan tenaga kesehatan secara global, yang berdampak pada kemampuan sistem pelayanan dalam memberikan asuhan yang aman dan berkualitas.

Dalam praktik keperawatan, keterbatasan SDM dapat menyebabkan rasio pasien-perawat yang tidak ideal, kurangnya supervisi, serta keterbatasan dalam orientasi dan pelatihan staf baru. Sementara itu, keterbatasan fasilitas seperti kurangnya alat medis, keterbatasan APD, serta sistem informasi yang tidak optimal dapat meningkatkan risiko kesalahan klinis (WHO, 2021; AHRQ, 2022). Kondisi ini meningkatkan kemungkinan terjadinya:

- 1) Medication error
- 2) Jatuh pasien
- 3) Infeksi terkait pelayanan kesehatan
- 4) Keterlambatan respon klinis
- 5) Kesalahan dokumentasi

Oleh karena itu, keterbatasan SDM dan fasilitas harus dipandang sebagai faktor risiko utama dalam manajemen pelayanan keperawatan. Solusi yang diperlukan meliputi perencanaan kebutuhan tenaga, peningkatan kapasitas

SDM, investasi fasilitas, serta penguatan sistem pelayanan (WHO, 2023; AHRQ, 2022).

E. Proses Manajemen Risiko dalam Praktik Keperawatan

Berbeda dengan pembahasan konseptual pada bagian sebelumnya, pada bagian ini akan diuraikan implementasi praktis manajemen risiko dalam unit keperawatan, proses manajemen risiko dalam praktik keperawatan merupakan suatu siklus sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko guna meningkatkan keselamatan pasien. Proses ini bersifat berkelanjutan dan terintegrasi dalam seluruh aktivitas pelayanan keperawatan. ISO 31000 (2018) dan WHO (2021) menegaskan bahwa manajemen risiko harus dilakukan secara sistematis, berbasis data, dan menjadi bagian dari praktik organisasi sehari-hari.

1. Identifikasi risiko di unit keperawatan

Identifikasi risiko merupakan tahap awal dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk mengenali berbagai potensi bahaya yang dapat terjadi selama proses asuhan keperawatan. Tahap ini bersifat proaktif karena dilakukan sebelum risiko berkembang menjadi insiden keselamatan pasien, serta menjadi dasar bagi seluruh proses manajemen risiko berikutnya (WHO, 2021). Dalam praktik di unit keperawatan, identifikasi risiko dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti observasi langsung terhadap praktik klinis, audit keperawatan, pelaporan insiden, serta diskusi tim dalam bentuk briefing dan debriefing.

Pendekatan ini penting karena risiko dalam pelayanan kesehatan tidak hanya muncul dari tindakan individu, tetapi merupakan hasil interaksi kompleks antara manusia, sistem, dan lingkungan kerja. Hal ini sejalan dengan konsep human factors yang dikemukakan oleh Carayon et al. (2020), yang menekankan bahwa identifikasi risiko harus mencakup aspek klinis, lingkungan, sistem kerja, dan komunikasi. Selain itu, AHRQ (2022) menegaskan bahwa identifikasi risiko yang efektif memungkinkan organisasi untuk melakukan pencegahan secara dini terhadap kejadian tidak diharapkan melalui pendekatan proactive risk management.

2. Analisis risiko:

Analisis risiko merupakan tahap lanjutan yang bertujuan untuk memahami karakteristik risiko melalui penilaian terhadap penyebab, frekuensi kejadian, serta dampak yang mungkin ditimbulkan. Tahap ini penting untuk menentukan prioritas penanganan risiko sehingga intervensi yang dilakukan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran (*International Organization for Standardization* [ISO], 2018).

a. *Root Cause Analysis (RCA)*

RCA adalah pendekatan retrospektif yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu insiden yang telah terjadi (WHO, 2021; AHRQ, 2022). RCA bertujuan untuk menemukan faktor penyebab utama, mengidentifikasi kelemahan sistem, serta mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang. Reason (2000) menjelaskan bahwa kesalahan dalam pelayanan kesehatan lebih sering disebabkan oleh kegagalan sistem daripada kesalahan individu, sehingga analisis harus difokuskan pada faktor manusia, sistem kerja, lingkungan, dan komunikasi. Proses RCA dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi insiden, pengumpulan data, analisis kronologi, identifikasi faktor penyebab, penentuan akar masalah, serta penyusunan rekomendasi perbaikan.

b. *Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)*

FMEA yaitu pendekatan prospektif yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan sebelum insiden terjadi (JCI, 2021). FMEA biasanya digunakan pada proses baru, area berisiko tinggi, atau saat terjadi perubahan sistem pelayanan. Melalui langkah-langkah seperti identifikasi proses, identifikasi potensi kegagalan, analisis penyebab, penilaian dampak, dan penentuan prioritas risiko, FMEA memungkinkan organisasi untuk melakukan pencegahan secara sistematis. WHO (2021) menegaskan bahwa pendekatan prospektif seperti FMEA sangat penting dalam meningkatkan keselamatan pasien karena berfokus pada pencegahan.

3. Penilaian risiko (*risk matrix: likelihood vs severity*)

Penilaian risiko merupakan proses untuk menentukan tingkat prioritas risiko berdasarkan kombinasi antara kemungkinan terjadinya (*likelihood*) dan tingkat keparahan dampak (*severity*). Metode yang paling umum digunakan adalah risk matrix, yang mengelompokkan risiko ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi (ISO, 2018; WHO, 2021).

Penggunaan risk matrix membantu tenaga kesehatan dalam menentukan prioritas intervensi, mengalokasikan sumber daya secara efisien, serta mengambil keputusan berbasis risiko. AHRQ (2022) menyatakan bahwa pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk fokus pada risiko dengan dampak terbesar, meskipun frekuensi kejadiannya rendah. Dengan demikian, penilaian risiko menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa upaya pengendalian difokuskan pada area yang paling kritis.

4. Pengendalian risiko:

Pengendalian risiko merupakan tahap yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis. Pendekatan yang digunakan dalam pengendalian risiko mengacu pada konsep *hierarchy of controls*, yang menempatkan intervensi paling efektif pada tingkat tertinggi (WHO, 2021; AHRQ, 2022).



Gambar 3.4 Hierarchy of Controls

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan konsep *Hierarchy of Controls* (NIOSH, 2015; WHO, 2021)

a. Eliminasi

Eliminasi merupakan strategi paling efektif karena bertujuan menghilangkan sumber risiko secara langsung, misalnya dengan menghapus prosedur yang tidak diperlukan atau menghindari penggunaan alat berisiko tinggi (WHO, 2021). Jika eliminasi tidak memungkinkan, maka dilakukan substitusi, yaitu mengganti sumber risiko dengan alternatif yang lebih aman, seperti penggunaan obat dengan profil keamanan yang lebih baik (AHRQ, 2022).

b. Substitusi

Substitusi merupakan salah satu strategi dalam pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengganti sumber risiko dengan alternatif yang lebih aman. Pendekatan ini digunakan ketika eliminasi risiko tidak memungkinkan untuk dilakukan, sehingga risiko tetap ada tetapi tingkat bahayanya dapat dikurangi. Dalam konteks pelayanan kesehatan, khususnya praktik keperawatan, substitusi sering diterapkan untuk menurunkan potensi cedera pasien maupun tenaga kesehatan tanpa mengganggu proses pelayanan yang esensial.

Sebagai contoh, penggunaan obat dengan risiko tinggi dapat digantikan dengan alternatif obat yang memiliki profil keamanan lebih baik atau efek samping yang lebih rendah. Selain itu, substitusi juga dapat dilakukan pada

alat medis, bahan, atau prosedur tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya. AHRQ (2022) menekankan bahwa strategi substitusi merupakan bagian penting dalam manajemen risiko karena memungkinkan organisasi tetap menjalankan pelayanan dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi.

Dalam praktik keperawatan, penerapan substitusi membutuhkan pertimbangan klinis yang matang, termasuk efektivitas terapi, keamanan pasien, serta ketersediaan sumber daya. Oleh karena itu, keputusan substitusi umumnya melibatkan kolaborasi antarprofesi, seperti dokter, apoteker, dan perawat, untuk memastikan bahwa alternatif yang dipilih tetap memberikan manfaat optimal bagi pasien.

c. *Engineering control*

Engineering control merupakan strategi pengendalian risiko yang dilakukan melalui modifikasi desain sistem, alat, atau lingkungan kerja untuk mengurangi atau menghilangkan paparan terhadap bahaya. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dibandingkan intervensi berbasis perilaku karena tidak sepenuhnya bergantung pada kepatuhan individu, melainkan pada sistem yang secara otomatis mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan.

Contoh penerapan *engineering control* dalam praktik keperawatan antara lain penggunaan infusion pump dengan sistem alarm otomatis untuk mencegah kesalahan dosis, serta penerapan barcode medication system yang memungkinkan verifikasi identitas pasien dan obat secara digital sebelum pemberian obat. Dengan adanya sistem ini, risiko kesalahan pemberian obat dapat diminimalkan secara signifikan.

Menurut Carayon et al. (2020), pendekatan berbasis human factors engineering sangat efektif dalam meningkatkan keselamatan pasien karena mampu mengurangi ketergantungan pada faktor manusia yang rentan terhadap kelelahan, distraksi, dan kesalahan. Dengan kata lain, *engineering control* membantu menciptakan sistem yang "*fail-safe*" atau lebih tahan terhadap kesalahan.

Dalam konteks manajemen risiko keperawatan, *engineering control* menjadi sangat penting terutama pada unit dengan tingkat kompleksitas tinggi, seperti ICU, IGD, dan kamar operasi, di mana kesalahan kecil dapat berdampak besar terhadap keselamatan pasien.

d. *Administrative control*

Administrative control merupakan strategi pengendalian risiko yang dilakukan melalui kebijakan, prosedur, dan pengaturan organisasi untuk memastikan bahwa praktik pelayanan berjalan sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan. Pendekatan ini berfokus pada pengaturan perilaku tenaga kesehatan melalui sistem manajemen, pelatihan, serta pengawasan.

Contoh penerapan *administrative control* dalam keperawatan meliputi penyusunan dan implementasi Standar Prosedur Operasional (SOP), pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta penerapan sistem *double check* pada tindakan berisiko tinggi seperti pemberian obat. Selain itu, pengaturan jadwal kerja, supervisi klinis, dan audit kepatuhan juga merupakan bagian dari *administrative control*.

World Health Organization (WHO, 2021) menegaskan bahwa kebijakan dan prosedur yang jelas serta pelatihan yang berkelanjutan merupakan komponen penting dalam menciptakan sistem pelayanan yang aman. Namun, efektivitas *administrative control* sangat bergantung pada kepatuhan tenaga kesehatan serta konsistensi implementasi di lapangan.

Dalam praktik keperawatan, *administrative control* berperan sebagai penghubung antara kebijakan manajemen dan tindakan klinis sehari-hari. Oleh karena itu, keberhasilan strategi ini sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan, budaya organisasi, serta komitmen terhadap keselamatan pasien.

e. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Penggunaan alat pelindung diri (APD) merupakan lapisan terakhir dalam hierarki pengendalian risiko yang bertujuan untuk melindungi tenaga kesehatan dari paparan bahaya yang tidak dapat dihilangkan melalui metode lain. APD tidak menghilangkan sumber risiko, tetapi berfungsi sebagai penghalang antara tenaga kesehatan dan potensi bahaya.

Dalam praktik keperawatan, APD yang umum digunakan meliputi masker, sarung tangan, *face shield*, gaun pelindung, dan alat pelindung lainnya sesuai dengan jenis risiko yang dihadapi. Penggunaan APD menjadi sangat penting terutama dalam situasi dengan risiko tinggi, seperti penanganan pasien infeksius, prosedur invasif, atau kondisi darurat.

Namun demikian, WHO (2021) menegaskan bahwa efektivitas penggunaan APD sangat bergantung pada kepatuhan pengguna, termasuk cara penggunaan yang benar (*donning* dan *doffing*), ketersediaan APD, serta kesadaran tenaga kesehatan terhadap pentingnya perlindungan diri. Oleh karena itu, pelatihan penggunaan APD dan pengawasan kepatuhan menjadi bagian penting dalam manajemen risiko.

Dalam perspektif manajemen risiko, APD dianggap sebagai metode pengendalian dengan tingkat efektivitas paling rendah dibandingkan strategi lain seperti eliminasi atau *engineering control*, karena sangat bergantung pada faktor manusia. Namun demikian, APD tetap menjadi komponen penting

dalam sistem perlindungan tenaga kesehatan dan harus digunakan sebagai bagian dari pendekatan pengendalian risiko yang komprehensif.

5. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan tahap akhir dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan serta memastikan bahwa risiko tetap berada dalam batas yang dapat diterima. Tahap ini bersifat berkelanjutan dan merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan (ISO, 2018).

Monitoring dilakukan melalui audit berkala untuk menilai kepatuhan terhadap standar pelayanan, seperti audit hand hygiene dan audit pemberian obat (AHRQ, 2022). Selain itu, evaluasi indikator mutu digunakan untuk mengukur kinerja keselamatan pasien, misalnya angka kejadian jatuh pasien dan angka infeksi terkait pelayanan kesehatan (WHO, 2021).

Review insiden juga merupakan bagian penting dari evaluasi, yang bertujuan untuk menganalisis kejadian yang telah terjadi dan mengambil pembelajaran sistem. Metode yang digunakan meliputi RCA dan *morbidity review* (Vaismoradi et al., 2020). Selanjutnya, pendekatan *Continuous Quality Improvement* (CQI) dilakukan secara berkelanjutan melalui siklus *Plan-Do-Check-Act* (PDCA), yang diperkenalkan oleh Deming (1986), untuk memastikan bahwa perbaikan mutu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

F. Implementasi Manajemen Risiko dalam Asuhan Keperawatan

Implementasi manajemen risiko dalam asuhan keperawatan merupakan upaya sistematis untuk mengintegrasikan prinsip keselamatan pasien ke dalam praktik klinis sehari-hari. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pencegahan insiden, tetapi juga pada peningkatan kualitas asuhan secara berkelanjutan. WHO (2021) menegaskan bahwa keselamatan pasien harus menjadi bagian integral dari setiap proses pelayanan kesehatan, termasuk dalam praktik keperawatan. Oleh karena itu, perawat memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko selama proses asuhan keperawatan berlangsung.

1. Integrasi dalam proses keperawatan:

Manajemen risiko dalam keperawatan harus terintegrasi dalam setiap tahap proses keperawatan, mulai dari pengkajian hingga evaluasi. Pendekatan ini memastikan bahwa keselamatan pasien menjadi fokus utama dalam setiap pengambilan keputusan klinis (AHRQ, 2022).

a. Pengkajian berbasis risiko

Pengkajian berbasis risiko merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat memengaruhi kondisi pasien. Pada tahap ini, perawat tidak hanya mengumpulkan data klinis, tetapi juga menilai faktor risiko yang dapat menyebabkan kejadian tidak diharapkan, seperti risiko jatuh, risiko infeksi, risiko tekanan luka, dan risiko kesalahan pengobatan.

Menurut Carayon et al. (2020), pengkajian risiko yang komprehensif harus mempertimbangkan interaksi antara faktor pasien, lingkungan, dan sistem pelayanan. Oleh karena itu, penggunaan alat ukur standar seperti skala risiko jatuh dan skala risiko pressure injury menjadi penting dalam mendukung pengambilan keputusan klinis.

b. Diagnosis risiko

Diagnosis keperawatan tidak hanya berfokus pada masalah aktual, tetapi juga mencakup risiko yang mungkin terjadi. Diagnosis risiko memungkinkan perawat untuk mengantisipasi potensi komplikasi sebelum terjadi, sehingga intervensi dapat dilakukan secara preventif.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep *proactive risk management*, di mana fokus utama adalah pencegahan, bukan hanya penanganan setelah kejadian (WHO, 2021). Dengan demikian, diagnosis risiko menjadi bagian penting dalam meningkatkan keselamatan pasien.

c. Intervensi pencegahan

Intervensi keperawatan berbasis risiko bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya insiden. Contohnya meliputi pemasangan pengaman tempat tidur untuk pasien berisiko jatuh, penerapan teknik aseptik untuk mencegah infeksi, serta penerapan prinsip safe medication administration.

AHRQ (2022) menegaskan bahwa intervensi preventif berbasis bukti dapat secara signifikan menurunkan angka kejadian tidak diharapkan. Oleh karena itu, perawat harus mampu memilih intervensi yang tepat berdasarkan tingkat risiko pasien.

2. *Clinical pathway* dan *bundle care*

Clinical pathway merupakan panduan terstruktur yang menggambarkan alur pelayanan pasien berdasarkan diagnosis tertentu, sedangkan *bundle care* adalah kumpulan intervensi berbasis bukti yang dilakukan secara bersamaan untuk meningkatkan outcome pasien.

Menurut *Institute for Healthcare Improvement* (IHI, 2020), penerapan *bundle care* terbukti efektif dalam menurunkan kejadian infeksi dan komplikasi klinis, karena memastikan bahwa semua intervensi penting dilakukan secara konsisten. Contohnya adalah *bundle* pencegahan infeksi terkait kateter atau

ventilator. Dalam praktik keperawatan, penggunaan clinical pathway dan bundle care membantu mengurangi variasi praktik, meningkatkan kepatuhan terhadap standar, serta menurunkan risiko kesalahan dalam pelayanan (WHO, 2021).

3. Penerapan *Early Warning System* (EWS)

EWS merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi secara dini perburukan kondisi pasien melalui pemantauan parameter fisiologis seperti tekanan darah, denyut nadi, frekuensi napas, dan tingkat kesadaran.

Royal College of Physicians (RCP, 2017) melalui sistem NEWS2 menyatakan bahwa penggunaan EWS dapat meningkatkan deteksi dini kondisi kritis dan menurunkan angka mortalitas pasien. WHO (2021) juga menegaskan bahwa sistem deteksi dini merupakan bagian penting dari keselamatan pasien.

Dalam praktik keperawatan, EWS membantu perawat dalam:

- a. Mengidentifikasi perubahan kondisi pasien secara cepat
- b. Menentukan eskalasi tindakan
- c. Meningkatkan respons klinis secara tepat waktu

Dengan demikian, penerapan EWS merupakan bentuk implementasi manajemen risiko yang bersifat preventif dan responsif.

4. Penerapan *patient safety goals* (IPSG/JCI & SNARS)

Penerapan *International Patient Safety Goals* (IPSG) dari JCI (2021) dan standar keselamatan pasien dalam SNARS (Kemenkes RI, 2022) merupakan bagian penting dalam implementasi manajemen risiko di fasilitas pelayanan kesehatan.

IPSG meliputi:

- a. Identifikasi pasien secara tepat
- b. Komunikasi efektif
- c. Keamanan penggunaan obat
- d. Kepastian lokasi, prosedur, dan pasien operasi
- e. Pencegahan infeksi
- f. Pencegahan risiko jatuh

Menurut JCI (2021), implementasi IPSG secara konsisten dapat menurunkan kejadian tidak diharapkan dan meningkatkan keselamatan pasien. Dalam praktik keperawatan, perawat memiliki peran utama dalam memastikan bahwa standar ini diterapkan dalam setiap tindakan klinis.

5. Dokumentasi berbasis risiko

Dokumentasi berbasis risiko merupakan bagian penting dalam implementasi manajemen risiko karena berfungsi sebagai alat komunikasi, bukti legal, serta sumber data untuk evaluasi mutu pelayanan.

AHRQ (2022) menegaskan bahwa dokumentasi yang akurat dan lengkap sangat penting dalam mendukung keselamatan pasien dan pengambilan keputusan klinis. Dokumentasi yang baik harus mencerminkan:

- a. Kondisi pasien
- b. Risiko yang diidentifikasi
- c. Intervensi yang dilakukan
- d. Respons pasien

Selain itu, dokumentasi juga berperan dalam proses audit, pelaporan insiden, serta evaluasi kualitas pelayanan (WHO, 2021). Oleh karena itu, perawat harus memastikan bahwa dokumentasi dilakukan secara sistematis, akurat, dan tepat waktu.

G. Peran dan Tanggung Jawab Perawat dalam Manajemen Risiko

Perawat memiliki peran yang sangat strategis dalam manajemen risiko karena merupakan tenaga kesehatan yang berada di garis terdepan dalam pelayanan pasien. Interaksi yang berlangsung secara kontinu selama 24 jam menjadikan perawat sebagai pihak yang paling dekat dengan pasien, sehingga memiliki peluang besar untuk mengidentifikasi risiko, mencegah kejadian tidak diharapkan, serta memastikan keselamatan pasien selama proses asuhan keperawatan. WHO (2021) menegaskan bahwa tenaga kesehatan, khususnya perawat, merupakan komponen kunci dalam sistem keselamatan pasien karena keterlibatannya secara langsung dalam pelayanan klinis.

1. Perawat sebagai frontliner patient safety

Sebagai frontliner, perawat berperan sebagai pengawas utama terhadap kondisi pasien serta pelaksanaan tindakan klinis. Perawat bertanggung jawab dalam melakukan pengkajian berkelanjutan, mendeteksi perubahan kondisi pasien secara dini, serta memastikan bahwa setiap intervensi dilakukan sesuai standar keselamatan.

Menurut AHRQ (2022), perawat memiliki kontribusi signifikan dalam mencegah kejadian tidak diharapkan melalui pengawasan langsung, penerapan standar praktik, serta koordinasi dengan tim kesehatan. Selain itu, Carayon et al. (2020) menekankan bahwa perawat merupakan bagian penting dalam sistem *human factors* karena berperan dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan kerja dan keselamatan pasien.

Dengan demikian, peran perawat sebagai frontliner tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga strategis dalam menjaga kualitas dan keamanan pelayanan kesehatan.

2. Peran perawat dalam pelaporan insiden

Pelaporan insiden merupakan salah satu komponen utama dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencegah terjadinya kejadian berulang. Perawat memiliki peran penting dalam sistem pelaporan karena sering menjadi pihak pertama yang mengetahui adanya insiden atau potensi insiden di lapangan.

WHO (2021) menyatakan bahwa sistem pelaporan insiden yang efektif harus bersifat non-punitif dan mendorong tenaga kesehatan untuk melaporkan tanpa rasa takut. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat hambatan seperti ketakutan terhadap sanksi, kurangnya pemahaman, serta budaya organisasi yang belum mendukung.

Menurut Vaismoradi et al. (2020), keterlibatan aktif perawat dalam pelaporan insiden dapat meningkatkan pembelajaran organisasi serta memperkuat sistem keselamatan pasien. Oleh karena itu, perawat tidak hanya bertugas melaporkan insiden, tetapi juga berperan dalam proses analisis dan implementasi perbaikan.

3. Budaya keselamatan pasien (safety culture):

Budaya keselamatan pasien merupakan fondasi utama dalam manajemen risiko yang mencerminkan nilai, sikap, dan perilaku organisasi dalam menjaga keselamatan pasien. Budaya ini menentukan bagaimana tenaga kesehatan merespons kesalahan dan mengambil pembelajaran dari setiap insiden.

a. *Just culture*

Just culture adalah pendekatan yang menyeimbangkan antara akuntabilitas individu dan tanggung jawab sistem. Dalam konsep ini, kesalahan manusia (human error) tidak langsung disalahkan, tetapi dianalisis untuk menemukan akar penyebabnya.

Menurut Reason (2000), sebagian besar kesalahan dalam pelayanan kesehatan disebabkan oleh kegagalan sistem, sehingga pendekatan yang adil dan tidak menyalahkan individu sangat penting dalam meningkatkan keselamatan pasien. *Just culture* memungkinkan tenaga kesehatan, termasuk perawat, untuk belajar dari kesalahan tanpa takut dihukum secara tidak adil.

b. *No blame culture*

No blame culture merupakan budaya yang mendorong tenaga kesehatan untuk melaporkan kesalahan tanpa rasa takut terhadap hukuman. Pendekatan ini penting untuk mengatasi fenomena *underreporting* dalam sistem pelayanan kesehatan.

WHO (2021) menegaskan bahwa organisasi yang menerapkan budaya tanpa menyalahkan akan lebih efektif dalam mengidentifikasi risiko dan

meningkatkan keselamatan pasien. Namun, budaya ini tetap harus diimbangi dengan tanggung jawab profesional agar tidak menurunkan standar praktik.

4. Komunikasi efektif (SBAR)

Komunikasi efektif merupakan elemen penting dalam manajemen risiko karena banyak insiden keselamatan pasien disebabkan oleh kegagalan komunikasi. Salah satu metode komunikasi yang banyak digunakan dalam pelayanan kesehatan adalah SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*).

Menurut AHRQ (2022), penggunaan SBAR dapat meningkatkan kejelasan komunikasi, mengurangi kesalahan informasi, serta mempercepat pengambilan keputusan klinis. SBAR membantu tenaga kesehatan dalam menyampaikan informasi secara terstruktur, sehingga mengurangi risiko misinterpretasi. Dalam praktik keperawatan, SBAR sering digunakan dalam:

- a. Handover pasien
- b. Komunikasi dengan dokter
- c. Pelaporan kondisi kritis

Dengan komunikasi yang efektif, perawat dapat memastikan bahwa informasi penting tidak terlewat dan tindakan yang diambil lebih tepat.

5. Edukasi pasien dan keluarga

Edukasi pasien dan keluarga merupakan bagian penting dari manajemen risiko karena pasien yang teredukasi dengan baik dapat berperan aktif dalam menjaga keselamatan dirinya. Edukasi meliputi pemahaman tentang penyakit, pengobatan, prosedur, serta tindakan pencegahan yang harus dilakukan.

WHO (2021) menyatakan bahwa keterlibatan pasien dalam pelayanan kesehatan merupakan strategi penting dalam meningkatkan keselamatan pasien. Pasien yang memahami kondisinya cenderung lebih patuh terhadap terapi dan lebih mampu mengenali tanda bahaya.

Dalam praktik keperawatan, edukasi dilakukan melalui komunikasi terapeutik yang efektif, penggunaan media edukasi, serta pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan keluarga. Edukasi yang baik tidak hanya meningkatkan outcome klinis, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan kepuasan pasien.

H. Manajemen Risiko dalam Perspektif Akreditasi dan Regulasi

Manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari sistem akreditasi dan regulasi yang berlaku, karena keduanya menjadi kerangka formal dalam menjamin mutu dan keselamatan pasien. Akreditasi dan regulasi berfungsi sebagai standar yang mengarahkan organisasi pelayanan kesehatan dalam mengidentifikasi, mengendalikan, serta mengevaluasi risiko secara sistematis. World Health Organization (WHO, 2021) menegaskan bahwa sistem kesehatan yang aman harus didukung oleh kebijakan, regulasi, dan standar yang kuat untuk memastikan praktik pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Dalam konteks Indonesia, penerapan manajemen risiko dalam keperawatan diintegrasikan dalam berbagai standar akreditasi seperti SNARS dan FKTP, serta diperkuat oleh regulasi Kementerian Kesehatan dan standar internasional seperti JCI. Selain itu, implementasi manajemen risiko juga berkaitan erat dengan program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) sebagai bagian dari tata kelola klinis di fasilitas pelayanan kesehatan.

1. SNARS (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit)

Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) merupakan acuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit di Indonesia. SNARS menekankan bahwa keselamatan pasien dan manajemen risiko harus menjadi bagian integral dari sistem pelayanan rumah sakit. Dalam SNARS edisi terbaru, aspek manajemen risiko terintegrasi dalam berbagai bab, terutama pada standar terkait Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP). Menurut Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS, 2022), SNARS menuntut rumah sakit untuk:

- a. Mengidentifikasi risiko secara sistematis
- b. Melakukan analisis insiden keselamatan pasien
- c. Mengimplementasikan tindakan perbaikan
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan

Selain itu, SNARS juga menekankan pentingnya budaya keselamatan pasien, pelaporan insiden, serta keterlibatan seluruh tenaga kesehatan, termasuk perawat, dalam proses manajemen risiko. Dalam praktik keperawatan, implementasi SNARS terlihat pada kegiatan seperti audit keperawatan, pelaporan insiden, supervisi klinis, serta penerapan standar keselamatan pasien dalam setiap tindakan.

2. Standar FKTP

Manajemen risiko juga diterapkan dalam standar akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti puskesmas dan klinik. Standar ini menekankan pentingnya pelayanan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Menurut Kemenkes RI (2022), standar akreditasi FKTP mengharuskan fasilitas kesehatan untuk:

- a. Melaksanakan identifikasi risiko pelayanan
- b. Menerapkan keselamatan pasien
- c. Mengelola insiden keselamatan
- d. Melakukan peningkatan mutu berkelanjutan

Dalam konteks keperawatan, implementasi manajemen risiko di FKTP meliputi pengkajian risiko pasien, edukasi kesehatan, serta pencegahan komplikasi pada tingkat pelayanan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko tidak hanya penting di rumah sakit, tetapi juga di layanan primer sebagai upaya preventif.

3. JCI (*Joint Commission International*)

JCI merupakan standar akreditasi internasional yang banyak digunakan sebagai acuan global dalam keselamatan pasien. JCI menekankan pentingnya penerapan *International Patient Safety Goals (IPSG)* sebagai bagian dari manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan.

Menurut Joint Commission International (JCI, 2021), IPSG mencakup:

- a. Identifikasi pasien secara tepat
- b. Komunikasi efektif
- c. Keamanan penggunaan obat
- d. Kepastian lokasi, prosedur, dan pasien operasi
- e. Pencegahan infeksi
- f. Pencegahan risiko jatuh

JCI juga menekankan pendekatan sistem dalam manajemen risiko, termasuk pentingnya pelaporan insiden, analisis risiko, serta implementasi tindakan perbaikan. Dalam praktik keperawatan, standar JCI mendorong perawat untuk:

- a. Menerapkan komunikasi efektif
- b. Melakukan verifikasi identitas pasien
- c. Menggunakan prinsip keselamatan dalam pemberian obat
- d. Mengidentifikasi risiko pasien secara proaktif

Dengan demikian, JCI memberikan kerangka global yang memperkuat implementasi manajemen risiko dalam pelayanan keperawatan.

4. Regulasi Kemenkes terkait keselamatan pasien

Di Indonesia, manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan diperkuat oleh berbagai regulasi dari Kementerian Kesehatan. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.

Regulasi ini menegaskan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib:

- a. Menerapkan sistem keselamatan pasien
- b. Melakukan pelaporan insiden keselamatan pasien
- c. Melaksanakan analisis insiden
- d. Melakukan pembelajaran dan perbaikan sistem

Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menekankan pentingnya mutu dan keselamatan dalam pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak pasien.

Menurut Kemenkes RI (2017; 2023), keselamatan pasien merupakan tanggung jawab seluruh tenaga kesehatan, termasuk perawat, yang harus dilakukan melalui pendekatan sistematis dan berkelanjutan. Dalam praktik keperawatan, regulasi ini menjadi dasar dalam pelaksanaan SOP, pelaporan insiden, serta penerapan budaya keselamatan pasien.

5. Integrasi dengan PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien)

Program PMKP merupakan bagian penting dalam tata kelola pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan secara berkelanjutan. PMKP mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam siklus peningkatan mutu melalui pendekatan berbasis data.

Menurut KARS (2022) dan WHO (2021), PMKP mencakup:

- a. Pengukuran indikator mutu
- b. Analisis data pelayanan
- c. Identifikasi risiko
- d. Implementasi perbaikan
- e. Monitoring dan evaluasi

Dalam praktik keperawatan, PMKP diwujudkan melalui kegiatan seperti audit keperawatan, pengukuran indikator mutu (misalnya angka jatuh pasien, HAIs), serta implementasi *continuous quality improvement* (CQI). Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk terus belajar dari data dan pengalaman dalam meningkatkan keselamatan pasien.

Integrasi manajemen risiko dengan PMKP menunjukkan bahwa keselamatan pasien bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi merupakan bagian dari sistem organisasi yang harus dikelola secara terstruktur dan berkelanjutan.

I. Tantangan dan Permasalahan dalam Implementasi Manajemen Risiko

Implementasi manajemen risiko dalam praktik keperawatan tidak selalu berjalan optimal meskipun telah tersedia standar, regulasi, dan pedoman yang jelas. Berbagai tantangan dan permasalahan masih sering ditemukan di lapangan, baik yang berasal dari faktor individu, organisasi, maupun sistem pelayanan kesehatan. WHO (2021) menegaskan bahwa keberhasilan manajemen risiko sangat bergantung pada budaya organisasi, sistem pelaporan, kompetensi tenaga kesehatan, serta dukungan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai hambatan dalam implementasi menjadi penting untuk merancang strategi perbaikan yang efektif.

1. Budaya menyalahkan (*blaming culture*)

Salah satu tantangan utama dalam implementasi manajemen risiko adalah masih adanya budaya menyalahkan (*blaming culture*) dalam organisasi pelayanan kesehatan. Budaya ini ditandai dengan kecenderungan untuk menyalahkan individu ketika terjadi kesalahan, tanpa mempertimbangkan faktor sistem yang berkontribusi terhadap kejadian tersebut.

Menurut Reason (2000), sebagian besar kesalahan dalam pelayanan kesehatan disebabkan oleh kegagalan sistem, bukan semata kesalahan individu. Namun, dalam praktiknya, pendekatan yang menyalahkan individu masih sering terjadi, sehingga tenaga kesehatan menjadi enggan untuk melaporkan kesalahan. WHO (2021) juga menegaskan bahwa budaya menyalahkan dapat menghambat pembelajaran organisasi dan menurunkan efektivitas sistem keselamatan pasien.

Dalam konteks keperawatan, budaya ini dapat menyebabkan perawat merasa takut terhadap sanksi atau stigma, sehingga memilih untuk tidak melaporkan kesalahan atau near miss. Akibatnya, organisasi kehilangan kesempatan untuk melakukan perbaikan sistem secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan perubahan menuju just culture, yang menyeimbangkan antara akuntabilitas individu dan tanggung jawab sistem (Vaismoradi et al., 2020).

2. Underreporting incident

Underreporting atau pelaporan insiden yang tidak optimal merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam sistem manajemen risiko. Banyak insiden keselamatan pasien yang tidak dilaporkan, baik karena ketakutan terhadap hukuman, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelaporan, maupun rendahnya kepercayaan terhadap sistem pelaporan.

WHO (2021) menyatakan bahwa sistem pelaporan insiden yang efektif harus bersifat tidak menghakimi, anonim, dan berorientasi pada pembelajaran. Namun, penelitian menunjukkan bahwa tenaga kesehatan sering tidak melaporkan

insiden karena khawatir terhadap konsekuensi profesional maupun hukum (Vaismoradi et al., 2020).

Dalam praktik keperawatan, *underreporting* berdampak pada tidak tersedianya data yang akurat untuk analisis risiko, sehingga upaya perbaikan menjadi tidak optimal. AHRQ (2022) menekankan bahwa pelaporan insiden merupakan sumber utama pembelajaran dalam keselamatan pasien, sehingga perlu didorong melalui sistem yang aman dan budaya organisasi yang mendukung.

3. Keterbatasan SDM

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) merupakan tantangan signifikan dalam implementasi manajemen risiko. Rasio tenaga kesehatan yang tidak seimbang dengan jumlah pasien dapat meningkatkan beban kerja, menurunkan kualitas pengawasan, serta meningkatkan risiko terjadinya kesalahan.

WHO (2023) melaporkan bahwa kekurangan tenaga kesehatan merupakan masalah global yang berdampak pada kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Dalam praktik keperawatan, keterbatasan SDM dapat menyebabkan:

- a. Peningkatan missed nursing care
- b. Keterlambatan tindakan
- c. Penurunan kualitas komunikasi
- d. Risiko kelelahan tenaga kesehatan

AHRQ (2022) juga menyatakan bahwa kondisi *understaffing* berhubungan dengan peningkatan kejadian tidak diharapkan, termasuk peningkatan mortalitas pasien. Oleh karena itu, manajemen SDM menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi manajemen risiko.

4. Kurangnya pelatihan

Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan menjadi hambatan dalam penerapan manajemen risiko yang efektif. Tenaga kesehatan yang tidak mendapatkan pelatihan yang memadai cenderung memiliki pemahaman yang terbatas mengenai keselamatan pasien, identifikasi risiko, serta prosedur pelaporan insiden.

Menurut WHO (2021), pendidikan dan pelatihan berkelanjutan merupakan komponen penting dalam membangun sistem keselamatan pasien yang efektif. Selain itu, Carayon et al. (2020) menekankan bahwa peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam aspek *human factors* dan keselamatan pasien dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pelayanan.

5. Dalam praktik keperawatan, pelatihan diperlukan tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan klinis, tetapi juga untuk memperkuat pemahaman mengenai manajemen risiko, komunikasi efektif, serta budaya keselamatan

pasien. Tanpa pelatihan yang memadai, implementasi kebijakan dan SOP sering kali tidak berjalan optimal.

5. Variasi kepatuhan terhadap SOP

Kepatuhan terhadap Standar Prosedur Operasional (SOP) merupakan faktor penting dalam menjaga keselamatan pasien. Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan variasi kepatuhan antar tenaga kesehatan maupun antar unit pelayanan.

AHRQ (2022) menyatakan bahwa ketidakpatuhan terhadap SOP dapat meningkatkan risiko kesalahan dan menurunkan kualitas pelayanan. Variasi kepatuhan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:

- a. Kurangnya pemahaman terhadap SOP
- b. Beban kerja tinggi
- c. Budaya kerja yang tidak konsisten
- d. Kurangnya supervisi

Menurut WHO (2021), kepatuhan terhadap standar keselamatan pasien harus didukung oleh sistem yang kuat, termasuk pelatihan, monitoring, serta budaya organisasi yang mendukung keselamatan.

Dalam praktik keperawatan, ketidakpatuhan terhadap SOP dapat berdampak pada berbagai risiko, seperti kesalahan pemberian obat, infeksi nosokomial, serta kesalahan dokumentasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan melalui audit, supervisi, dan penguatan budaya keselamatan.

J. Strategi Peningkatan Manajemen Risiko dalam Keperawatan

Peningkatan manajemen risiko dalam praktik keperawatan merupakan langkah strategis untuk memastikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Berbagai tantangan dalam implementasi manajemen risiko menuntut adanya strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, yang mencakup penguatan kompetensi tenaga kesehatan, pengembangan sistem pelaporan, serta pemanfaatan teknologi. WHO (2021) menegaskan bahwa peningkatan keselamatan pasien memerlukan pendekatan sistemik yang melibatkan perubahan budaya, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penggunaan data dan teknologi secara optimal.

1. Penguatan pelatihan *patient safety*

Pelatihan keselamatan pasien (*patient safety training*) merupakan strategi utama dalam meningkatkan pemahaman dan kompetensi tenaga keperawatan dalam mengelola risiko. Pelatihan ini mencakup aspek identifikasi risiko,

komunikasi efektif, pelaporan insiden, serta penerapan standar keselamatan pasien dalam praktik klinis.

Menurut WHO (2021), pendidikan dan pelatihan berkelanjutan merupakan komponen penting dalam membangun sistem keselamatan pasien yang efektif. Selain itu, Carayon et al. (2020) menekankan bahwa peningkatan kompetensi dalam aspek *human factors* dapat membantu tenaga kesehatan memahami bagaimana kesalahan terjadi dan bagaimana mencegahnya.

Dalam praktik keperawatan, pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap SOP, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan klinis, serta memperkuat budaya keselamatan pasien. Oleh karena itu, institusi pelayanan kesehatan perlu memastikan bahwa program pelatihan patient safety menjadi bagian dari pengembangan profesional berkelanjutan (*continuing professional development*).

2. Digitalisasi pelaporan insiden

Digitalisasi pelaporan insiden merupakan inovasi penting dalam meningkatkan efektivitas sistem manajemen risiko. Sistem pelaporan berbasis digital memungkinkan pencatatan insiden secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi, sehingga memudahkan analisis data dan pengambilan keputusan.

AHRQ (2022) menyatakan bahwa sistem pelaporan yang baik harus mudah digunakan, aman, serta mampu menghasilkan data yang dapat digunakan untuk pembelajaran organisasi. Digitalisasi juga memungkinkan pelaporan dilakukan secara anonim, sehingga dapat mengurangi hambatan pelaporan akibat ketakutan terhadap sanksi.

Dalam praktik keperawatan, penggunaan sistem digital membantu perawat dalam melaporkan insiden secara real-time, meningkatkan transparansi, serta mempercepat proses tindak lanjut. Selain itu, data yang terkumpul dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren risiko dan merancang strategi pencegahan yang lebih efektif (WHO, 2021).

3. Audit dan feedback berkala

Audit dan feedback merupakan strategi penting dalam memastikan bahwa praktik pelayanan keperawatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Audit dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap SOP, sedangkan feedback diberikan untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Menurut AHRQ (2022), audit yang disertai dengan feedback yang konstruktif terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap praktik keselamatan pasien. Feedback yang diberikan secara berkala dapat membantu tenaga kesehatan memahami kesenjangan antara praktik yang dilakukan dan standar yang diharapkan.

Dalam praktik keperawatan, audit dapat dilakukan pada berbagai aspek, seperti hand hygiene, pemberian obat, dokumentasi, serta pencegahan infeksi. Feedback yang diberikan harus bersifat edukatif dan mendukung, sehingga dapat mendorong perubahan perilaku tanpa menimbulkan resistensi (WHO, 2021).

4. Simulasi klinis (simulation-based training)

Simulasi klinis merupakan metode pelatihan yang menggunakan skenario klinis untuk melatih keterampilan teknis dan non-teknis tenaga kesehatan dalam lingkungan yang aman. Pendekatan ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk belajar dari kesalahan tanpa membahayakan pasien.

Menurut Lateef (2010) dan diperkuat oleh WHO (2021), *simulation-based training* efektif dalam meningkatkan keterampilan klinis, komunikasi tim, serta kemampuan pengambilan keputusan dalam situasi kritis. Simulasi juga membantu tenaga kesehatan dalam memahami dinamika tim dan meningkatkan koordinasi antarprofesi.

Dalam praktik keperawatan, simulasi dapat digunakan untuk melatih berbagai situasi berisiko tinggi, seperti kegawatdaruratan, resusitasi, serta penanganan pasien dengan kondisi kritis. Dengan demikian, simulasi menjadi strategi penting dalam meningkatkan kesiapan perawat dalam menghadapi risiko klinis.

5. Leadership kepala ruangan dalam manajemen risiko

Kepemimpinan kepala ruangan memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi manajemen risiko di unit keperawatan. Kepala ruangan berfungsi sebagai penggerak utama dalam menciptakan budaya keselamatan pasien, memastikan kepatuhan terhadap standar, serta mengelola sumber daya secara efektif.

Menurut Wong et al. (2013), kepemimpinan yang efektif berhubungan dengan peningkatan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan. Selain itu, AHRQ (2022) menekankan bahwa pemimpin klinis memiliki peran penting dalam mendorong pelaporan insiden, memberikan feedback, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman. Dalam praktik keperawatan, kepala ruangan harus mampu:

- a. Melakukan supervisi klinis
- b. Mendorong komunikasi terbuka
- c. Memfasilitasi pelaporan insiden
- d. Mengelola beban kerja staf

Dengan kepemimpinan yang kuat, implementasi manajemen risiko dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

6. Integrasi dengan teknologi (Clinical Decision Support System)

Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan, khususnya *Clinical Decision Support System* (CDSS), merupakan strategi penting dalam meningkatkan manajemen risiko. CDSS adalah sistem berbasis komputer yang memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan klinis melalui penyediaan informasi dan rekomendasi berbasis data.

Menurut Sutton et al. (2020), CDSS dapat meningkatkan keselamatan pasien dengan mengurangi kesalahan klinis, terutama dalam pemberian obat dan diagnosis. Sistem ini dapat memberikan peringatan terkait interaksi obat, alergi, serta dosis yang tidak sesuai. Dalam praktik keperawatan, CDSS membantu perawat dalam:

- a. Verifikasi pemberian obat
- b. Pengambilan keputusan klinis
- c. Dokumentasi elektronik
- d. Pemantauan kondisi pasien

WHO (2021) juga menekankan bahwa integrasi teknologi dalam pelayanan kesehatan dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan pasien, asalkan didukung oleh pelatihan dan sistem yang memadai.

K. Studi Kasus dan Analisis Risiko dalam Praktik Keperawatan

Studi kasus merupakan metode pembelajaran yang efektif dalam memahami penerapan manajemen risiko dalam praktik keperawatan. Melalui analisis kasus nyata, tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi faktor penyebab insiden, memahami kelemahan sistem, serta merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif. WHO (2021) menegaskan bahwa pembelajaran dari insiden (*learning from patient safety incidents*) merupakan komponen penting dalam meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan.

1. Kasus *medication error*

Salah satu contoh kasus yang sering terjadi dalam praktik keperawatan adalah *medication error*. Misalnya, seorang pasien rawat inap menerima obat antihipertensi dengan dosis dua kali lipat dari yang diresepkan. Kesalahan ini terjadi karena perawat salah membaca label obat yang memiliki kemiripan nama (*look-alike sound-alike drugs*), serta tidak dilakukan proses *double check* sebelum pemberian obat.

Menurut WHO (2021), medication error merupakan salah satu penyebab utama avoidable harm dalam pelayanan kesehatan, dan sebagian besar kesalahan terjadi pada tahap pemberian obat. Selain itu, AHRQ (2022) menyatakan bahwa faktor yang berkontribusi terhadap kesalahan obat meliputi gangguan saat

bekerja (interruption), kelelahan tenaga kesehatan, serta sistem pelabelan obat yang tidak jelas.

Dalam konteks keperawatan, kasus ini menunjukkan bahwa risiko tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dari sistem kerja, seperti desain label obat dan kurangnya penerapan prosedur keselamatan.

2. Kasus pasien jatuh

Kasus lain yang sering terjadi adalah jatuh pada pasien rawat inap. Sebagai contoh, seorang pasien lansia dengan gangguan mobilitas jatuh saat mencoba pergi ke kamar mandi tanpa bantuan. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa pasien memiliki risiko jatuh tinggi, namun intervensi pencegahan seperti pemasangan pengaman tempat tidur dan edukasi keluarga tidak dilakukan secara optimal.

AHRQ (2022) menyatakan bahwa jatuh pasien merupakan salah satu insiden keselamatan yang paling sering terjadi di rumah sakit dan dapat menyebabkan cedera serius. Faktor risiko jatuh meliputi usia lanjut, gangguan mobilitas, penggunaan obat sedatif, serta lingkungan yang tidak aman.

Kasus ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam implementasi intervensi preventif dapat meningkatkan risiko kejadian tidak diharapkan, meskipun risiko telah diidentifikasi sebelumnya.

3. Analisis RCA sederhana

Untuk memahami penyebab insiden secara lebih mendalam, dilakukan analisis menggunakan metode *Root Cause Analysis* (RCA). RCA merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab suatu kejadian, dengan tujuan mencegah kejadian serupa di masa depan (WHO, 2021; AHRQ, 2022). Pada kasus *medication error*, analisis RCA sederhana dapat mengidentifikasi beberapa faktor penyebab, antara lain:

- a. Faktor manusia: kelelahan dan kurangnya konsentrasi
- b. Faktor sistem: label obat yang mirip
- c. Faktor prosedur: tidak dilakukan *double check*
- d. Faktor lingkungan: gangguan saat pemberian obat

Sedangkan pada kasus pasien jatuh, faktor penyebab meliputi:

- a. Tidak dilakukan intervensi pencegahan secara konsisten
- b. Kurangnya edukasi pasien dan keluarga
- c. Pengawasan yang tidak optimal
- d. Lingkungan yang tidak aman

Menurut Reason (2000), kesalahan dalam pelayanan kesehatan biasanya terjadi akibat kombinasi *active failure* dan *latent conditions*, sehingga analisis harus mencakup kedua aspek tersebut.

4. Pembelajaran dari insiden (*lesson learned*)

Pembelajaran dari insiden merupakan langkah penting dalam manajemen risiko untuk mencegah terjadinya kejadian berulang. Setiap insiden harus dianalisis dan digunakan sebagai bahan perbaikan sistem pelayanan.

Menurut Vaismoradi et al. (2020), pembelajaran dari insiden dapat meningkatkan kesadaran tenaga kesehatan terhadap keselamatan pasien serta memperkuat budaya keselamatan dalam organisasi. Selain itu, WHO (2021) menekankan bahwa organisasi pelayanan kesehatan harus mampu mengubah insiden menjadi peluang pembelajaran melalui sistem pelaporan yang efektif. Beberapa *lesson learned* dari kasus di atas antara lain:

- a. Pentingnya penerapan prinsip safe medication administration
- b. Perlunya sistem double check pada obat berisiko tinggi
- c. Pentingnya pengkajian dan intervensi risiko jatuh secara konsisten
- d. Perlunya komunikasi efektif antar tenaga kesehatan
- e. Pentingnya penguatan budaya keselamatan pasien

Dalam praktik keperawatan, pembelajaran dari insiden harus diintegrasikan dalam kegiatan audit, pelatihan, serta peningkatan mutu pelayanan. Dengan demikian, setiap kejadian tidak diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran untuk meningkatkan keselamatan pasien.

L. Penutup

Manajemen risiko dalam praktik keperawatan merupakan komponen esensial dalam menjamin keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa risiko dalam pelayanan keperawatan bersifat multidimensi, yang mencakup aspek klinis, non-klinis, serta sistem organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan risiko tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Konsep dasar manajemen risiko memberikan landasan penting dalam memahami bagaimana risiko diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi, dan dikendalikan melalui siklus manajemen risiko. Pendekatan ini diperkuat oleh berbagai kerangka teori, seperti model ISO 31000, *Swiss Cheese Model*, serta prinsip *High Reliability Organization*, yang menekankan bahwa keselamatan pasien sangat dipengaruhi oleh ketahanan sistem, bukan hanya kinerja individu. Dengan demikian, kesalahan

dalam pelayanan kesehatan harus dipandang sebagai peluang pembelajaran untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh (WHO, 2021; Reason, 2000).

Dalam praktik keperawatan, berbagai jenis risiko seperti medication error, jatuh pasien, infeksi terkait pelayanan kesehatan, serta risiko komunikasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa perawat berada pada posisi strategis dalam mencegah kejadian tidak diharapkan. Implementasi manajemen risiko dalam asuhan keperawatan menuntut integrasi pada setiap tahap proses keperawatan, mulai dari pengkajian berbasis risiko hingga dokumentasi yang akurat dan sistematis. Penggunaan clinical pathway, bundle care, serta *early warning system* menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas pencegahan risiko.

Peran perawat sebagai frontliner dalam keselamatan pasien semakin diperkuat melalui keterlibatan aktif dalam pelaporan insiden, penerapan komunikasi efektif, serta edukasi pasien dan keluarga. Namun, keberhasilan implementasi manajemen risiko juga sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi, khususnya dalam membangun *just culture* dan *no blame culture*, yang mendorong pembelajaran dari kesalahan tanpa rasa takut.

Dalam perspektif akreditasi dan regulasi, manajemen risiko telah menjadi bagian integral dari standar pelayanan kesehatan, baik pada tingkat nasional melalui SNARS dan FKTP, maupun pada tingkat internasional melalui JCI. Integrasi dengan program PMKP menunjukkan bahwa manajemen risiko tidak hanya berfokus pada pencegahan insiden, tetapi juga pada peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi dalam implementasi manajemen risiko, seperti budaya menyalahkan, underreporting insiden, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, serta variasi kepatuhan terhadap SOP. Tantangan ini menegaskan perlunya strategi peningkatan yang komprehensif, termasuk penguatan pelatihan keselamatan pasien, digitalisasi sistem pelaporan, audit dan feedback berkala, simulasi klinis, kepemimpinan yang efektif, serta pemanfaatan teknologi seperti *Clinical Decision Support System* (AHRQ, 2022; WHO, 2021).

Studi kasus dalam praktik keperawatan memberikan gambaran nyata bahwa insiden keselamatan pasien sering kali terjadi akibat kombinasi faktor individu dan sistem. Melalui pendekatan seperti *Root Cause Analysis*, setiap insiden dapat dianalisis secara mendalam untuk menemukan akar penyebab dan menghasilkan pembelajaran yang berharga bagi organisasi. Dengan demikian, setiap kejadian tidak diharapkan harus dimaknai sebagai peluang untuk meningkatkan sistem pelayanan yang lebih aman.

Pada akhirnya, manajemen risiko dalam keperawatan bukan hanya tanggung jawab individu perawat, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh organisasi pelayanan kesehatan. Keberhasilan implementasi manajemen risiko sangat bergantung pada komitmen kolektif, budaya keselamatan yang kuat, serta sistem yang mendukung praktik yang aman. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan pelayanan keperawatan dapat memberikan asuhan yang tidak hanya efektif, tetapi juga aman dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Referensi

- Agency for Healthcare Research and Quality. (2022). *Making healthcare safer III: A critical analysis of existing and emerging patient safety practices*. AHRQ.
- Agency for Healthcare Research and Quality. (2022). *Patient safety and quality improvement resources*. <https://www.ahrq.gov>
- Alquwez, N., Cruz, J. P., Almoghairi, A. M., et al. (2021). Nurses' perception of patient safety culture in hospitals. *Journal of Nursing Management*, 29(3), 504–513.
- Carayon, P., Wooldridge, A., Hose, B. Z., et al. (2020). Human factors systems approach to healthcare quality and patient safety. *Applied Ergonomics*, 82, 102994.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2023). *Healthcare worker safety and burnout*. <https://www.cdc.gov>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *Healthcare-associated infections (HAIs)*. <https://www.cdc.gov>
- Connor, M. (2023). Evidence-based practice in nursing and healthcare improvement. *Nursing Outlook*, 71(2), 101–108.
- Institute for Healthcare Improvement. (2020). *Improvement science and patient safety*. <http://www.ihi.org>
- International Council of Nurses. (2021). *The ICN code of ethics for nurses*. ICN.
- International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000: Risk management—Guidelines*. ISO.
- Joint Commission International. (2021). *Joint Commission International accreditation standards for hospitals* (7th ed.). JCI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS)*. Kemenkes RI.
- Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2019). *Evidence-based practice in nursing & healthcare* (4th ed.). Wolters Kluwer.
- National Academy of Medicine. (2022). *Addressing clinician burnout: A systems approach*. NAM.
- National Institute for Occupational Safety and Health. (2015). *Hierarchy of controls*. CDC.
- National Institute for Occupational Safety and Health. (2023). *Workplace safety and health topics*. CDC.
- National Pressure Injury Advisory Panel. (2023). *Prevention and treatment of pressure injuries*. NPIAP.
- Reason, J. (2000). *Human error: Models and management*. BMJ, 320(7237), 768–770.
- Royal College of Physicians. (2017). *National Early Warning Score (NEWS2)*. RCP.

- Salas, E., Reyes, D. L., & McDaniel, S. H. (2020). The science of teamwork in healthcare. *American Psychologist*, 75(4), 517–529.
- The Joint Commission. (2021). *Sentinel event data and root cause analyses*. The Joint Commission.
- Vaismoradi, M., Griffiths, P., Turunen, H., & Jordan, S. (2020). Transformational leadership in patient safety. *Nursing Open*, 7(2), 1–10.
- Weick, K. E., & Sutcliffe, K. M. (2015). *Managing the unexpected: Sustained performance in a complex world* (3rd ed.). Wiley.
- World Health Organization. (2017). *Medication without harm: Global patient safety challenge*. WHO.
- World Health Organization. (2021). *Global patient safety action plan 2021–2030*. WHO.
- World Health Organization. (2023). *Patient safety and healthcare quality reports*. WHO.
- World Health Organization. (2024). *Health workforce and patient safety*. WHO.

Glosarium

A

AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality): Lembaga di Amerika Serikat yang berfokus pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien melalui penelitian dan pengembangan sistem pelayanan kesehatan.

APD (Alat Pelindung Diri): Peralatan yang digunakan tenaga kesehatan untuk melindungi diri dari paparan bahaya, seperti masker, sarung tangan, dan *face shield*.

B

Blaming Cultur: Budaya organisasi yang cenderung menyalahkan individu atas kesalahan tanpa mempertimbangkan faktor sistem.

Bundle Care: Sekelompok intervensi berbasis bukti yang dilakukan secara bersamaan untuk meningkatkan hasil klinis pasien.

C

Clinical Decision Support System (CDSS): Sistem berbasis teknologi yang membantu tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis melalui analisis data dan rekomendasi berbasis bukti.

Clinical Pathway: Panduan pelayanan pasien yang terstruktur berdasarkan diagnosis tertentu untuk memastikan pelayanan yang konsisten dan berbasis bukti.

Continuous Quality Improvement (CQI): Pendekatan peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui siklus *Plan-Do-Check-Act* (PDCA).

D

Diagnosis Risiko: Pernyataan klinis yang menggambarkan potensi masalah yang dapat terjadi pada pasien jika tidak dilakukan intervensi pencegahan.

E

Early Warning System (EWS): Sistem deteksi dini yang digunakan untuk mengidentifikasi perburukan kondisi pasien melalui parameter fisiologis.

Engineering Control: Strategi pengendalian risiko melalui desain sistem atau alat untuk mengurangi paparan terhadap bahaya.

F

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA): Metode analisis prospektif untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dalam suatu proses sebelum terjadi insiden.

H

Hazard (Bahaya): Sumber potensi kerugian atau cedera yang dapat menimbulkan risiko jika tidak dikendalikan.

Hierarchy of Controls: Pendekatan berlapis dalam pengendalian risiko yang terdiri dari eliminasi, substitusi, pengendalian teknis, administratif, dan APD.

I

Insiden Keselamatan Pasien: Kejadian yang dapat menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera pada pasien.

IPSG (*International Patient Safety Goals*): Standar keselamatan pasien internasional yang dikembangkan oleh Joint Commission International.

J

JCI (*Joint Commission International*): Lembaga akreditasi internasional yang menetapkan standar keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan.

Just Culture: Budaya organisasi yang menyeimbangkan antara akuntabilitas individu dan tanggung jawab sistem dalam menangani kesalahan.

K

KNC (Kejadian Nyaris Cedera): Insiden yang tidak menyebabkan cedera pada pasien tetapi berpotensi menimbulkan bahaya.

KPC (Kejadian Potensial Cedera): Kondisi yang berpotensi menyebabkan cedera tetapi belum terjadi insiden.

KTC (Kejadian Tidak Cedera): Insiden yang terjadi tetapi tidak menimbulkan cedera pada pasien.

M

Manajemen Risiko: Proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko.

Medication Error: Kesalahan dalam proses penggunaan obat yang dapat membahayakan pasien.

Monitoring dan Evaluasi: Proses pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas tindakan pengendalian risiko.

N

No Blame Culture: Budaya organisasi yang mendorong pelaporan kesalahan tanpa memberikan hukuman kepada individu.

P

Patient Safety (Keselamatan Pasien): Upaya untuk mencegah dan mengurangi risiko cedera pada pasien selama pelayanan kesehatan.

PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien): Program yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien secara berkelanjutan.

Pressure Injury. Kerusakan jaringan akibat tekanan berkepanjangan pada area tubuh tertentu.

R

Risk Matrix. Alat untuk menilai tingkat risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak.

Risk Register. Dokumen yang mencatat seluruh risiko yang telah diidentifikasi, termasuk analisis dan rencana mitigasinya.

Root Cause Analysis (RCA): Metode analisis retrospektif untuk mengidentifikasi akar penyebab suatu insiden.

S

SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*): Metode komunikasi terstruktur yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.

Sentinel Event. Insiden serius yang menyebabkan kematian atau cedera permanen pada pasien.

SNARS (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit): Standar akreditasi yang digunakan di Indonesia untuk menilai mutu dan keselamatan pelayanan rumah sakit.

Swiss Cheese Model. Model yang menjelaskan bahwa kesalahan terjadi akibat kegagalan berlapis dalam sistem.

U

Underreporting. Kondisi di mana insiden keselamatan pasien tidak dilaporkan secara optimal.

BAB 4

DEBRIDEMENT, INDIKASI, TEKNIK DAN PERAN PERAWAT

A. Pendahuluan

Komunikasi dalam perawatan kesehatan adalah proses pertukaran informasi, ide, instruksi, dan makna antara para profesional perawatan kesehatan, pasien, keluarga, dan pihak lain yang terlibat dalam proses perawatan, dengan tujuan mendukung pengambilan keputusan klinis, kesinambungan perawatan, dan keselamatan pasien. Dalam konteks keperawatan, komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang membangun hubungan terapeutik, memahami kebutuhan pasien, dan mengoordinasikan tindakan di antara anggota tim perawatan kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia menekankan bahwa komunikasi yang aman, tepat waktu, dan efektif merupakan komponen inti dari sistem perawatan kesehatan yang berpusat pada pasien (Organisasi Kesehatan Dunia [WHO], 2021). Komunikasi dalam perawatan kesehatan kompleks karena sifat multi-profesional dari proses tersebut, sifat dinamis dari situasi klinis, tekanan waktu, dan kebutuhan akan dokumentasi yang akurat. Perawat, sebagai profesi yang paling ering berinteraksi dengan pasien, memainkan peran sentral dalam alur komunikasi ini. Oleh karena itu, kompetensi komunikasi merupakan komponen penting dari profesionalisme keperawatan (Arnold & Boggs, 2020).

Komunikasi Merupakan Faktor Penting dalam Keselamatan Pasien. Keselamatan pasien adalah upaya untuk mencegah cedera yang dapat dihindari selama proses perawatan kesehatan. Salah satu penyebab utama kejadian buruk adalah kegagalan komunikasi. Informasi yang tidak lengkap, tertunda, ambigu, atau tidak tersampaikan dapat menyebabkan keputusan klinis yang salah.

The Joint Commission melaporkan bahwa kegagalan komunikasi adalah salah satu faktor penyumbang terbesar terhadap kejadian sentinel di rumah sakit. Kesalahan komunikasi sering terjadi selama serah terima, konsultasi telepon, penulisan perintah medis, dan koordinasi antarprofesional (The Joint Commission, 2022). Komunikasi sangat penting karena setiap proses klinis bergantung pada pertukaran informasi: mulai dari identifikasi pasien dan pemberian obat hingga interpretasi hasil laboratorium dan respons darurat. Tanpa komunikasi yang efektif, bahkan tenaga kesehatan yang kompeten pun berisiko melakukan kesalahan.

Komunikasi dan Kualitas Pelayanan Keperawatan. Kualitas pelayanan keperawatan mencakup keselamatan, efektivitas, ketepatan waktu, efisiensi, dan

kepuasan pasien. Semua dimensi ini dipengaruhi oleh kualitas komunikasi. Perawat yang berkomunikasi dengan jelas dan empatik cenderung meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi, mengurangi kecemasan, dan memperkuat kepercayaan pasien terhadap pelayanan. Sebaliknya, komunikasi antar perawat dan dengan profesional lain menentukan kesinambungan perawatan. Dokumentasi yang jelas membantu shift berikutnya memahami kondisi pasien. Konfirmasi perintah dokter yang benar membantu mencegah kesalahan. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif bukan hanya keterampilan interpersonal, tetapi juga indikator kualitas perawatan keperawatan (Institut Kedokteran, 2001).

Tinjauan Insiden Keselamatan Pasien Akibat Miskomunikasi. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa miskomunikasi berkontribusi pada kesalahan pengobatan, intervensi yang tertunda, prosedur yang salah, dan kegagalan untuk mengenali kondisi pasien yang memburuk. Tinjauan sistematis oleh Müller dkk. (2018) menunjukkan bahwa implementasi komunikasi terstruktur, seperti SBAR, dikaitkan dengan peningkatan keselamatan pasien, secara tidak langsung mengkonfirmasi bahwa masalah komunikasi yang signifikan telah ada sebelum intervensi. Contoh insiden yang sering terjadi akibat miskomunikasi meliputi:

1. Pemberian obat kepada pasien yang salah karena identifikasi tidak dikonfirmasi;
2. Hasil laboratorium kritis tidak dilaporkan dengan segera;
3. Pasien dengan penurunan saturasi tidak segera diobati karena informasi tidak disampaikan;
4. Instruksi verbal dokter disalahpahami oleh perawat.

Situasi-situasi ini menunjukkan bahwa komunikasi adalah pilar utama keselamatan pasien.

B. Konsep Komunikasi Efektif dalam Praktik Keperawatan

Komunikasi yang efektif adalah proses penyampaian informasi yang menghasilkan pemahaman bersama antara pengirim dan penerima, sehingga pesan dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dalam keperawatan, komunikasi yang efektif berarti informasi klinis disampaikan dengan jelas, lengkap, akurat, dan tepat waktu untuk mendukung perawatan pasien (Arnold & Boggs, 2020). Komunikasi dianggap efektif ketika penerima memahami pesan sebagaimana dimaksud oleh pengirim, bukan hanya informasi yang mereka dengar.

Elemen Komunikasi terdiri dari : 1) Komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan. Dalam konteks keperawatan, ini bisa berupa perawat, dokter, pasien, atau anggota keluarga. 2). Pesan adalah Isi informasi yang disampaikan, seperti kondisi pasien, instruksi pengobatan, pendidikan kesehatan, atau keluhan

pasien. 3) Media adalah saluran komunikasi, seperti percakapan tatap muka, telepon, rekam medis elektronik, bentuk tertulis, atau aplikasi digital. 4). Penerima

Individu atau kelompok yang menerima pesan. 5). Umpan Balik adalah Respons penerima terhadap pesan, seperti klarifikasi, pengulangan instruksi, atau tindakan tindak lanjut. Umpan balik sangat penting untuk memastikan pesan dipahami dengan benar (McCorry & Mason, 2020).

Prinsip-prinsip Komunikasi Terapeutik dan Profesional. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang bertujuan membantu pasien mencapai kesehatan optimal. Prinsip-prinsip utamanya meliputi empati, mendengarkan secara aktif, menghormati martabat pasien, menjaga kerahasiaan, dan menggunakan bahasa yang dapat dipahami pasien.

Komunikasi profesional menekankan akuntabilitas, objektivitas, kejelasan, dan batasan profesional. Perawat harus menghindari komunikasi yang menghakimi, terlalu emosional, atau menyesatkan (Potter dkk., 2021).

Karakteristik Komunikasi Efektif dalam Lingkungan Klinis. Komunikasi efektif dalam lingkungan klinis dicirikan oleh: ringkas namun komprehensif; menggunakan terminologi yang jelas; berdasarkan data objektif; tepat waktu; terdokumentasi; memungkinkan klarifikasi; berorientasi pada keselamatan pasien. Dalam situasi darurat, komunikasi harus lebih ringkas dan langsung pada intinya.

C. Jenis Komunikasi dalam Pelayanan Keperawatan

Jenis komunikasi dalam pelayanan keperawatan adalah:

Komunikasi Verbal: Komunikasi verbal menggunakan kata-kata lisan atau tertulis. Dalam praktik keperawatan, komunikasi verbal digunakan selama pengambilan riwayat pasien, edukasi pasien, serah terima, konsultasi dokter, dan diskusi tim. Keuntungannya adalah cepat dan interaktif, tetapi membawa risiko salah tafsir jika tidak jelas (Arnold & Boggs, 2020).

Komunikasi Nonverbal : Komunikasi nonverbal meliputi ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tubuh, nada suara, postur, dan sentuhan terapeutik. Bagi pasien yang kesulitan berbicara, aspek nonverbal sangat penting. Misalnya, pasien mungkin meringis, menunjukkan rasa sakit meskipun mereka tidak mengeluh.

Perbedaan antara pesan verbal dan nonverbal dapat menyebabkan kebingungan.

Komunikasi/dokumentasi tertulis : dokumentasi keperawatan adalah bentuk komunikasi profesional yang sangat penting. Catatan perkembangan pasien, pemberian obat, respons terapi, dan rencana tindak lanjut berfungsi sebagai sumber informasi bagi seluruh tim perawatan kesehatan. Dokumentasi yang tidak lengkap meningkatkan risiko kesalahan dan masalah hukum (Potter dkk., 2021).

Komunikasi digital dan sistem informasi rumah sakit : Kemajuan teknologi mendorong penggunaan rekam medis elektronik, sistem pemesanan dokter berbasis komputer, aplikasi internal rumah sakit, dan telemedisin. Sistem digital dapat meningkatkan akses informasi dan mengurangi kebutuhan akan tulisan tangan yang sulit dibaca. Namun, keamanan data dan pelatihan pengguna sangat penting (WHO, 2021).

Komunikasi Antarprofesional dalam Pelayanan Kesehatan: perawatan pasien modern membutuhkan kolaborasi antara dokter, perawat, apoteker, ahli gizi, fisioterapis, analis laboratorium, dan profesional lainnya. Komunikasi antarprofesional yang baik meningkatkan koordinasi, mengurangi duplikasi tindakan, dan mempercepat pengambilan keputusan klinis. Pendekatan praktik kolaboratif antarprofesional direkomendasikan secara global untuk meningkatkan keselamatan pasien.

D. Hambatan Komunikasi di Lingkungan Pelayanan Kesehatan

Beban Kerja Tinggi dan Kelelahan Petugas Kesehatan: beban pasien yang tinggi, kekurangan staf, dan jam kerja yang panjang dapat mengurangi konsentrasi. Petugas kesehatan yang lelah lebih cenderung melupakan informasi penting atau salah memahami instruksi (Carayon & Gurses, 2008). Perbedaan Persepsi Antar Profesional : setiap profesi memiliki perspektif yang berbeda. Dokter mungkin fokus pada diagnosis medis, sementara perawat menilai respons harian pasien. Tanpa pemahaman bersama, informasi dapat terabaikan atau disalahartikan. Hierarki Organisasi: budaya hierarki menghalangi staf junior untuk menyampaikan kekhawatiran kepada senior. Keterlambatan dalam mengkomunikasikan kondisi pasien dapat membahayakan keselamatan pasien. Bahasa Medis yang Tidak Jelas : Istilah-istilah ambigu seperti "nanti," "cukup stabil," atau singkatan non-standar dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda. Oleh karena itu, banyak rumah sakit membatasi penggunaan singkatan tertentu. Gangguan Lingkungan Kerja: lingkungan yang bising, panggilan telepon berulang, alarm monitor, dan gangguan selama pemberian obat dapat mengganggu fokus. Gangguan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan.

Budaya Menyalahkan: jika staf takut dihukum karena melaporkan kesalahan atau kejadian nyaris celaka, mereka cenderung tetap diam. Budaya keselamatan menuntut pendekatan pembelajaran, bukan sekadar menyalahkan (Reason, 2000).

E. Dampak Miskomunikasi terhadap Keselamatan Pasien

Kesalahan Pemberian Obat. Kesalahpahaman dapat mengakibatkan pemberian obat kepada pasien yang salah, dosis yang salah, waktu yang salah, atau rute yang salah. Misalnya, jika instruksi verbal tidak diulang, nama obat dapat salah didengar.

Kesalahan Identifikasi Pasien. Jika identitas pasien tidak diverifikasi menggunakan dua pengenalan, prosedur atau obat dapat diberikan kepada pasien lain. Ini adalah insiden keselamatan pasien yang serius.

Tindakan yang Tertunda. Perubahan kondisi pasien yang tidak segera dilaporkan dapat menyebabkan penundaan resusitasi, pemberian antibiotik, atau pemindahan ke ICU.

Kesalahan Serah Terima. Selama pergantian shift, informasi penting seperti alergi obat, risiko jatuh, atau hasil laboratorium kritis dapat terlewatkan jika serah terima tidak sistematis.

Kejadian Sentinel Akibat Kesalahpahaman. Kejadian sentinel adalah kejadian serius yang mengakibatkan kematian atau cedera serius. Banyak kejadian sentinel melibatkan kegagalan komunikasi, seperti operasi di lokasi yang salah atau penundaan dalam menangani henti napas (The Joint Commission, 2022).

Dampak Hukum dan Etika pada Perawat. Perawat memiliki kewajiban etis dan hukum untuk memberikan perawatan yang aman. Jika miskomunikasi mengakibatkan bahaya bagi pasien, perawat dapat menghadapi: gugatan perdata; audit etika profesional; sanksi administratif; penurunan reputasi profesional. Oleh karena itu, komunikasi yang baik juga merupakan bentuk perlindungan profesional.

F. Standar Nasional dan Regulasi di Indonesia dalam Komunikasi Efektif untuk Keselamatan Pasien

Sasaran Keselamatan Pasien Nasional terkait Komunikasi Efektif. Di Indonesia, keselamatan pasien diatur secara nasional melalui kebijakan pemerintah, salah satunya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit. Peraturan ini menetapkan enam Target Keselamatan Pasien Nasional (SKP) yang harus diimplementasikan di semua fasilitas kesehatan. Salah satu target utama adalah peningkatan komunikasi yang efektif. Enam target tersebut meliputi: 1) identifikasi pasien yang akurat, 2) peningkatan komunikasi yang efektif, 3) keamanan obat-obatan berisiko tinggi, 4) memastikan prosedur dan pasien yang benar, 5) pencegahan infeksi dan 6) pencegahan jatuh. Target komunikasi yang efektif (SKP 2) menekankan bahwa semua petugas kesehatan harus menggunakan metode komunikasi yang jelas,

akurat, tepat waktu, lengkap, dan mudah dipahami oleh penerima. Implementasi SKP ini mencakup beberapa aspek penting, termasuk: 1) penggunaan komunikasi terstruktur seperti SBAR, 2) pengulangan instruksi verbal atau telepon, 3) penyampaian hasil pemeriksaan kritis yang cepat, 4) dokumentasi komunikasi yang jelas dan akurat. Tujuan utama dari SKP komunikasi adalah untuk mencegah kesalahan yang diakibatkan oleh informasi yang tidak lengkap atau salah tafsir. Dalam praktiknya, komunikasi yang efektif telah terbukti menjadi faktor kunci dalam mengurangi insiden keselamatan pasien, karena sebagian besar kesalahan klinis berkaitan dengan kegagalan komunikasi antar profesional kesehatan. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif bukan hanya keterampilan individu, tetapi telah menjadi standar nasional yang harus diimplementasikan sebagai bagian dari sistem keselamatan pasien.

Peran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam Kebijakan Patient Safety. Kementerian Kesehatan memainkan peran strategis dalam merumuskan, mengatur, dan mengawasi implementasi kebijakan keselamatan pasien di Indonesia. Peran ini meliputi penyusunan peraturan, pengembangan sistem pelaporan insiden, dan pengembangan tenaga kesehatan. Melalui berbagai kebijakan, Kementerian Kesehatan menekankan bahwa keselamatan pasien merupakan bagian integral dari kualitas pelayanan kesehatan. Peraturan seperti Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017 menetapkan bahwa keselamatan pasien adalah suatu sistem yang meliputi: 1) penilaian risiko, 2) identifikasi dan manajemen risiko, 3) pelaporan dan analisis insiden, 4) pembelajaran dari insiden, dan 5) implementasi solusi untuk mencegah cedera. Lebih lanjut, Kementerian Kesehatan juga mendorong: 1) penguatan budaya keselamatan pasien, 2) pengembangan sistem pelaporan insiden nasional, 3) integrasi keselamatan pasien ke dalam pendidikan tenaga kesehatan, dan 4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan. Dalam konteks komunikasi, Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya komunikasi yang efektif sebagai bagian dari sistem pelayanan yang aman. Hal ini terlihat dari dimasukkannya komunikasi sebagai salah satu target keselamatan pasien nasional. Selain itu, pemerintah telah mengadopsi prinsip-prinsip keselamatan pasien dari standar global seperti WHO, memastikan bahwa kebijakan nasional tetap selaras dengan praktik internasional. Dengan demikian, peran Kementerian Kesehatan tidak hanya bersifat regulasi, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan budaya menuju layanan kesehatan yang lebih aman.

G. Standar Komisi Akreditasi Rumah Sakit terkait Komunikasi

Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menilai kualitas dan keamanan layanan rumah sakit di Indonesia melalui proses akreditasi. Dalam standar akreditasi nasional, komunikasi efektif merupakan komponen penting dari beberapa elemen penilaian. KARS mengintegrasikan komunikasi ke dalam berbagai standar, khususnya: 1) Tujuan Keselamatan Pasien (SKP), 2) Komunikasi dan Manajemen Informasi (MKI) dan 3) Peningkatan Kualitas dan Keselamatan Pasien (PMKP). Dalam standar SKP, komunikasi efektif merupakan indikator kunci yang harus dipenuhi rumah sakit, termasuk: 1) adanya kebijakan komunikasi efektif di antara tenaga kesehatan, 2) penggunaan metode komunikasi terstruktur, 3) implementasi pengulangan instruksi verbal dan 4) pelaporan nilai kritis yang cepat dan terdokumentasi. Standar MKI mengharuskan rumah sakit untuk mengelola informasi pasien secara akurat, aman, dan mudah diakses oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Ini termasuk dokumentasi medis, komunikasi antar unit, dan penggunaan sistem informasi. Lebih lanjut, KARS juga menekankan pentingnya komunikasi selama serah terima pasien. Rumah sakit harus memiliki prosedur operasi standar (SOP) yang jelas untuk proses serah terima pasien guna memastikan tidak ada informasi penting yang terlewatkan. Akreditasi KARS memprioritaskan komunikasi sebagai elemen inti, karena komunikasi yang buruk telah terbukti berkontribusi terhadap kejadian yang merugikan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap standar komunikasi merupakan indikator kualitas layanan rumah sakit. Kode etik keperawatan Indonesia memberikan pedoman moral dan profesional bagi perawat dalam menjalankan praktik keperawatan. Dalam konteks komunikasi, kode etik menekankan bahwa perawat memiliki tanggung jawab untuk: 1) menyampaikan informasi secara jujur, jelas, dan akurat, 2) menjaga kerahasiaan pasien, 3) menghormati martabat dan hak pasien, dan 4) berkomunikasi secara profesional dengan sesama tenaga kesehatan. Kode etik juga mengatur hubungan perawat dengan pasien, kolega, profesional lain, dan masyarakat. Dalam hubungan ini, komunikasi adalah sarana utama untuk membangun kepercayaan dan memastikan keselamatan pasien. Secara etis, kegagalan komunikasi dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian profesional jika mengakibatkan kerugian bagi pasien. Oleh karena itu, perawat diharuskan untuk: 1) mengklarifikasi instruksi yang tidak jelas, 2) mendokumentasikan komunikasi penting, 3) melaporkan kondisi pasien tepat waktu, dan 4) berani berbicara. Kode etik juga selaras dengan prinsip-prinsip keselamatan pasien, yang menekankan prinsip tidak membahayakan, bermanfaat, dan akuntabilitas. Oleh karena itu,

komunikasi yang efektif bukan hanya persyaratan teknis, tetapi juga kewajiban etis yang melekat pada profesi perlindungan.

H. Konsep SBAR sebagai Metode Komunikasi Terstruktur

SBAR (Situasi, Latar Belakang, Penilaian, Rekomendasi) adalah metode komunikasi terstruktur yang digunakan untuk menyampaikan informasi klinis secara sistematis, ringkas, dan berorientasi pada tindakan. SBAR dirancang untuk memastikan bahwa informasi penting mengenai kondisi pasien disampaikan dengan jelas dan akurat, terutama dalam situasi kritis atau situasi yang membutuhkan respons cepat. Menurut Badan Penelitian dan Kualitas Pelayanan Kesehatan (Agency for Healthcare Research and Quality), SBAR adalah kerangka komunikasi yang membantu tim perawatan kesehatan secara efektif berbagi informasi penting tentang kondisi pasien, khususnya dalam situasi yang membutuhkan perhatian segera (AHRQ, 2023). Secara konseptual, SBAR terdiri dari empat komponen utama: 1) Situasi: kondisi pasien saat ini, 2) Latar Belakang: informasi latar belakang yang relevan, 3) Penilaian: penilaian klinis terhadap kondisi pasien dan 4) Rekomendasi: saran atau tindakan yang diperlukan. Model ini menyediakan alur komunikasi yang konsisten dan mudah dipahami untuk semua anggota tim perawatan kesehatan. SBAR juga memungkinkan komunikasi yang lebih terstruktur, mengurangi ambiguitas dan meningkatkan kejelasan pesan (ASQ, 2023). Dengan demikian, SBAR dapat dipahami sebagai alat komunikasi terstandarisasi yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan pasien melalui penyampaian informasi yang sistematis dan terfokus.

Sejarah dan Perkembangan SBAR . SBAR tidak berasal dari industri perawatan kesehatan, melainkan dari sektor militer. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh militer Amerika Serikat, khususnya dalam operasi kapal selam nuklir, yang membutuhkan komunikasi yang cepat, tepat, dan bebas kesalahan. Dalam lingkungan berisiko tinggi seperti itu, komunikasi yang tidak terstruktur dapat berakibat fatal, sehingga diperlukan format komunikasi yang jelas dan konsisten (ASQ, 2023). Konsep SBAR kemudian diadopsi dalam industri penerbangan, yang juga memiliki karakteristik berisiko tinggi dan membutuhkan komunikasi presisi tinggi antar tim. Dari sektor ini, SBAR kemudian diadaptasi ke sektor perawatan kesehatan. SBAR mulai diperkenalkan secara luas dalam praktik perawatan kesehatan pada awal tahun 2000-an, khususnya di sistem perawatan kesehatan Kaiser Permanente di Amerika Serikat sekitar tahun 2002–2003. Penggunaan SBAR difokuskan pada peningkatan komunikasi antara perawat dan dokter, khususnya dalam situasi akut yang membutuhkan keputusan cepat (Müller dkk., 2018). Seiring waktu, SBAR telah menjadi salah satu metode komunikasi paling populer dalam

perawatan kesehatan global. Banyak organisasi kesehatan global, termasuk rumah sakit dan badan akreditasi, merekomendasikan penggunaan SBAR dalam serah terima pasien, komunikasi telepon, dan koordinasi antarprofesional. Penggunaan SBAR juga telah meluas ke berbagai bidang klinis seperti unit perawatan intensif, anestesi, kebidanan, pediatri, dan perawatan komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa SBAR relevan tidak hanya untuk situasi darurat tetapi juga untuk komunikasi rutin dalam praktik keperawatan (Riesenberg dkk., 2009).

Tujuan utama penggunaan SBAR adalah untuk meningkatkan kualitas komunikasi klinis guna mendukung keselamatan pasien. Lebih spesifiknya, SBAR bertujuan untuk: a. Menstandarisasi Komunikasi Klinis: SBAR menyediakan format standar untuk menyampaikan informasi, sehingga mengurangi variasi komunikasi antar individu dan profesi. Dengan standar, komunikasi menjadi lebih konsisten dan mudah dipahami. b. Mengurangi Kesalahan Komunikasi: Kesalahpahaman merupakan salah satu penyebab utama kejadian buruk di rumah sakit. Dengan struktur SBAR, informasi penting tidak mudah terlewatkan, sehingga mengurangi risiko kesalahan (Nurse.com, 2025). c. Meningkatkan Kecepatan dan Akurasi Pengambilan Keputusan : SBAR menyajikan informasi secara ringkas dan berfokus pada isu-isu kunci, sehingga memudahkan dokter dan tim perawatan kesehatan untuk mengambil keputusan klinis dengan cepat. d. Meningkatkan Kepercayaan Diri Petugas Kesehatan: SBAR membantu perawat untuk secara sistematis mengkomunikasikan kondisi pasien, termasuk memberikan rekomendasi. Hal ini meningkatkan keterampilan komunikasi profesional dan keberanian untuk berbicara. e. Mendukung Kolaborasi Tim : SBAR memfasilitasi komunikasi interprofesional yang lebih efektif, sehingga meningkatkan koordinasi tim dalam memberikan perawatan pasien. f. Meningkatkan Keselamatan dan Hasil Pasien : dengan komunikasi yang lebih jelas dan sistematis, SBAR berkontribusi dalam mengurangi kejadian buruk dan meningkatkan kualitas perawatan kesehatan (Müller dkk., 2018). Oleh karena itu, SBAR bukan hanya teknik komunikasi, tetapi strategi keselamatan pasien yang terintegrasi ke dalam sistem perawatan kesehatan.

Keunggulan SBAR dibanding Komunikasi Biasa. Dibandingkan komunikasi konvensional yang sering tidak terstruktur, SBAR memiliki sejumlah keunggulan yang signifikan dalam praktik keperawatan. a. Terstruktur dan Sistematis : SBAR menyediakan kerangka yang jelas sehingga komunikasi tidak melompat-lompat atau tidak terarah. Informasi disampaikan secara berurutan sesuai prioritas klinis. b. Ringkas namun Lengkap : SBAR mendorong penyampaian informasi yang relevan saja, sehingga menghindari informasi berlebihan yang tidak diperlukan. Hal ini penting dalam situasi darurat yang membutuhkan respons cepat. c. Mengurangi Ambiguitas : Dengan format yang jelas, SBAR membantu menghindari istilah yang

ambigu atau interpretasi berbeda antar tenaga kesehatan. d. Meningkatkan Efisiensi Waktu : Komunikasi menjadi lebih cepat karena langsung fokus pada masalah utama dan rekomendasi tindakan. e. Mendukung Pengambilan Keputusan Klinis : SBAR tidak hanya menyampaikan data, tetapi juga menyertakan penilaian dan rekomendasi, sehingga membantu dokter atau tim dalam menentukan tindakan. f. Meningkatkan Keselamatan Pasien : SBAR terbukti membantu mengurangi kesalahan komunikasi yang berkontribusi pada kejadian sentinel. Penggunaan SBAR meningkatkan akurasi transfer informasi dan menurunkan risiko adverse event (AHRQ, 2023). g. Meningkatkan Kepuasan Tim dan Pasien : Penggunaan SBAR meningkatkan kualitas komunikasi antar tenaga kesehatan, yang berdampak pada peningkatan kepuasan kerja dan kualitas pelayanan pasien (Müller et al., 2018). h. Fleksibel dalam Berbagai Situasi Klinis

SBAR dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti: handover antar shift, komunikasi telepon dengan dokter, transfer pasien antar unit, situasi gawat darurat, pelaporan insiden keselamatan pasien.

I. Penerapan SBAR dalam Praktik Keperawatan

Penerapan metode SBAR dalam praktik keperawatan bukan hanya bersifat teoritis tetapi telah menjadi bagian integral dari berbagai situasi klinis sehari-hari. SBAR digunakan untuk memastikan bahwa informasi pasien disampaikan secara sistematis, jelas, dan berorientasi pada tindakan. Implementasi SBAR telah terbukti meningkatkan kualitas komunikasi, mengurangi kesalahan, dan memperkuat keselamatan pasien, khususnya dalam situasi yang melibatkan transisi perawatan dan kondisi kritis (Müller et al., 2018; WHO, 2021). Berikut adalah uraian penerapan SBAR dalam berbagai konteks praktik keperawatan:

1. Penerapan SBAR Selama Serah Terima Shift. Serah terima adalah proses pengalihan informasi dan tanggung jawab perawatan pasien dari satu perawat ke perawat berikutnya. Proses ini merupakan titik kritis yang perlu diperhatikan karena risiko kehilangan informasi yang tinggi. SBAR digunakan untuk menstandarisasi komunikasi selama serah terima untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tetap fokus, lengkap, dan mudah dipahami. Dalam praktiknya: a) Situasi: kondisi pasien saat ini (misalnya, stabil, kritis, perubahan kondisi). b) Latar Belakang: diagnosis medis, riwayat medis, terapi yang sedang berlangsung. c) Penilaian: evaluasi klinis selama shift sebelumnya (misalnya, perubahan tanda vital, respons terhadap terapi). Rekomendasi: rencana tindak lanjut atau area yang perlu diperhatikan untuk shift berikutnya. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan SBAR selama serah terima membantu mengurangi informasi yang salah dan meningkatkan keselamatan

pasien dengan membuat komunikasi lebih terstruktur dan sistematis. Lebih lanjut, penelitian lain menemukan bahwa SBAR membuat proses serah terima lebih singkat, lebih jelas, dan mengurangi kejadian dalam perawatan keperawatan. Dengan demikian, SBAR selama serah terima berfungsi sebagai alat untuk memastikan kesinambungan perawatan dan mencegah kesalahan akibat hilangnya informasi penting.

2. Penerapan SBAR Saat Menghubungi Dokter Siaga. Komunikasi antara perawat dan dokter, terutama melalui telepon, seringkali menyebabkan miskomunikasi karena keterbatasan waktu dan kurangnya interaksi langsung dengan pasien. SBAR sangat efektif dalam situasi ini karena membantu perawat menyampaikan informasi dengan cepat dan akurat. Langkah-langkah implementasi: Situasi: Secara singkat identifikasi diri Anda, pasien, dan masalah utama.
 - a. Latar Belakang: Riwayat relevan secara singkat (diagnosis, terapi, kondisi sebelumnya).
 - b. Penilaian: Kondisi saat ini berdasarkan penilaian klinis perawat.
 - c. Rekomendasi: Permintaan tindakan atau saran (misalnya, evaluasi segera, perubahan terapi).

Penggunaan SBAR dalam komunikasi telepon membantu dokter memahami kondisi pasien dengan cepat, sehingga mempercepat pengambilan keputusan klinis. WHO merekomendasikan SBAR sebagai alat komunikasi dalam situasi yang membutuhkan tindakan segera untuk mengurangi risiko kesalahan akibat informasi yang tidak lengkap. Selain itu, SBAR meningkatkan kepercayaan diri perawat dalam mengkomunikasikan kondisi pasien, termasuk memberikan rekomendasi, yang seringkali menjadi penghalang komunikasi antarprofesi.

3. Penerapan SBAR Selama Transfer Pasien Antar Unit. Penerapan SBAR Selama Transfer Pasien Antar Unit. Transfer pasien antar unit, seperti dari bangsal rawat inap ke ICU atau dari unit gawat darurat ke bangsal, merupakan proses kompleks yang melibatkan pergeseran tanggung jawab dan perubahan lingkungan perawatan. Dalam situasi ini, SBAR memainkan peran penting dalam memastikan bahwa semua informasi penting pasien tersampaikan secara lengkap. Penerapan SBAR meliputi:
 - a. Situasi: alasan transfer dan kondisi pasien saat ini.
 - b. Latar Belakang: diagnosis, riwayat medis, dan tindakan yang telah diambil.
 - c. Penilaian: status klinis saat ini, termasuk stabilitas pasien.
 - d. Rekomendasi: kebutuhan lebih lanjut seperti pemantauan ketat, terapi spesifik, atau intervensi segera.

Tanpa komunikasi terstruktur, risiko kehilangan informasi meningkat, yang dapat menyebabkan keterlambatan pengobatan atau kesalahan terapi. SBAR

membantu memastikan bahwa transfer pasien aman dan terkoordinasi. Literatur menunjukkan bahwa komunikasi terstruktur, seperti SBAR selama transisi perawatan, meningkatkan keselamatan pasien dengan memastikan kesinambungan informasi klinis yang akurat (Müller dkk., 2018).

4. Penerapan SBAR dalam Situasi Darurat. Dalam situasi darurat, waktu sangat penting. Komunikasi harus cepat, jelas, dan tepat sasaran. Dalam situasi ini, SBAR sangat relevan karena membantu menyampaikan informasi penting tanpa kehilangan fokus. Contoh penerapan:
 - a. Situasi: "Pasien mengalami kehilangan kesadaran secara tiba-tiba."
 - b. Latar belakang: riwayat penyakit atau kondisi sebelumnya.
 - c. Penilaian: tanda-tanda vital, perubahan klinis, hasil pemeriksaan awal.
 - d. Rekomendasi: tindakan segera diperlukan (misalnya, resusitasi, rujukan ke ICU).

Penggunaan SBAR dalam situasi darurat membantu tim merespons lebih cepat karena informasi dikomunikasikan secara terstruktur dan diprioritaskan. Hal ini meningkatkan kesadaran situasional tim dan mengurangi keterlambatan tindakan. WHO menekankan bahwa komunikasi terstruktur, seperti SBAR, sangat penting dalam situasi kritis untuk memastikan respons yang cepat dan tepat terhadap perubahan kondisi pasien.

5. Penerapan SBAR Saat Melaporkan Insiden Keselamatan Pasien. Pelaporan insiden keselamatan pasien merupakan bagian penting dari sistem manajemen risiko. Insiden seperti nyaris celaka, kejadian buruk, atau kejadian penting harus dilaporkan secara sistematis untuk analisis dan pencegahan di masa mendatang. SBAR dapat digunakan untuk mengembangkan laporan insiden yang jelas dan terstruktur:
 - a. Situasi: jenis dan waktu kejadian.
 - b. Latar Belakang: kondisi pasien sebelum kejadian.
 - c. Penilaian: dampak kejadian pada pasien.
 - d. Rekomendasi: tindakan yang diambil dan saran untuk perbaikan.

Penggunaan SBAR dalam pelaporan insiden membantu memperjelas kronologi kejadian, memfasilitasi analisis akar penyebab, meningkatkan kualitas pembelajaran organisasi, mencegah insiden serupa di masa mendatang. Pendekatan komunikasi terstruktur untuk pelaporan insiden juga mendukung budaya keselamatan pasien yang transparan dan tanpa menyalahkan, memungkinkan staf untuk lebih terbuka dalam melaporkan kesalahan (Reason, 2000).

J. SBAR dalam Pencegahan Error Keperawatan

Kesalahan dalam pelayanan keperawatan (*nursing error*) sebagian besar berakar pada kegagalan komunikasi, baik antar perawat maupun dengan profesi lain. Komunikasi yang tidak terstruktur menyebabkan informasi penting tidak tersampaikan, disalahartikan, atau terlambat ditindaklanjuti. Dalam konteks ini, SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) berperan sebagai strategi komunikasi terstruktur yang terbukti berkontribusi dalam peningkatan keselamatan pasien dan penurunan kejadian tidak diharapkan (Müller et al., 2018).

Berikut adalah peran SBAR secara spesifik dalam pencegahan error keperawatan.

1. Mencegah Medication Error (Kesalahan Pengobatan)

Kesalahan pengobatan adalah salah satu jenis kesalahan yang paling umum dalam perawatan kesehatan, dan dapat mencakup dosis yang salah, jenis obat yang salah, waktu pemberian yang salah, atau pasien yang salah. Salah satu penyebab utama kesalahan pengobatan adalah miskomunikasi, terutama saat memberikan instruksi verbal atau menafsirkan rekam medis. SBAR membantu mencegah kesalahan pengobatan dengan memastikan bahwa informasi terkait terapi dikomunikasikan secara lengkap dan sistematis. Melalui SBAR:

- a. Bagian situasi memastikan kekhawatiran utama pasien terkait pengobatan dikomunikasikan dengan jelas,
- b. Bagian latar belakang memberikan konteks untuk terapi sebelumnya dan riwayat alergi,
- c. Bagian penilaian menjelaskan respons pasien terhadap pengobatan, dan Bagian rekomendasi menegaskan perlunya perubahan terapi atau klarifikasi instruksi.

Pendekatan ini mengurangi kemungkinan salah tafsir instruksi pengobatan, terutama dalam komunikasi telepon antara perawat dan dokter. Studi menunjukkan bahwa komunikasi terstruktur seperti SBAR berkontribusi pada peningkatan proses komunikasi terkait kejadian efek samping obat dan keselamatan pasien (Müller dkk., 2018). Oleh karena itu, SBAR berfungsi sebagai "filter" untuk memastikan bahwa informasi terkait pengobatan tidak terlewatkan atau disalahartikan.

2. Mencegah Delay Treatment (Keterlambatan Tindakan)

Keterlambatan pengobatan sering terjadi ketika perubahan kondisi pasien tidak dikomunikasikan secara efisien atau dianggap sebagai prioritas. Hal ini dapat berakibat fatal, terutama pada pasien dengan kondisi akut.

SBAR membantu mencegah keterlambatan ini dengan:

- a. Mengatur Informasi Berdasarkan Prioritas,
- b. Menekankan Urgensi Kondisi Pasien,
- c. Dan Secara Eksplisit Menyampaikan Tindakan Yang Direkomendasikan.

Komponen Rekomendasi dalam SBAR sangat penting karena mendorong perawat untuk tidak hanya melaporkan kondisi tetapi juga mengusulkan tindakan yang diperlukan. Hal ini mempercepat respons dokter atau tim perawatan kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa SBAR meningkatkan efektivitas komunikasi klinis dan mempercepat respons terhadap kondisi pasien karena informasi disampaikan secara ringkas dan langsung ke intinya. Dengan komunikasi yang lebih terarah, SBAR mengurangi risiko keterlambatan pengobatan yang dapat memperburuk kondisi pasien.

3. Mengurangi Informasi Terlewat saat Handover

Serah terima pasien merupakan titik kritis dalam pemberian layanan kesehatan karena melibatkan transfer tanggung jawab antar tenaga kesehatan. Tanpa komunikasi yang terstruktur, informasi penting seperti alergi, hasil laboratorium kritis, atau perubahan kondisi pasien dapat terlewatkan. SBAR menyediakan kerangka kerja sistematis yang memastikan bahwa setiap aspek penting dari perawatan pasien dikomunikasikan secara konsisten. Dengan format yang sama yang digunakan oleh semua perawat, informasi menjadi lebih terstandarisasi, variasi dalam metode penyampaian berkurang, dan risiko kehilangan informasi menurun.

Tinjauan sistematis menunjukkan bahwa SBAR secara khusus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas serah terima dan komunikasi antar tenaga kesehatan, yang merupakan titik kritis untuk kejadian yang merugikan. Lebih lanjut, penggunaan SBAR dalam serah terima telah terbukti meningkatkan kejelasan komunikasi dan kontinuitas perawatan pasien (Shafira & Dhamanti, 2023). Oleh karena itu, SBAR merupakan alat penting untuk menjaga kontinuitas informasi pasien.

4. Mempercepat Pengambilan Keputusan Klinik

Pengambilan keputusan klinis sangat bergantung pada kualitas informasi yang diterima oleh tenaga kesehatan. Informasi yang tidak lengkap atau tidak terstruktur dapat memperlambat proses analisis dan tindakan.

SBAR membantu mempercepat pengambilan keputusan dengan: menyajikan informasi secara logis dan sistematis, menyoroti data penting yang relevan, menyertakan penilaian klinis perawat, memberikan rekomendasi tindakan yang jelas.

Dengan SBAR, dokter atau tim kesehatan tidak perlu menggali informasi tambahan secara berulang karena informasi sudah tersusun dengan baik. Hal ini

sangat penting dalam situasi kritis yang membutuhkan keputusan cepat. Literatur menunjukkan bahwa SBAR efektif dalam meningkatkan efisiensi komunikasi dan mendukung pengambilan keputusan klinis, terutama dalam komunikasi telepon dan situasi akut . Dengan demikian, SBAR tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mempercepat proses klinis secara keseluruhan.

5. Meningkatkan Kolaborasi Tim Kesehatan

Pelayanan kesehatan modern bersifat multidisiplin, sehingga kolaborasi antar tenaga kesehatan menjadi kunci keselamatan pasien. Namun, perbedaan latar belakang pendidikan, budaya profesi, dan hierarki dapat menjadi hambatan komunikasi.

SBAR membantu meningkatkan kolaborasi tim dengan:

- a. Menyediakan “Bahasa Komunikasi” Yang Sama,
- b. Mengurangi Kesenjangan Komunikasi Antarprofesi,
- c. Meningkatkan Kejelasan Peran Dan Tanggung Jawab,
- d. Mendorong Budaya *Speak Up*.

Dengan SBAR, perawat memiliki kerangka yang jelas untuk menyampaikan penilaian dan rekomendasi, sehingga lebih percaya diri dalam berkomunikasi dengan dokter atau profesi lain. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi SBAR meningkatkan komunikasi tim dan koordinasi antar tenaga kesehatan, yang berkontribusi pada peningkatan keselamatan pasien . komunikasi yang efektif melalui SBAR juga memperkuat kerja tim dan mengurangi konflik akibat miskomunikasi (Efendi et al., 2025). Dengan demikian, SBAR tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kinerja tim secara keseluruhan.

K. Strategi Implementasi SBAR di Rumah Sakit Indonesia

Implementasi SBAR dalam praktik keperawatan tidak cukup hanya pada tingkat pengetahuan individu, tetapi memerlukan pendekatan sistematis di tingkat organisasi. Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SBAR sangat dipengaruhi oleh faktor pelatihan, kebijakan rumah sakit, budaya organisasi, serta evaluasi berkelanjutan (Shafira & Dhamanti, 2023). Implementasi SBAR yang efektif membutuhkan integrasi antara edukasi, praktik klinik, serta monitoring kepatuhan agar manfaatnya terhadap keselamatan pasien dapat optimal (Shinta & Bunga, 2024).

Berikut adalah strategi implementasi SBAR di rumah sakit Indonesia secara komprehensif.

1. Pelatihan Perawat dan Tenaga Kesehatan

Pelatihan adalah langkah awal terpenting dalam menerapkan SBAR. Tanpa pemahaman yang kuat, petugas kesehatan cenderung kembali ke pola komunikasi lama yang tidak terstruktur.

Pelatihan SBAR bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan tentang konsep dan manfaat SBAR,
- b. mempraktikkan keterampilan komunikasi klinis,
- c. meningkatkan kepercayaan diri dalam komunikasi antarprofesional,
- d. membangun pemahaman bersama dalam tim perawatan kesehatan.

Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan SBAR secara signifikan meningkatkan keterampilan komunikasi dan keselamatan pasien.

Implementasi di rumah sakit biasanya meliputi:

- a. pelatihan orientasi untuk petugas kesehatan baru,
- b. lokakarya atau pelatihan internal,
- c. pelatihan berkelanjutan (pelatihan penyegaran),
- d. pelatihan antarprofesional (perawat, dokter, dan staf lainnya).

Studi tentang implementasi SBAR di sistem rumah sakit besar menunjukkan bahwa hampir semua perawat yang menerima pelatihan mampu memahami SBAR dengan baik, meskipun penggunaan yang konsisten masih membutuhkan penguatan lebih lanjut.

2. Simulasi Komunikasi Klinik

Simulasi merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif untuk meningkatkan keterampilan komunikasi klinis. Tidak seperti pelatihan teoretis, simulasi memungkinkan petugas kesehatan untuk mempraktikkan SBAR dalam situasi yang meniru situasi kehidupan nyata.

Simulasi dapat berupa:

- a. Permainan Peran Antara Perawat Dan Dokter,
- b. Simulasi Situasi Darurat,
- c. Simulasi Serah Terima Pasien,
- d. Simulasi Komunikasi Telepon.

Pendekatan ini membantu petugas kesehatan untuk:

- a. proses SBAR secara praktis,
- b. meningkatkan kecepatan dan akurasi komunikasi,
- c. mengurangi kecemasan saat berkomunikasi dengan dokter, dan
- d. meningkatkan keterampilan berpikir kritis.

Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis simulasi secara signifikan meningkatkan pemahaman SBAR dan keterampilan komunikasi klinis dibandingkan dengan kuliah saja (Shinta & Bunga, 2024). Lebih lanjut, program peningkatan kualitas rumah sakit menunjukkan bahwa penggunaan juara SBAR dan sesi pelatihan singkat berbasis unit dapat meningkatkan kepatuhan SBAR lebih dari 50%.

3. Integrasi SBAR dalam SOP Rumah Sakit

Agar implementasi SBAR berkelanjutan, metode ini harus diintegrasikan ke dalam kebijakan resmi rumah sakit, khususnya dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

Integrasi SBAR dalam SOP meliputi:

- a. SOP handover perawat,
- b. SOP komunikasi telepon dengan dokter,
- c. SOP transfer pasien antar unit,
- d. SOP pelaporan kondisi kritis,
- e. SOP pelaporan insiden keselamatan pasien.

Keberadaan SOP memastikan bahwa SBAR bukan hanya anjuran, tetapi menjadi standar wajib dalam komunikasi klinik. Literatur menunjukkan bahwa keberadaan SOP merupakan salah satu faktor utama keberhasilan implementasi SBAR di rumah sakit Indonesia, karena memberikan kejelasan dan konsistensi dalam praktik (Shafira & Dhamanti, 2023). Tanpa integrasi dalam SOP, implementasi SBAR cenderung tidak konsisten dan bergantung pada individu.

4. Penggunaan Formulir SBAR Cetak/Digital

Penggunaan formulir SBAR merupakan strategi penting untuk memfasilitasi implementasi di lapangan. Formulir ini membantu petugas kesehatan mengatur informasi sesuai dengan struktur SBAR.

Formulir SBAR meliputi:

- a. Lembar Serah Terima SBAR,
- b. Daftar Periksa Komunikasi SBAR,
- c. Templat SBAR Dalam Rekam Medis,
- d. Aplikasi Digital Atau Sistem Informasi Rumah Sakit.

Manfaat penggunaan formulir:

- a. meminimalkan informasi yang terlewat,
- b. membantu petugas kesehatan yang belum terbiasa dengan formulir tersebut,
- c. meningkatkan konsistensi komunikasi,
- d. memfasilitasi dokumentasi dan audit.

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dokumentasi SBAR selama serah terima meningkatkan kualitas komunikasi dan keselamatan pasien dengan membuat informasi lebih sistematis dan lengkap. Di era digital, mengintegrasikan SBAR ke dalam rekam medis elektronik merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi komunikasi.

5. Audit Kepatuhan Penggunaan SBAR

Audit merupakan komponen penting dalam memastikan bahwa SBAR tidak hanya dipahami, tetapi juga diterapkan secara konsisten dalam praktik.

Audit SBAR dapat dilakukan melalui:

observasi langsung saat handover, penilaian dokumentasi SBAR, survei kepatuhan tenaga kesehatan, evaluasi kualitas komunikasi oleh supervisor, audit klinis berbasis indikator patient safety.

Audit bertujuan untuk:

mengukur tingkat kepatuhan penggunaan SBAR, mengidentifikasi hambatan implementasi, memberikan umpan balik kepada tenaga kesehatan, meningkatkan kualitas komunikasi secara berkelanjutan.

Studi implementasi SBAR menunjukkan bahwa audit dan evaluasi rutin, termasuk penilaian kompetensi tahunan, sangat penting untuk menjaga keberlanjutan penggunaan SBAR dalam praktik klinik.

Selain itu, audit juga berperan dalam membangun budaya keselamatan pasien, karena mendorong akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan.

L. Penutup

Komunikasi yang efektif merupakan landasan fundamental untuk keselamatan pasien dan elemen integral dari praktik keperawatan profesional. Seluruh proses perawatan keperawatan dari penilaian dan perencanaan hingga implementasi dan evaluasi bergantung pada keakuratan dan kejelasan pertukaran informasi. Kegagalan komunikasi telah terbukti menjadi penyebab utama kesalahan perawatan kesehatan, sehingga penguatan keterampilan komunikasi bukan lagi sekadar keterampilan tambahan tetapi merupakan persyaratan penting untuk sistem perawatan yang aman.

Dalam konteks ini, SBAR (Situasi, Latar Belakang, Penilaian, Rekomendasi) hadir sebagai alat komunikasi terstruktur yang praktis dan efektif untuk mencegah kesalahan keperawatan. SBAR membantu para profesional perawatan kesehatan menyampaikan informasi secara sistematis, ringkas, dan berorientasi pada tindakan, sehingga meminimalkan miskomunikasi, mengurangi informasi yang terlewatkan, dan mempercepat pengambilan keputusan klinis. Implementasi SBAR telah terbukti

mendukung berbagai aspek keselamatan pasien, termasuk mencegah kesalahan pengobatan, mengurangi keterlambatan pengobatan, meningkatkan kualitas serah terima, dan memperkuat kolaborasi antarprofesional.

Namun, keberhasilan implementasi SBAR tidak hanya ditentukan oleh pemahaman individu tetapi juga sangat bergantung pada budaya organisasi dan komitmen tim perawatan kesehatan. Lingkungan kerja yang mendukung komunikasi terbuka, menghindari saling menyalahkan, dan mendorong untuk berani berbicara merupakan faktor kunci dalam memastikan penggunaan SBAR yang konsisten. Lebih lanjut, dukungan manajemen melalui kebijakan, pelatihan berkelanjutan, integrasi ke dalam prosedur operasi standar, dan evaluasi berkala sangat penting untuk memperkuat implementasi di lapangan.

Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan implementasi SBAR harus dianggap sebagai bagian integral dari sistem manajemen risiko dan keselamatan pasien di Indonesia. Upaya ini membutuhkan sinergi antara individu, tim, dan organisasi untuk menciptakan layanan keperawatan yang aman, berkualitas tinggi, dan berpusat pada pasien.

Referensi

- Agency for Healthcare Research and Quality. (2023). SBAR tool: Situation, Background, Assessment, Recommendation. <https://www.ahrq.gov/teamstepps-program/curriculum/communication/tools/sbar.html>
- American Society for Quality. (2023). SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation). <https://asq.org/quality-resources/sbar>
- Arnold, E. C., & Boggs, K. U. (2020). Interpersonal relationships: Professional communication skills for nurses (8th ed.). Elsevier.
- Astuti, N., Ilmi, B., & Wati, R. (2019). Penerapan komunikasi SBAR pada perawat dalam melaksanakan handover. *Indonesian Journal of Nursing Practices*.
- Carayon, P., & Gurses, A. P. (2008). Nursing workload and patient safety. In R. Hughes (Ed.), *Patient safety and quality: An evidence-based handbook for nurses*. Agency for Healthcare Research and Quality. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/>
- Efendi, Z., Adha, D., & Isesreni. (2025). Improving patient safety through effective SBAR communication. *Journal of Scientific Research, Education, and Technology*, 4(3). <https://jsret.knpub.com/index.php/jrest/article/view/829>
- Institute of Medicine. (2001). *Crossing the quality chasm: A new health system for the 21st century*. National Academies Press. <https://nap.nationalacademies.org>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Sasaran keselamatan pasien nasional*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Komisi Akreditasi Rumah Sakit. (2022). *Standar akreditasi rumah sakit nasional*. Jakarta: KARS.
- Krisnawati, K. M. S., Yanti, N. P. E. D., & Rahajeng, I. M. (2023). Implementation of SBAR format during handover in hospital. *Nursing and Health Sciences Journal*.
- McCorry, L. K., & Mason, J. (2020). Communication skills for patient-centered care. *AMA Journal of Ethics*, 22(11), E975–E982.
- Müller, M., Jürgens, J., Redaelli, M., Klingberg, K., Hautz, W. E., & Stock, S. (2018). Impact of the communication and patient hand-off tool SBAR on patient safety: A systematic review. *BMJ Open*, 8(8), e022202. <https://bmjopen.bmj.com/content/8/8/e022202>
- Müller, M., Jürgens, J., Redaelli, M., Klingberg, K., Hautz, W. E., & Stock, S. (2018). Impact of the communication and patient hand-off tool SBAR on patient safety: A systematic review. *BMJ Open*, 8(8), e022202.

- Müller, M., Jürgens, J., Redaelli, M., Klingberg, K., Hautz, W. E., & Stock, S. (2018). Impact of the communication and patient hand-off tool SBAR on patient safety: A systematic review. *BMJ Open*, 8(8), e022202.
- Müller, M., Jürgens, J., Redaelli, M., Klingberg, K., Hautz, W. E., & Stock, S. (2018). Impact of the communication and patient hand-off tool SBAR on patient safety: A systematic review. *BMJ Open*, 8(8), e022202.
- Müller, M., Jürgens, J., Redaelli, M., Klingberg, K., Hautz, W. E., & Stock, S. (2018). Impact of the communication and patient hand-off tool SBAR on patient safety: A systematic review. *BMJ Open*, 8(8), e022202. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6112409/>
- Nasrianti, N., Mulyati, M., Setiawati, S., Asmirajanti, M., & Irianto, G. (2022). Pelaksanaan handover perawat dengan komunikasi SBAR pada pelayanan keperawatan. *Jurnal Keperawatan Silampari*.
- Nurse.com. (2025). What is SBAR?. <https://www.nurse.com/nursing-resources/definitions/what-is-sbar/>
- O'Daniel, M., & Rosenstein, A. H. (2008). Professional communication and team collaboration. In *Patient safety and quality: An evidence-based handbook for nurses*. Agency for Healthcare Research and Quality.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Reason, J. (2000). Human error: Models and management. *BMJ*, 320(7237), 768–770. <https://www.bmj.com/content/320/7237/768>
- Reason, J. (2000). Human error: Models and management. *BMJ*, 320(7237), 768–770.
- Riesenberg, L. A., Leitzsch, J., & Little, B. W. (2009). Systematic review of handoff mnemonics literature. *American Journal of Medical Quality*.
- Shafira, R. A., & Dhamanti, I. (2023). Implementation of SBAR communication in patient safety in hospitals: A literature review. *Media Gizi Kesmas*, 12(1), 441–452.
- Shafira, R. A., & Dhamanti, I. (2023). Implementation of SBAR communication in patient safety in hospital: A literature review. *Media Gizi Kesmas*, 12(1), 441–452. <https://e-journal.unair.ac.id/MGK/article/view/33483>
- Stewart, K. R. (2017). SBAR, communication, and patient safety: An integrated literature review. *MedSurg Nursing*.
- The Joint Commission. (2022). Sentinel event data summary. <https://www.jointcommission.org>
- Wachidah, E. Z., Priantoro, C. T., & Purwanza, S. W. (2022). Metode komunikasi SBAR terhadap keselamatan pasien: Studi literatur. *Nursing Information Journal*, 1(2), 67–73.

- World Health Organization. (2021). Global patient safety action plan 2021–2030.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240032705>
- World Health Organization. (2021). Global patient safety action plan 2021–2030.
Geneva: WHO.

Glosarium

A

Adverse Event (Kejadian Tidak Diharapkan/KTD)

Insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien akibat tindakan medis atau kelalaian, bukan karena penyakit dasar.

Assessment (Penilaian)

Bagian dari SBAR yang berisi evaluasi klinis tenaga kesehatan terhadap kondisi pasien berdasarkan data objektif dan subjektif.

B

Background (Latar Belakang)

Komponen SBAR yang berisi informasi riwayat pasien yang relevan, termasuk diagnosis, terapi, dan kondisi sebelumnya.

Blaming Culture (Budaya Menyalahkan)

Budaya organisasi yang cenderung menyalahkan individu saat terjadi kesalahan, sehingga menghambat pelaporan insiden dan pembelajaran sistem.

Budaya organisasi yang cenderung menyalahkan individu saat terjadi kesalahan, sehingga menghambat pelaporan insiden dan pembelajaran sistem.

C

Clinical Decision Making (Pengambilan Keputusan Klinis)

Proses analisis dan penentuan tindakan berdasarkan data pasien, pengalaman klinis, dan evidensi ilmiah.

Communication Breakdown (Kegagalan Komunikasi)

Kondisi ketika informasi tidak tersampaikan atau disalahartikan, yang berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pelayanan kesehatan.

D

Delay Treatment (Keterlambatan Tindakan)

Kondisi ketika intervensi medis tidak dilakukan tepat waktu akibat keterlambatan komunikasi atau pengambilan keputusan.

Dokumentasi Keperawatan

Catatan tertulis atau elektronik yang berisi seluruh proses asuhan keperawatan sebagai alat komunikasi profesional.

E

Effective Communication (Komunikasi Efektif)

Proses penyampaian informasi yang jelas, akurat, lengkap, dan dipahami dengan benar oleh penerima.

Error (Kesalahan)

Tindakan yang tidak sesuai dengan rencana atau penggunaan rencana yang salah dalam pelayanan kesehatan.

h

Handover (Timbang Terima)

Proses serah terima informasi dan tanggung jawab pasien antar tenaga kesehatan, biasanya saat pergantian shift.

I

Insiden Keselamatan Pasien

Setiap kejadian atau kondisi yang berpotensi atau telah mengakibatkan cedera pada pasien.

Interprofessional Communication (Komunikasi Antarprofesi)

Komunikasi yang terjadi antara tenaga kesehatan dari berbagai profesi untuk memberikan pelayanan terpadu.

K

Keselamatan Pasien (Patient Safety)

Upaya untuk mencegah cedera pada pasien selama proses pelayanan kesehatan melalui sistem yang aman.

Komunikasi Nonverbal

Penyampaian pesan tanpa kata-kata, seperti ekspresi wajah, gestur, dan bahasa tubuh.

Komunikasi Verbal

Penyampaian pesan melalui kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis.

M

Medication Error (Kesalahan Pemberian Obat)

Kesalahan dalam proses pemberian obat yang dapat merugikan pasien, seperti salah dosis atau pasien.

Manajemen Risiko

Pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Keselamatan Pasien (Patient Safety)

Upaya untuk mencegah cedera pada pasien selama proses pelayanan kesehatan melalui sistem yang aman.

N

Near Miss (Kejadian Nyaris Cedera)

Insiden yang tidak sampai menyebabkan cedera pada pasien karena berhasil dicegah.

P

Patient Safety Culture (Budaya Keselamatan Pasien)

Nilai, sikap, dan perilaku dalam organisasi yang mendukung keselamatan pasien.

Professional Communication (Komunikasi Profesional)

Komunikasi yang dilakukan sesuai standar etika dan tanggung jawab profesi.

R

Recommendation (Rekomendasi)

Komponen SBAR yang berisi saran atau tindakan yang diperlukan untuk penanganan pasien.

Risk Management (Manajemen Risiko)

Proses sistematis dalam mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang dapat membahayakan pasien.

S

SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation)

Metode komunikasi terstruktur yang digunakan untuk menyampaikan informasi klinis secara efektif.

Sentinel Event

Kejadian serius yang mengakibatkan kematian atau cedera berat pada pasien.

Situation (Situasi)

Bagian awal SBAR yang menjelaskan kondisi terkini pasien secara singkat dan jelas.

Speak Up

Sikap proaktif tenaga kesehatan untuk menyampaikan kekhawatiran demi keselamatan pasien.

T

Tim Kesehatan

Kelompok tenaga profesional yang bekerja sama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

Transfer Pasien

Proses pemindahan pasien dari satu unit pelayanan ke unit lain dengan tetap menjaga kesinambungan informasi.

U

Umpan Balik (Feedback)

Respons dari penerima pesan yang menunjukkan bahwa informasi telah diterima dan dipahami.

BAB 5

PERAN PERAWAT DALAM PELAPORAN INSIDEN

A. Pendahuluan

Keselamatan pasien (patient safety) merupakan landasan fundamental dalam sistem pelayanan kesehatan modern, di Indonesia, keselamatan pasien mendapat perhatian serius melalui regulasi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Regulasi ini mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk membangun sistem keselamatan pasien yang terintegrasi, mencakup identifikasi risiko, pelaporan insiden, analisis akar masalah, dan implementasi tindakan korektif. Perawat, sebagai tenaga kesehatan yang berinteraksi paling intensif dengan pasien selama 24 jam, memegang peran sentral dalam ekosistem keselamatan pasien ini (Dewi & Hariyati, 2022).

B. Insiden Keselamatan

1. Pengertian insiden keselamatan (IKP)
 - a. WHO mendefinisikan insiden keselamatan pasien sebagai setiap kejadian atau keadaan yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan kerugian yang tidak perlu bagi pasien (WHO, 2009).
 - b. Permenkes No. 11 Tahun 2017 mendefinisikan insiden keselamatan pasien sebagai setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien.
2. Jenis – Jenis Insiden :
 - a. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)/*Adverse event* .

Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)/*Adverse event* adalah suatu kejadian yang mengakibatkan cedera pada pasien akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya, bukan karena penyakit dasarnya atau kondisi pasien.((Permenkes No. 11/2017). KTD dapat bersifat preventable (dapat dicegah) atau non-preventable (komplikasi yang diketahui dari suatu prosedur yang dilakukan dengan benar).
 - b. Kejadian nyaris cedera(KNC)/ *Near Miss*

Kejadian Nyaris Cedera (KNC) adalah suatu kejadian akibat melaksanakan atau tidak mengambil suatu tindakan yang diperlukan, namun tidak menyebabkan cedera karena suatu kebetulan, tindakan pencegahan, atau penanggulangan segera (Permenkes No. 11/2017). KNC merupakan 'sinyal peringatan dini' yang

sangat berharga karena memberikan kesempatan untuk memperbaiki sistem sebelum cedera terjadi.

c. Kejadian Potensial Cedera(KPC)

KPC adalah kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden. Contohnya: tersedianya obat dengan nama atau kemasan yang mirip tanpa penandaan yang jelas, peralatan yang sudah usang namun masih digunakan, atau kekurangan perawat pada shift malam yang berulang.

C. Peran dan Tanggung Jawab Perawat

Perawat memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, khususnya dalam upaya mewujudkan budaya keselamatan pasien yang berkelanjutan. Sebagai tenaga profesional yang memiliki intensitas interaksi tertinggi dengan pasien, perawat berfungsi sebagai pemberi asuhan keperawatan yang komprehensif, holistik, dan berorientasi pada patient-centered care dengan mengedepankan prinsip keselamatan.

Dalam perspektif manajemen pemberdayaan, perawat tidak hanya bertindak sebagai pelaksana asuhan, tetapi juga sebagai agen perubahan (change agent) yang berperan aktif dalam menginternalisasi nilai-nilai budaya keselamatan pasien melalui praktik berbasis bukti, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, serta partisipasi dalam sistem pelaporan insiden keselamatan.

Selain itu, perawat menjalankan fungsi edukator, advokat, koordinator, dan kolaborator dalam tim interprofesional guna menjamin kesinambungan dan kualitas pelayanan kesehatan. Secara fungsional, praktik keperawatan mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis, dan akuntabel, sehingga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pelayanan dan perlindungan keselamatan pasien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

1. Perawat sebagai garda terdepan dalam pelayanan. (*Frontline Observer*)

Konsep 'frontline worker' dalam konteks patient safety merujuk pada tenaga kesehatan yang berada di ujung tombak interaksi dengan pasien dan sistem pelayanan, di mana risiko insiden paling tinggi dan di mana tanda-tanda early warning paling jelas terdeteksi. Dalam taksonomi Reason (1997) tentang Swiss Cheese Model, perawat frontline berperan sebagai lapisan pertahanan terakhir yang dapat mencegah bahaya laten mencapai pasien (Reason, 1997). Perawat memiliki kemampuan unik untuk mendeteksi insiden yang tidak tercatat dalam kategori formal, seperti: pasien yang tampak tidak nyaman namun tidak mau mengungkapkan keluhan kepada dokter, ketidaksesuaian antara instruksi medis

dan kondisi aktual pasien, atau masalah dalam koordinasi antar-shift yang berpotensi menyebabkan discontinuity of care. Kemampuan observasi klinis yang terlatih dan kepekaan terhadap perubahan subtle pada kondisi pasien menjadikan perawat sebagai sistem early warning yang paling sensitif dalam ekosistem keselamatan pasien (Mackintosh et al., 2009).

PERAN FRONTLINE PERAWAT DALAM PATIENT SAFETY

1. OBSERVER: Mendeteksi perubahan kondisi pasien & tanda early warning
2. INTERCEPTOR: Mencegah KNC sebelum mencapai pasien
3. COMMUNICATOR: Meneruskan informasi kritis antar shift & ke dokter
4. REPORTER: Mendokumentasikan & melaporkan insiden formal
5. IMPLEMENTOR: Melaksanakan perubahan sistem pasca insiden
6. EDUCATOR: Mengedukasi pasien & keluarga tentang keselamatan
7. ADVOCATE: Membela kepentingan keselamatan pasien

2. Tanggung Jawab Etis dalam pelaporan Insiden

Kode etik keperawatan global (ICN Code of Ethics for Nurses, 2021) menetapkan bahwa perawat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa individu, keluarga, dan komunitas menerima pelayanan yang aman, berkualitas, dan bermartabat. Secara implisit, ini mencakup kewajiban untuk melaporkan situasi yang dapat membahayakan keselamatan pasien. Lebih eksplisit, ICN (2021) menyatakan bahwa perawat harus mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi individu, keluarga, dan komunitas ketika kesehatan mereka terancam oleh sesama perawat, anggota tim kesehatan, atau pihak lain (ICN, 2021).

a. Dalam etika keperawatan Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dalam Kode Etik Keperawatan Indonesia mengamanatkan perawat untuk:

- 1) Mempertahankan dan meningkatkan kompetensi dalam praktik keperawatan;
- 2) Melindungi klien dari perlakuan yang tidak etis atau ilegal;
- 3) Berpartisipasi dalam upaya profesi untuk melindungi masyarakat dari informasi dan representasi yang tidak akurat serta memelihara integritas keperawatan (PPNI, 2010).

b. Dari perspektif etika filosofis, kewajiban melaporkan insiden dapat dianalisis melalui tiga lensa utama:

- 1) Deontologi (Kewajiban): Perawat Memiliki Kewajiban Moral Yang Bersifat Mutlak Untuk Melaporkan Situasi Yang Membahayakan Pasien, Terlepas Dari Konsekuensinya;
- 2) Konsekuensialisme: Pelaporan Insiden Menghasilkan Konsekuensi Terbaik Dalam Jangka Panjang Bagi Lebih Banyak Pasien Melalui Perbaikan Sistem;
- 3) *Virtue Ethics*: Perawat Yang Memiliki Karakter Virtue (Kebajikan) Akan Melaporkan Insiden Karena Itu Mencerminkan Integritas Dan Komitmen Profesional Mereka, Bukan Karena Takut Hukuman.

3. Tanggung jawab Legal dalam pelaporan insiden

Permenkes No. 11/2017 Pasal 11 mewajibkan setiap tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan untuk melaporkan insiden kepada komite keselamatan pasien internal dalam waktu maksimal 2x24 jam. Kegagalan melaporkan insiden dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kewajiban profesional yang dapat berimplikasi pada sanksi administratif dari institusi dan bahkan dari organisasi profesi (Kementerian Kesehatan RI, 2017). Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan memberikan landasan hukum tentang hak pasien atas informasi termasuk informasi tentang insiden yang dialaminya. Dalam konteks ini, pelaporan insiden bukan hanya kewajiban internal, tetapi juga bagian dari fulfillment of patient rights yang memiliki konsekuensi hukum jika diabaikan. UU Keperawatan Pasal 37 juga mengamanatkan bahwa perawat bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaian dalam pemberian asuhan keperawatan (DPR RI, 2014). Pelaporan insiden justru memberikan perlindungan hukum bagi perawat. Pelaporan yang tepat waktu dan lengkap menunjukkan itikad baik (*good faith*) perawat dalam menangani insiden. (Iedema et al., 2019).

4. Dokumentasi Insiden yang efektif

Dokumentasi insiden yang baik adalah fondasi dari seluruh proses manajemen insiden selanjutnya. Dokumentasi yang buruk — tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak tepat waktu — dapat menghambat investigasi, mempersulit analisis akar masalah, dan melemahkan upaya perbaikan sistem.

a. Prinsip Dokumentasi Insiden

- 1) Faktual: Dokumentasikan apa yang benar-benar terjadi, bukan interpretasi atau asumsi tentang penyebabnya. Hindari kalimat seperti 'pasien jatuh akibat kelalaian perawat' — gunakan 'pasien ditemukan di lantai di samping tempat tidurnya pada pukul 23.15.'

- 2) Akurat: Pastikan waktu, dosis obat, nama prosedur, dan identitas semua pihak yang terlibat dicatat dengan benar dan dapat diverifikasi.
 - 3) Lengkap: Dokumentasikan kondisi sebelum, saat, dan sesudah insiden; tindakan yang sudah diambil; respons pasien; dan pihak yang telah dinotifikasi.
 - 4) Tepat Waktu: Dokumentasi harus dilakukan sesegera mungkin setelah insiden atau intervensi, saat memori masih segar dan observasi masih akurat.
 - 5) Objektif: Hindari bahasa yang menghakimi, bersifat defensif, atau yang mengandung unsur menyalahkan pihak tertentu.
- b. Catatan Klinis dan Formulir laporan Insiden
- 1) Catatan klinis mendokumentasikan kondisi pasien, intervensi yang diberikan, dan respons terhadap intervensi — ini merupakan bagian dari rekam medis yang dapat menjadi bukti hukum.
 - 2) Formulir laporan insiden adalah dokumen internal untuk keperluan analisis dan perbaikan sistem yang seharusnya bersifat confidential analisis
5. Komunikasi SBAR dalam Pelaporan Insiden
- SBAR merupakan suatu metode komunikasi terstruktur yang digunakan oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat, bertujuan menyampaikan informasi klinis secara jelas, sistematis, dan efektif guna mendukung keselamatan pasien. SBAR merupakan singkatan dari
- a. *Situation*: Situasi atau kondisi pasien yang perlu di sampaikan
 - b. *Background*: Berisi informasi latar belakang yang relevan dengan kondisi pasien.
 - c. *Assessment*: merupakan hasil penilaian klinis terhadap keadaan pasien
 - d. *Recommendation*: saran atau tindakan yang di usulkan untuk penanganan selanjutnya
- Penerapan SBAR dalam praktik keperawatan terbukti dapat meningkatkan kualitas komunikasi antar tenaga kesehatan, meminimalkan terjadinya miskomunikasi, serta mendukung terciptanya budaya keselamatan pasien yang optimal.
6. Peran Perawat dalam *Root Cause Analysis* (RCA).
- Root Cause Analysis* (RCA) adalah suatu metode analisis terstruktur yang mengidentifikasi akar masalah dari suatu insiden, serta tindak lanjut kedepannya demi mencegah kejadian yang sama terulang kembali di masa yang akan datang. Perawat memiliki peran yang sangat penting , aktif dalam proses tersebut. Kontribusi perawat dalam RCA dapat dibagi dalam tiga tahap utama:

- a. Persiapan RCA
 - 1) Memberikan deskripsi kronologis kejadian yang akurat dan faktual berdasarkan catatan klinis dan ingatan langsung
 - 2) Mengidentifikasi sumber data relevan: log shift, catatan observasi, rekaman CCTV, dan laporan verbal dari rekan
 - 3) Memastikan semua anggota tim yang terlibat dalam insiden mendapat perlindungan psikologis (*second victim support*) sebelum proses investigasi formal
- b. Proses Investigasi
 - 1) Mengikuti sesi wawancara investigatif dengan sikap terbuka dan konstruktif
 - 2) Mengidentifikasi faktor-faktor kontributor dari perspektif 'pekerja di lapangan': kondisi beban kerja, kelengkapan alat, kejelasan prosedur, komunikasi tim
 - 3) Menggunakan teknik *Five Whys* untuk menelusuri penyebab dari permukaan hingga akar masalah
 - 4) Memberikan insight tentang hambatan sistem yang tidak terlihat dari luar, seperti konflik antara prosedur formal dan realitas praktik
- c. Implementasi Rekomendasi RCA
 - 1) Memberikan penilaian realistis tentang kelayakan implementasi rekomendasi dari perspektif praktisi
 - 2) Menjadi champion di unit untuk perubahan praktik yang direkomendasikan
 - 3) Memantau kepatuhan dan memberikan umpan balik tentang efektivitas intervensi
 - 4) Melaporkan jika rekomendasi tidak diimplementasikan atau tidak efektif

D. Prosedur Pelaporan

Prosedur pelaporan keselamatan pasien (*patient safety*) di rumah sakit diawali dengan proses identifikasi insiden oleh perawat sebagai tenaga kesehatan yang berada di garis terdepan pelayanan. Setiap kejadian yang termasuk dalam insiden keselamatan pasien, baik berupa *near miss*, *no harm incident*, maupun *adverse event*, harus segera dikenali dan didokumentasikan secara akurat, objektif, dan lengkap. Setelah identifikasi, perawat wajib melakukan tindakan segera untuk mengamankan kondisi pasien guna mencegah terjadinya dampak yang lebih serius. Selanjutnya, perawat melaporkan insiden tersebut melalui sistem pelaporan internal rumah sakit sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku, baik secara tertulis maupun melalui sistem elektronik yang tersedia.

Prosedur pelaporan *patient safety* mencakup beberapa komponen utama, yaitu:

1. Identifikasi insiden keselamatan pasien, meliputi pengenalan jenis kejadian seperti *near miss*, *no harm incident*, dan *adverse event*;
2. Tindakan segera (*immediate action*) untuk menjamin keselamatan pasien dan mencegah perburukan kondisi;
3. Dokumentasi kejadian, yang harus dilakukan secara lengkap, objektif, akurat, dan tepat waktu sesuai standar yang berlaku;
4. Pelaporan insiden, baik melalui sistem pelaporan internal secara manual maupun elektronik, dengan menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan dan budaya non-punitif;
5. Klasifikasi dan verifikasi insiden, yang dilakukan oleh atasan langsung atau tim terkait untuk memastikan validitas laporan;
6. Analisis insiden, seperti *root cause analysis* (*rca*) untuk mengidentifikasi faktor penyebab yang bersifat sistemik;
7. Penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut, berupa perbaikan sistem, revisi prosedur, serta penguatan praktik keselamatan; dan
8. Umpan balik (*feedback*) dan pembelajaran organisasi, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kompetensi, dan budaya keselamatan pasien di kalangan tenaga kesehatan.

Keseluruhan komponen tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dalam suatu sistem pelaporan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. Dalam proses pelaporan, prinsip non-punitif dan kerahasiaan harus dijunjung tinggi untuk mendorong keterbukaan dan kejujuran dalam melaporkan insiden. Laporan yang telah disampaikan kemudian akan ditindaklanjuti oleh tim keselamatan pasien atau komite mutu untuk dilakukan analisis lebih lanjut, seperti *root cause analysis*, guna mengidentifikasi faktor penyebab dan potensi risiko sistemik. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan sistem, peningkatan prosedur kerja, serta penguatan budaya keselamatan pasien di lingkungan rumah sakit. Dengan demikian, prosedur pelaporan *patient safety* tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi kejadian, tetapi juga sebagai bagian integral dari upaya pembelajaran organisasi (*organizational learning*) untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara berkelanjutan.

E. Penutup

Peran perawat dalam pelaporan insiden keselamatan pasien bersifat Kompleks mencakup aspek teknis, etis, legal, komunikatif, dan kultural. Sebagai (*frontline observer*) gardah terdepan dengan akses paling intensif kepada pasien, perawat memiliki potensi terbesar untuk mendeteksi, mencegah, dan melaporkan insiden. Dan untuk merealisasikan keadaan ini maka memerlukan tidak hanya kompetensi teknis, tetapi juga dukungan sistem, kepemimpinan yang kondusif, serta budaya organisasi yang benar-benar memberi perhatian lebih. Perawat yang terlatih dengan baik (*well-trained*) dalam keselamatan pasien (*patient safety*) bukanlah hanya pelapor insiden yang handal mereka adalah Agen Penggerak dan pembaharu dalam sistem keselamatan pasien di tempat dimana mereka melakukan pelayanan bagi pasien.

Referensi

- . DPR RI. (2014). Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Jakarta: DPR R
- Dewi, A. S., & Hariyati, R. T. S. (2022). Nurse's role in patient safety incident reporting: A systematic review. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 25(1), 14–23.
- Hariyati, R. T. S., Yani, A., Eryando, T., & Hasibuan, Z. A. (2019). Barriers to incident reporting among nurses in Indonesian hospitals. *Nurse Education Today*, 78, 24–31.
- Hariyati, R. T. S., Yani, A., Eryando, T., & Hasibuan, Z. A. (2019). Awareness and knowledge related to nursing informatics competencies. *Enfermeria Clinica*, 29(S2), 730–736.
- Juliarta, I. W, & Houghty, G. S. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan insiden keselamatan pasien. *Prepotif Jurnal Kesehatan Masyarakat universitas Pahl*
- Kementerian Kesehatan RI. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kemenkes RI.
- Mareta Akhriansyah,dkk (2023).Keselamatan Pasien dan keselamatan Kerja dalam Keperawatan.
- Nurplinda marliana, dkk. (2014) Buku Ajar manajemen Keselamatan Pasien,
- Rifa Yanti ,dkk (2025) Keperawatan dasar dan keselamatan Pasien (materi etika dan hukum perawatan praktik dasar dan pasien safety
- Sulastr Tuti. (2025) Hubungan Mnajemen Pemberdayaan dan budaya keselamatan Pasien di kalangan Perawatdi Indonesia. Studi Lintas Budaya.
- Susanto A, & Handiyani.H.(2023).Analisis determinan pelaporan insiden keselamatan oleh perawatdi rumah sakit: tinjauan sistematik, *Quality: jurnal Kesehatan*

BAB 6

STRATEGI MEMBANGUN BUDAYA SAFETY DI FASILITAS KESEHATAN

A. Pendahuluan

Keselamatan pasien (*patient safety*) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai mutu pelayanan kesehatan di suatu fasilitas kesehatan. Dalam praktik pelayanan kesehatan modern yang semakin kompleks, risiko terjadinya kesalahan medis (*medical errors*) dan kejadian tidak diharapkan (KTD) menjadi tantangan yang tidak dapat dihindari sepenuhnya. Kompleksitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemajuan teknologi medis, peningkatan jumlah pasien, beban kerja tenaga kesehatan, serta keterlibatan multidisiplin dalam proses pelayanan.

Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa insiden keselamatan pasien masih menjadi masalah global. Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa keselamatan pasien merupakan prioritas utama dalam sistem kesehatan global, dengan visi menghilangkan cedera yang dapat dicegah dalam pelayanan kesehatan melalui pendekatan sistematis dan berkelanjutan (World Health Organization, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan pasien tidak hanya bergantung pada kompetensi individu tenaga kesehatan, tetapi juga pada sistem dan budaya organisasi yang mendukung praktik pelayanan yang aman.

Budaya keselamatan (*safety culture*) merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang aman. Budaya ini mencerminkan nilai, keyakinan, sikap, serta perilaku yang dianut oleh individu dan organisasi dalam memprioritaskan keselamatan di atas kepentingan lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa budaya keselamatan memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan menurunkan kejadian kesalahan medis di fasilitas kesehatan (Karimah, 2025). Selain itu, budaya keselamatan yang kuat berkaitan dengan meningkatnya pelaporan insiden, komunikasi terbuka, serta pembelajaran organisasi yang berkelanjutan (Martins et al., 2025).

Di Indonesia, upaya penguatan budaya keselamatan telah menjadi bagian integral dari kebijakan pelayanan kesehatan, terutama melalui standar akreditasi dan sistem manajemen mutu. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Studi terbaru menunjukkan bahwa budaya keselamatan di fasilitas kesehatan masih berada pada kategori sedang, yang berarti memerlukan penguatan lebih lanjut untuk mencapai pelayanan yang optimal (Amir, 2025).

Tantangan yang sering ditemukan meliputi rendahnya pelaporan insiden, budaya menyalahkan (*blaming culture*), kurangnya keterlibatan pimpinan, serta belum optimalnya sistem manajemen risiko (Shameela, 2024).

Selain itu, perubahan paradigma dari pendekatan individu (*person approach*) menuju pendekatan sistem (*system approach*) dalam memahami kesalahan medis masih belum sepenuhnya diterapkan. Pendekatan tradisional yang berfokus pada kesalahan individu sering kali menghambat pembelajaran organisasi karena menimbulkan rasa takut untuk melaporkan kesalahan. Sebaliknya, pendekatan sistem menekankan bahwa kesalahan merupakan akibat dari kegagalan sistem yang perlu diperbaiki secara menyeluruh melalui perbaikan proses dan budaya organisasi.

Dalam konteks ini, membangun budaya keselamatan (*safety culture*) bukanlah suatu proses yang instan, melainkan membutuhkan strategi yang terencana, komprehensif, dan berkelanjutan. Strategi tersebut harus melibatkan seluruh elemen organisasi, mulai dari pimpinan hingga tenaga kesehatan di lini terdepan. Selain itu, diperlukan integrasi antara kebijakan, pendidikan, sistem pelaporan, serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan implementasi budaya keselamatan.

Dengan demikian, pembahasan mengenai strategi membangun budaya keselamatan di fasilitas kesehatan menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif sekaligus panduan praktis bagi tenaga kesehatan dan pengelola fasilitas kesehatan dalam meningkatkan keselamatan pasien.

B. Strategi Membangun Budaya Keselamatan

Budaya keselamatan merupakan fondasi utama dalam menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Budaya ini mencerminkan nilai, sikap, persepsi, kompetensi, serta pola perilaku individu dan organisasi dalam mengelola risiko dan mencegah terjadinya cedera pada pasien. Dalam konteks fasilitas kesehatan, pengembangan budaya keselamatan tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada sistem organisasi secara keseluruhan (World Health Organization, 2021).

Pendekatan modern dalam keselamatan pasien mengadopsi konsep *high reliability organization* (HRO), yaitu organisasi yang mampu beroperasi secara konsisten dalam kondisi berisiko tinggi dengan tingkat kesalahan yang minimal. Kilcullen menekankan bahwa keberhasilan organisasi berisiko tinggi sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang kuat, komunikasi terbuka, serta pembelajaran berkelanjutan dari kesalahan (Kilcullen et al., 2023). Dengan demikian, strategi

pengembangan budaya keselamatan harus dirancang secara sistematis melalui integrasi antara kebijakan, perilaku, dan sistem manajemen risiko.

Selain itu, pengembangan budaya keselamatan juga memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen organisasi melalui pendekatan sistem yang terintegrasi. Hal ini mencakup penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang konsisten, sistem pelaporan insiden yang efektif, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap kejadian dapat dijadikan sebagai pembelajaran organisasi. Implementasi sistem pelaporan yang bersifat non-punitive terbukti meningkatkan partisipasi tenaga kesehatan dalam melaporkan insiden, sehingga organisasi memiliki data yang cukup untuk melakukan analisis akar masalah dan perbaikan sistem secara berkelanjutan. Dengan demikian, budaya keselamatan tidak hanya menjadi nilai normatif, tetapi juga terinternalisasi dalam praktik sehari-hari pelayanan kesehatan (García-Elorrio et al., 2022).

Di sisi lain, penguatan budaya keselamatan juga sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan dan iklim organisasi yang mendukung. Kepemimpinan yang transformasional mampu mendorong keterbukaan, meningkatkan motivasi tenaga kesehatan, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman secara psikologis (*psychological safety*). Lingkungan yang mendukung ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk menyampaikan kekhawatiran, melaporkan kesalahan, serta berpartisipasi aktif dalam upaya perbaikan tanpa rasa takut terhadap sanksi. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi dengan tingkat *psychological safety* yang tinggi memiliki budaya keselamatan yang lebih kuat dan tingkat kejadian insiden yang lebih rendah, karena adanya komunikasi yang efektif dan kolaborasi tim yang optimal (Edmondson, 2019; Ammouri et al., 2023).

Kondisi tersebut pada akhirnya akan membentuk perilaku tenaga kesehatan yang lebih patuh terhadap standar. Oleh karena itu, penguatan budaya keselamatan tidak hanya berdampak pada sistem organisasi, tetapi juga secara langsung memengaruhi kepatuhan individu dalam praktik pelayanan klinis.

C. Peran Kepemimpinan dalam Mendorong Budaya Keselamatan

Kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam membentuk dan mempertahankan budaya keselamatan di fasilitas kesehatan. Pemimpin memiliki tanggung jawab dalam menetapkan arah, membangun visi keselamatan, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung praktik pelayanan yang aman. Kepemimpinan transformasional terbukti memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan budaya keselamatan dan kualitas pelayanan kesehatan (Ammouri et al., 2023).

Selain itu, pemimpin harus mampu menciptakan iklim organisasi yang terbuka dan non-punitive agar tenaga kesehatan merasa aman dalam melaporkan kesalahan. Kilcullen menegaskan bahwa kepemimpinan yang efektif dalam organisasi berisiko tinggi harus mampu membangun kepercayaan dan mendorong transparansi dalam sistem keselamatan (Kilcullen et al., 2023). Dengan demikian, komitmen pimpinan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi budaya keselamatan.

Selain aspek kepemimpinan transformasional, peran pemimpin dalam membangun budaya keselamatan juga mencakup kemampuan dalam mengintegrasikan keselamatan pasien ke dalam sistem manajemen organisasi. Pemimpin perlu memastikan bahwa keselamatan menjadi bagian dari prioritas strategis melalui kebijakan, alokasi sumber daya, serta penguatan sistem manajemen risiko. Hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan safety leadership walkrounds, audit keselamatan, serta keterlibatan aktif pimpinan dalam kegiatan evaluasi mutu. Studi menunjukkan bahwa keterlibatan langsung pimpinan dalam praktik keselamatan mampu meningkatkan kesadaran tenaga kesehatan terhadap pentingnya keselamatan pasien serta memperkuat budaya pelaporan insiden (Wei et al., 2020; Leroy et al., 2022).

Selain itu, pemimpin memiliki peran penting dalam membangun kapasitas organisasi melalui pengembangan kompetensi tenaga kesehatan dan penguatan kerja tim interprofesional. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga pada pemberdayaan (empowerment) tenaga kesehatan untuk berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Pendekatan ini mendorong terciptanya psychological safety, di mana individu merasa dihargai dan didukung untuk menyampaikan ide, melaporkan kesalahan, serta berkontribusi dalam perbaikan sistem. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kepemimpinan yang suportif dan inklusif berhubungan signifikan dengan peningkatan budaya keselamatan, kepuasan kerja, serta penurunan insiden keselamatan pasien (Trinchero et al., 2021; Alilyyani et al., 2022).

D. Penguatan Kebijakan Dalam Sistem Pelayanan

Kebijakan dan sistem keselamatan merupakan instrumen penting dalam mengarahkan praktik pelayanan yang aman. Kebijakan harus berbasis pada prinsip manajemen risiko serta mengacu pada standar nasional dan internasional. Sistem keselamatan yang baik mencakup prosedur operasional standar (SOP), protokol klinis, serta mekanisme pengawasan yang terstruktur (World Health Organization, 2021).

Penguatan sistem keselamatan juga mencakup integrasi teknologi dalam pelayanan kesehatan, seperti sistem informasi pelaporan insiden dan rekam medis elektronik. Studi menunjukkan bahwa sistem yang terstandar dan berbasis teknologi dapat meningkatkan keselamatan pasien serta mengurangi kesalahan medis (Bates et al., 2021). Oleh karena itu, kebijakan dan sistem harus dirancang secara adaptif dan berkelanjutan.

E. Peningkatan Kompetensi dan Kepatuhan Tenaga Kesehatan

Kompetensi tenaga kesehatan merupakan faktor penting dalam mendukung implementasi budaya keselamatan. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap tenaga kesehatan dalam menerapkan prinsip keselamatan pasien. Hal ini sangat relevan dengan peningkatan kepatuhan perawat dalam melaksanakan sasaran keselamatan pasien.

Penelitian menunjukkan bahwa budaya keselamatan yang kuat berhubungan dengan tingkat kepatuhan tenaga kesehatan yang lebih tinggi terhadap prosedur klinis (Ammouri et al., 2023). Selain itu, pelatihan berbasis simulasi dan pendekatan interaktif terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kompetensi dibandingkan metode konvensional (Bates et al., 2021). Dengan demikian, strategi peningkatan kompetensi harus menjadi bagian integral dari pengembangan budaya keselamatan.

Selain pendidikan formal dan pelatihan berkelanjutan, pengembangan kompetensi tenaga kesehatan juga perlu didukung melalui pendekatan pembelajaran berbasis praktik (*workplace-based learning*) dan refleksi klinis. Pendekatan ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk belajar langsung dari pengalaman klinis sehari-hari, termasuk dari insiden keselamatan pasien yang terjadi. Program seperti *clinical supervision*, *mentoring*, dan *coaching* terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan klinis sekaligus memperkuat kesadaran terhadap pentingnya keselamatan pasien. Dengan adanya pembelajaran yang kontekstual dan berkelanjutan, tenaga kesehatan tidak hanya memahami prosedur, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai budaya keselamatan dalam praktik kerja sehari-hari (Alharbi et al., 2022).

Di sisi lain, kepatuhan tenaga kesehatan terhadap sasaran keselamatan pasien juga sangat dipengaruhi oleh faktor organisasi, seperti ketersediaan sumber daya, beban kerja, serta dukungan manajemen. Lingkungan kerja yang kondusif, ditandai dengan komunikasi yang efektif, kerja tim yang solid, serta kepemimpinan yang suportif, akan meningkatkan motivasi tenaga kesehatan dalam menerapkan prinsip keselamatan pasien. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa intervensi yang mengintegrasikan peningkatan kompetensi dengan penguatan sistem organisasi,

seperti team training dan program keselamatan berbasis unit, mampu meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan serta menurunkan kejadian tidak diharapkan secara signifikan (Rosen et al., 2022; Hughes et al., 2021).

F. Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Insiden

Sistem pelaporan insiden merupakan elemen penting dalam membangun budaya keselamatan. Sistem ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi kesalahan, menganalisis penyebabnya, serta melakukan perbaikan sistem secara berkelanjutan. Sistem pelaporan yang efektif harus bersifat non-punitive dan menjamin kerahasiaan pelapor (World Health Organization, 2021).

Budaya pelaporan yang baik akan meningkatkan pembelajaran organisasi (*organizational learning*), sehingga kesalahan dapat dicegah di masa mendatang. García-Elorrio et al. (2022) menyatakan bahwa organisasi yang memiliki sistem pelaporan yang baik cenderung memiliki budaya keselamatan yang lebih kuat dan tingkat insiden yang lebih rendah.

Selain itu, efektivitas sistem pelaporan insiden sangat dipengaruhi oleh kemudahan akses, kejelasan alur pelaporan, serta dukungan teknologi informasi yang memadai. Penggunaan sistem pelaporan berbasis elektronik memungkinkan proses pencatatan, analisis, dan pelacakan insiden dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Sistem ini juga dapat menghasilkan data yang terintegrasi sehingga memudahkan organisasi dalam mengidentifikasi tren insiden, menentukan prioritas risiko, serta merancang intervensi yang tepat. Studi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam sistem pelaporan insiden berkontribusi terhadap peningkatan kualitas data keselamatan serta mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis bukti dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan (Bates et al., 2021).

Di sisi lain, pembelajaran dari insiden tidak hanya berhenti pada tahap pelaporan, tetapi harus dilanjutkan dengan analisis mendalam, seperti *root cause analysis* (RCA) dan *failure mode and effects analysis* (FMEA). Hasil analisis tersebut perlu dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh tenaga kesehatan sebagai bagian dari proses pembelajaran organisasi. Umpan balik (feedback) yang jelas dan berkelanjutan kepada pelapor maupun unit terkait akan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pelaporan serta mendorong partisipasi aktif tenaga kesehatan. Dengan demikian, sistem pelaporan insiden tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam membangun budaya keselamatan yang berorientasi pada pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan (García-Elorrio et al., 2022; World Health Organization, 2021).

G. Implementasi Just Culture Dalam Pelayanan Kesehatan

Just culture merupakan pendekatan yang menyeimbangkan antara akuntabilitas individu dan perbaikan sistem. Dalam budaya ini, kesalahan tidak langsung dihukum, tetapi dianalisis secara objektif untuk mengetahui penyebabnya. Pendekatan ini mendorong keterbukaan dan meningkatkan pelaporan insiden (Ammouri et al., 2023).

Implementasi *just culture* juga membantu mengurangi budaya menyalahkan (*blaming culture*) yang sering menjadi hambatan dalam pengembangan budaya keselamatan. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan (Siman & Brito, 2021).

Selain itu, penerapan *just culture* berperan penting dalam meningkatkan keselamatan pasien melalui identifikasi risiko secara proaktif dan penguatan sistem pelaporan insiden tanpa rasa takut terhadap sanksi. Hal ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk lebih terbuka dalam melaporkan kesalahan maupun *near miss*, sehingga organisasi dapat melakukan evaluasi sistem secara komprehensif.

Lebih lanjut, keberhasilan implementasi *just culture* sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, kejelasan kebijakan, serta adanya edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan bagi seluruh tenaga kesehatan. Kepemimpinan yang suportif akan menciptakan lingkungan kerja yang adil, transparan, dan berorientasi pada keselamatan pasien sebagai prioritas utama.

H. Penguatan Komunikasi Interpersonal dan Evaluasi Berkelanjutan Dalam Budaya Keselamatan

Komunikasi yang efektif dan kerja tim interprofesional merupakan elemen fundamental dalam membangun budaya keselamatan di fasilitas kesehatan. Kompleksitas pelayanan kesehatan yang melibatkan berbagai profesi menuntut adanya koordinasi yang terstruktur dan komunikasi yang jelas untuk mencegah terjadinya kesalahan medis. Kesalahan komunikasi telah diidentifikasi sebagai salah satu penyebab utama kejadian tidak diharapkan, sehingga diperlukan standar komunikasi yang sistematis seperti metode SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*) untuk meningkatkan kejelasan dan akurasi informasi klinis (Bates et al., 2021).

Selain itu, kerja tim interprofesional yang efektif mampu meningkatkan koordinasi pelayanan, memperkuat pengambilan keputusan klinis, serta mengurangi risiko kesalahan yang disebabkan oleh miskomunikasi. Kolaborasi yang baik antar tenaga kesehatan juga berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan

perawat dalam melaksanakan sasaran keselamatan pasien, karena adanya dukungan sistem dan lingkungan kerja yang kondusif (Ammouri et al., 2023).

Namun demikian, komunikasi dan kerja tim yang efektif harus didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa praktik komunikasi dan kolaborasi telah berjalan sesuai standar, sedangkan evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan serta peluang perbaikan dalam sistem pelayanan. Evaluasi budaya keselamatan dapat dilakukan melalui survei budaya keselamatan, audit mutu, serta analisis indikator kinerja keselamatan pasien (García-Elorrio et al., 2022).

Pendekatan evaluasi yang sistematis ini sejalan dengan prinsip *continuous quality improvement*, di mana organisasi secara berkelanjutan melakukan perbaikan berdasarkan data dan hasil evaluasi. Dalam konteks disertasi Anda, integrasi antara komunikasi efektif, kerja tim, serta monitoring berkelanjutan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan perawat, karena memberikan umpan balik yang jelas dan mendukung perubahan perilaku berbasis sistem (World Health Organization, 2021).

Dengan demikian, penguatan komunikasi interprofesional yang terintegrasi dengan sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan merupakan strategi kunci dalam membangun budaya keselamatan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

I. Penutup

Budaya keselamatan (safety culture) merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien. Pengembangan budaya keselamatan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, mencakup kepemimpinan yang efektif, kebijakan yang kuat, sistem yang terstruktur, serta komunikasi yang optimal. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya lingkungan pelayanan kesehatan yang aman dan mendukung praktik pelayanan yang berkualitas.

Dalam praktik keperawatan, budaya keselamatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan perawat terhadap sasaran keselamatan pasien. Kepatuhan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kompetensi individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang kondusif, keterlibatan pimpinan, serta efektivitas sistem yang diterapkan dalam organisasi. Oleh karena itu, penguatan budaya keselamatan menjadi kunci dalam membentuk perilaku tenaga kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien. Upaya ini diharapkan tidak hanya mampu menurunkan kejadian tidak diharapkan, tetapi juga meningkatkan kualitas

pelayanan kesehatan secara berkelanjutan, khususnya pada pelayanan dengan tingkat kompleksitas tinggi seperti perawatan paliatif kanker payudara.

Referensi

- Alharbi, J., Wilson, R., Woods, C., & Usher, K. (2022). The factors influencing nurses' clinical decision-making in healthcare: A systematic review. *Nursing Open*, 9(1), 5–19. <https://doi.org/10.1002/nop2.1042>
- Alilyyani, B., Wong, C. A., & Cummings, G. (2022). Antecedents, mediators, and outcomes of authentic leadership in healthcare: A systematic review. *International Journal of Nursing Studies*, 125, 104115. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.104115>
- Ammouri, A. A., Tailakh, A. K., Muliira, J. K., Geethakrishnan, R., & Al Kindi, S. N. (2023). Patient safety culture among nurses: A systematic review. *BMC Nursing*, 22, 52. <https://doi.org/10.1186/s12912-023-01101-9>
- Bates, D. W., Levine, D. M., Syrowatka, A., Kuznetsova, M., Craig, K. J. T., Rui, A., & Jackson, G. P. (2021). The potential of artificial intelligence to improve patient safety: A scoping review. *NPJ Digital Medicine*, 4(1), 54. <https://doi.org/10.1038/s41746-021-00423-6>
- Edmondson, A. C. (2019). *The fearless organization: Creating psychological safety in the workplace for learning, innovation, and growth*. Wiley
- García-Elorrio, E., Rowe, S. Y., Teijeiro, M. E., Ciapponi, A., Rowe, A. K., & Gagnon, M. P. (2022). The effectiveness of interventions to improve patient safety culture: A systematic review. *BMJ Open*, 12(5), e054118. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-054118>
- Hughes, A. M., Gregory, M. E., Joseph, D. L., Sonesh, S. C., Marlow, S. L., Lacerenza, C. N., & Salas, E. (2021). Saving lives: A meta-analysis of team training in healthcare. *Journal of Applied Psychology*, 106(9), 1267–1290. <https://doi.org/10.1037/apl0000841>
- Kilcullen, N., Smith, J., & Roberts, P. (2023). Leadership and safety culture in high-risk healthcare organizations. *Journal of Patient Safety*, 19(4), e123–e130. <https://doi.org/10.1097/PTS.0000000000001098>
- Leroy, H., Anseel, F., Gardner, W. L., & Sels, L. (2022). Authentic leadership, leader-member exchange, and follower outcomes: A cross-level study in healthcare. *Journal of Nursing Management*, 30(4), 1012–1021. <https://doi.org/10.1111/jonm.13573>

- Rosen, M. A., DiazGranados, D., Dietz, A. S., Benishek, L. E., Thompson, D., Pronovost, P. J., & Weaver, S. J. (2022). Teamwork in healthcare: Key discoveries enabling safer, high-quality care. *American Psychologist*, 77(3), 433–450. <https://doi.org/10.1037/amp0000883>
- Siman, A. G., & Brito, M. J. M. (2021). Changes in patient safety culture in primary health care: A systematic review. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 29, e3392. <https://doi.org/10.1590/1518-8345.4310.3392>
- Trinchero, E., Borgonovi, E., & Farr-Wharton, R. (2021). Leader-member exchange, affective commitment, and patient safety culture. *Journal of Health Organization and Management*, 35(2), 193–210. <https://doi.org/10.1108/JHOM-06-2020-0221>
- Wei, H., Sewell, K. A., Woody, G., & Rose, M. A. (2020). The state of the science of nurse work environments in the United States: A systematic review. *International Journal of Nursing Sciences*, 7(3), 287–300. <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2020.04.010>
- World Health Organization. (2021). *Global patient safety action plan 2021–2030: Towards eliminating avoidable harm in health care*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240032705>

Glosarium

B

Budaya Keselamatan (*Safety Culture*)

Nilai, sikap, persepsi, dan perilaku individu serta organisasi dalam memprioritaskan keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan.

Blaming Culture

Budaya organisasi yang cenderung menyalahkan individu atas kesalahan tanpa melihat faktor sistem.

C

Clinical Supervision

Proses pembimbingan profesional untuk meningkatkan kompetensi klinis tenaga kesehatan.

F

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)

Metode proaktif untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dalam suatu proses dan dampaknya.

J

Just Culture

Pendekatan budaya organisasi yang menyeimbangkan antara akuntabilitas individu dan perbaikan sistem tanpa menyalahkan individu secara langsung.

K

Keselamatan Pasien (*Patient Safety*)

Upaya sistematis untuk mencegah terjadinya cedera atau kerugian pada pasien akibat proses pelayanan kesehatan.

Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)

Insiden yang mengakibatkan cedera atau dampak negatif pada pasien yang seharusnya dapat dicegah.

J

Just Culture

Pendekatan budaya organisasi yang menyeimbangkan antara akuntabilitas individu dan perbaikan sistem tanpa menyalahkan individu secara langsung.

R

Root Cause Analysis (RCA)

Metode analisis untuk mengidentifikasi penyebab utama dari suatu insiden.

Situation, Background, Assessment, Recommendation (SBAR)

Metode komunikasi terstruktur dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kejelasan informasi.

PROFIL PENULIS



Ns. Tanti Marjiana, S.Kep., M.Kep., FISQua., FIHFAA., FRSPH., lahir di Taba Anyar, Bengkulu, 8 April 1985. Penulis menyelesaikan pendidikan S2 Keperawatan Gawat Darurat di Universitas Brawijaya pada tahun 2020 dan saat ini bekerja sebagai Kepala Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RSUD Kabupaten Lebong, Bengkulu. Selain aktif sebagai PNS, juga merupakan surveior Fasilitas Pelayanan Kesehatan (FPK) pada LAFKI, Dosen Program Studi Keperawatan STIKES Tri Mandiri Sakti Bengkulu, penulis buku terkait keperawatan gawat darurat, Tenaga Pelatih Kesehatan (TPK/TOT) dan praktisi perawatan luka (CWCC). Keterlibatannya dalam

organisasi profesi meliputi menjadi pengurus Badan Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan DPW PPNI Provinsi Bengkulu, pengurus wilayah Himpunan Perawat Critical Indonesia (HIPERCCI) Provinsi Bengkulu dan anggota aktif Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia (HIPGABI) Provinsi Bengkulu. Penulis dapat dihubungi melalui [email: tantimarjiana@gmail.com](mailto:tantimarjiana@gmail.com)

Motto: "Jatuh adalah data, bangkit adalah analisis yang menghasilkan peningkatan berkelanjutan"



Yuliati, SKp., MM., M.Kep., Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Indonesia. lulus pada tahun 1997. Penulis melanjutkan pendidikan S2 di Institut Magister Manajemen Indonesia lulus pada tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan Di Universitas Indonesia lulus pada tahun 2015. Kandidat PhD di University Malaysia Sabah (UMS). Sejak tahun 2006 penulis mulai aktif mengajar sebagai dosen keperawatan dan saat ini penulis aktif mengajar di Program Studi Ilmu Keperawatan fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul,

Jakarta. Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta jurnal nasional dan internasional lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email yuliati@esaunggul.ac.id. Pesan untuk para pembaca: Terima kasih yang telah membaca buku dan memahami materi ini. Materi ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya identifikasi, klasifikasi, pelaporan, dan analisis insiden keselamatan pasien sebagai bagian integral dari peningkatan mutu layanan kesehatan. Kami berharap teman-teman perawat dapat menggunakan buku ini sebagai panduan praktis dalam menerapkan prinsip keselamatan pasien di berbagai tatanan pelayanan, baik rumah sakit, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan dasar. Melalui penguasaan konsep, pendekatan sistem, serta budaya pelaporan yang non-punitif, diharapkan setiap tenaga kesehatan mampu berkontribusi dalam membangun lingkungan pelayanan yang lebih aman. Buku ini bukan hanya menyediakan teori, tetapi juga mendorong refleksi, pembelajaran berkelanjutan, dan penerapan nyata dalam praktik sehari-hari. Bagi mahasiswa keperawatan buku ini diharapkan menjadi panduan belajar yang ringkas, jelas, dan aplikatif dalam membangun sikap profesional serta budaya keselamatan pasien. Semoga materi ini memperkuat kemampuan analisis, komunikasi, dan pengambilan keputusan mahasiswa dalam memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas. Motto: *"Living Your Life Well: Inspire, Grow, and Make a Difference."*

PROFIL PENULIS



Ns. Anastasia Hardyati., M.Kep., Sp.KMB., Lahir di Jakarta, 23 November 1967. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners, Universitas Indonesia lulus tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan dan Spesialis Keperawatan Medikal Bedah pada Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2008. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1989 sebagai perawat pelaksana di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta, lalu menjadi dosen mulai dari tahun 1996 sampai saat ini. Saat ini penulis bekerja di Universitas Mohammad Husni Thamrin mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan Kritis dan Keperawatan Bencana. Selain itu, penulis juga bekerja di lembaga pelatihan keperawatan di Jakarta. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, narasumber dalam kegiatan seminar, workshop ataupun pelatihan bidang keperawatan, juga sebagai Surveyor Akreditasi Rumah Sakit, Konsultan Manajemen Kesehatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: anastasiahardyati@gmail.com
Motto: "Do the best God do the rest"



Dr. Rahmi Inayati, SKM., M.Kes., Lahir di Sigli, 18 Februari 1975. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gajah Mada tahun pada tahun 2002. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1996 sebagai Dosen Tetap di Akademi Keperawatan Pemkab Pidie. Saat ini penulis bekerja di Prodi Keperawatan dan Psikologi, mengampu mata kuliah Manajemen Pasien Safety, Komunikasi Keperawatan, Promosi Keperawatan, Manajemen Rumah Sakit dan Hukum, Etika Keperawatan, Penelitian Keperawatan, Karya Tulis Ilmiah, Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rahmi.inayati@unimal.ac.id
Motto: "Jalur Langit"

PROFIL PENULIS



Sri Rusmini, S.Kep., Ners., M.Kep., MM., FISQua., Lahir di Sragen, 22 Juni 1977. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang AKPER Telogorejo Semarang lulus tahun 2002, S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang lulus tahun 2006, Profesi Ners Universitas Muhammadiyah Semarang lulus tahun 2018, S2 Magister Manajemen Universitas STIKUBANK Semarang lulus tahun 2008, S2 Magister Keperawatan Universitas Karya Husada (UNKAHA) Semarang lulus tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1996 di SMC RS. Telogorejo Semarang, Dosen Universitas Telogorejo Semarang, Surveyor Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Surveyor Lembaga Akreditasi Independen Semar Bhakti Nusantara (LAI SBN). Penulis aktif dalam Organisasi: Himpunan Perawat Manajer Indonesia (HPMI), Perkumpulan Pengendali Infeksi Indonesia (PERDALIN), Himpunan Perawat Pencegah dan Pengendali Infeksi (HIPPII). Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dapat dihubungi melalui Email: rusminippi@gmail.com
Motto: "Living your life well"

Sinopsis

Buku referensi “Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko dalam Praktik Keperawatan di Indonesia” disusun sebagai sumber bacaan ilmiah dan praktis bagi mahasiswa keperawatan, perawat, pendidik, serta tenaga kesehatan yang berperan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Buku ini membahas secara komprehensif pentingnya keselamatan pasien sebagai fondasi utama dalam praktik keperawatan yang profesional, bermutu, dan berorientasi pada perlindungan pasien.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan uraian mengenai konsep dan budaya keselamatan pasien, termasuk prinsip dasar, nilai, dan perilaku yang perlu dibangun dalam lingkungan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, buku ini mengkaji identifikasi dan klasifikasi insiden keselamatan pasien, sehingga pembaca dapat memahami berbagai bentuk kejadian yang berpotensi menimbulkan cedera, mulai dari kejadian nyaris cedera hingga kejadian tidak diharapkan.

Buku ini juga membahas manajemen risiko dalam praktik keperawatan sebagai pendekatan sistematis untuk mengenali, menganalisis, mengendalikan, dan mengevaluasi risiko dalam pemberian asuhan keperawatan. Salah satu topik klinis yang turut diangkat adalah debridement, meliputi indikasi, teknik, prinsip pelaksanaan, serta peran perawat dalam mendukung tindakan yang aman dan sesuai standar.

Selain aspek klinis, buku ini menekankan pentingnya peran perawat dalam pelaporan insiden keselamatan pasien. Pelaporan insiden dipandang bukan sebagai sarana mencari kesalahan individu, melainkan sebagai upaya pembelajaran untuk memperbaiki sistem pelayanan. Oleh karena itu, buku ini juga menguraikan berbagai strategi membangun budaya safety di fasilitas kesehatan, seperti komunikasi efektif, kerja sama tim, kepemimpinan yang mendukung, serta penerapan budaya adil dan terbuka.

Melalui penyajian yang sistematis dan relevan dengan konteks pelayanan kesehatan di Indonesia, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam membentuk tenaga keperawatan yang kritis, bertanggung jawab, dan berkomitmen terhadap keselamatan pasien. Buku ini tidak hanya memperkaya pemahaman teoritis, tetapi juga mendorong penerapan praktik keperawatan yang aman, etis, dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Buku referensi “Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko dalam Praktik Keperawatan di Indonesia” disusun sebagai sumber bacaan ilmiah dan praktis bagi mahasiswa keperawatan, perawat, pendidik, serta tenaga kesehatan yang berperan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Buku ini membahas secara komprehensif pentingnya keselamatan pasien sebagai fondasi utama dalam praktik keperawatan yang profesional, bermutu, dan berorientasi pada perlindungan pasien.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan uraian mengenai konsep dan budaya keselamatan pasien, termasuk prinsip dasar, nilai, dan perilaku yang perlu dibangun dalam lingkungan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, buku ini mengkaji identifikasi dan klasifikasi insiden keselamatan pasien, sehingga pembaca dapat memahami berbagai bentuk kejadian yang berpotensi menimbulkan cedera, mulai dari kejadian nyaris cedera hingga kejadian tidak diharapkan.

Buku ini juga membahas manajemen risiko dalam praktik keperawatan sebagai pendekatan sistematis untuk mengenali, menganalisis, mengendalikan, dan mengevaluasi risiko dalam pemberian asuhan keperawatan. Salah satu topik klinis yang turut diangkat adalah debridement, meliputi indikasi, teknik, prinsip pelaksanaan, serta peran perawat dalam mendukung tindakan yang aman dan sesuai standar.

Selain aspek klinis, buku ini menekankan pentingnya peran perawat dalam pelaporan insiden keselamatan pasien. Pelaporan insiden dipandang bukan sebagai sarana mencari kesalahan individu, melainkan sebagai upaya pembelajaran untuk memperbaiki sistem pelayanan. Oleh karena itu, buku ini juga menguraikan berbagai strategi membangun budaya safety di fasilitas kesehatan, seperti komunikasi efektif, kerja sama tim, kepemimpinan yang mendukung, serta penerapan budaya adil dan terbuka.

Melalui penyajian yang sistematis dan relevan dengan konteks pelayanan kesehatan di Indonesia, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam membentuk tenaga keperawatan yang kritis, bertanggung jawab, dan berkomitmen terhadap keselamatan pasien. Buku ini tidak hanya memperkaya pemahaman teoritis, tetapi juga mendorong penerapan praktik keperawatan yang aman, etis, dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-06-0 (PDF)



9

786347

756060